**Чирчиқ шаҳар «Инсон»
ижтимоий хизматлар маркази**

ИЖТИМОИЙ ХОДИМЛАР УЧУН

ИЗОҲЛИ ЛУҒАТ-ҚЎЛЛАНМА

Тиббий атамалар ва касалликларнинг изоҳли луғати

Ногиронлик, парвариш ва реабилитация ишида кўп учрайдиган касалликлар, МКБ-10 кодлари ва техник воситаларнинг содда изоҳи

«Тиббий билим ва ижтимоий меҳр — инсон қадри йўлида»

Тузувчи
Ж.А.Туйчиев
Чирчиқ шаҳар "Инсон" ижтимоий хизматлар маркази супервайзери

Чирчиқ - 2026-йил

УШБУ ҚЎЛЛАНМА ҲАҚИДА

Қўлланманинг аҳамияти. Ижтимоий соҳа тиббиёт билан чамбарчас боғлиқ. Ижтимоий ходимлар ногиронлиги бор, кекса ёки сурункали касалликка чалинган, парваришга муҳтож кишилар билан ишлаганда ҳар куни тиббий атамалар ва касалликлар номига дуч келади: улар шифокор хулосаларида, ТИЭК ва ПТПК ҳужжатларида, реабилитация дастурларида учрайди. Бу атамаларнинг номи ва мазмунини тушунмаслик мижозга тўғри ёрдам беришга ва ҳужжатларни тўғри расмийлаштиришга халақит беради.

Қўлланманинг мақсади. Ушбу қўлланма айнан шу эҳтиёж учун тайёрланган. У тиббий маълумоти бўлмаган мутахассисга тиббий ҳужжатларда учрайдиган атама, касаллик ва реабилитация воситаларининг номи ва мазмунини тушунарли тилда тушунтиради ҳамда мижоз билан ишлашда нимага эътибор бериш кераклигини тез англаб олишга ёрдам беради.

Кимлар учун мўлжалланган. Қўлланма ижтимоий хизматлар марказлари ижтимоий ходимлари, супервайзерлар, уйда ижтимоий хизмат кўрсатувчи ходимлар ҳамда ногиронлиги бор ва парваришга муҳтож шахслар билан ишловчи бошқа мутахассислар учун мўлжалланган.

Тузилиши. Луғат уч бўлимдан иборат: I — касалликлар, синдромлар ва ҳолатлар (МКБ-10 коди билан); II — тиббий ва ижтимоий-тиббий атамалар; III — протез-ортопедия мосламалари ва реабилитациянинг техник воситалари. Ҳар бир бўлим ичида бандлар кирилл алифбоси тартибида жойлаштирилган.

Банд тузилиши. Ҳар бир бандда атама (касалликлар учун МКБ-10 коди билан), унинг содда мазмуни ҳамда ижтимоий ходим амалиёти учун аҳамияти берилган.

Муҳим эслатма. Луғат тиббий маълумот берувчи қўлланма эмас ва шифокор ташхиси ёки даволашини алмаштирмайди. Мижоз соғлиғига оид ҳар қандай қарорни шифокор билан келишиш лозим. Шошилинч ҳолатларда дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг.

ТУЗУВЧИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ

Тузувчи: Ж.А.Туйчиев
Лавозими: Чирчиқ шаҳар "Инсон" ижтимоий хизматлар маркази супервайзери
Нашр жойи ва йили: Чирчиқ, 2026-йил

МУНДАРИЖА

Ушбу қўлланма ҳақида ва тузувчи маълумоти 2

I. КАСАЛЛИКЛАР, СИНДРОМЛАР ВА ҲОЛАТЛАР 4

А 4 · Б 14 · В 18 · Г 19 · Д 25 · Е 29 · Ё 30 · Ж 30 · З 31 · И 32 · К 33 · Л 40 · М 41 · Н 47 · О 51 · П 56 · Р 62 · С 64 · Т 70 · У 76 · Ф 77 · Х 78 · Ц 79 · Ч 79 · Ш 80 · Э 81 · Ю 83 · Ў 84 · Қ 84 · Ғ 87 · Ҳ 87

II. ТИББИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-ТИББИЙ АТАМАЛАР 88

А 88 · Б 90 · В 91 · Г 92 · Д 94 · Ж 96 · З 97 · И 97 · Й 98 · К 98 · Л 101 · М 102 · Н 104 · О 106 · П 107 · Р 110 · С 112 · Т 114 · У 116 · Ф 117 · Х 118 · Ц 119 · Ч 119 · Ш 119 · Э 119 · Я 121 · Ў 121 · Қ 122 · Ҳ 122 · Лотин ҳарфлилар 122

III. ПРОТЕЗ-ОРТОПЕДИЯ МОСЛАМАЛАРИ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯНИНГ ТЕХНИК ВОСИТАЛАРИ 124

А 124 · Б 125 · Е 128 · К 128 · М 131 · Н 132 · О 132 · П 133 · Р 133 · С 134 · Т 134 · Ф 136 · Ч 136 · Э 136 · Ю 137 · Ў 137 · Қ 137 · Ҳ 138 · Лотин ҳарфлилар 138

ФОЙДАЛАНИЛГАН МАНБАЛАР 139

Жами 651 банд: I бўлим — 403, II бўлим — 175, III бўлим — 73.

I. КАСАЛЛИКЛАР, СИНДРОМЛАР ВА ҲОЛАТЛАР

Касалликлар МКБ-10 коди билан берилган.

A

1. Агрессия (тажовузкорлик) (МКБ-10: R45.6)

Мазмуни: Ўзгаларга ёки ўзига нисбатан ҳақорат, бақириш, уриш ёки буюм синдириш каби қўпол хатти-ҳаракатлар. Алоҳида касаллик эмас, деменция, руҳий касаллик, стресс ёки оғриқ белгиси.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга қарши чиқмасдан, паст ва хотиржам овозда гаплашинг, хавфсиз масофада туринг. Сабабини аниқлаш учун шифокорга йўлланг; хавф жиддий бўлса, ёрдам чақиринг.

2. Адиссон касаллиги (МКБ-10: E27.1)

Мазмуни: Буйрак усти безлари гормонни етарли ишлаб чиқара олмайдиган оғир сурункали касаллик: ҳолсизлик, озиш, паст қон босими, терининг қорайиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бемор гормон дорисини умр бўйи узлуксиз ичиши шарт; дорини ташлаш хавфли. Дори билан таъминланишига ва шифокор назоратига ёрдам беринг, касаллик ёки стрессда аҳвол ёмонлашишини оилага тушунтиринг.

3. Адиссон кризи (МКБ-10: E27.2)

Мазмуни: Адиссон касаллигида тўсатдан пайдо бўладиган оғир ҳолат: кучли ҳолсизлик, қайт, қорин оғриғи, қон босимининг кескин тушиши, ҳушдан кетиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ҳаёт учун хавфли ҳолат: дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг ва мижознинг касаллигини айтинг. Дориларни вақтида ичиши ва касал бўлганда шифокорга мурожаат қилишини назорат қилинг.

4. Ажитация (руҳий безовталик) (МКБ-10: R45.1)

Мазмуни: Кучли ҳаяжон, ваҳима ва тинч туролмаслик ҳолати: одам у ёқдан бу ёққа юради, қўлларини ушлаб ўтиради, бақиради ёки мақсадсиз ҳаракатлар қилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Шовқинни камайтиринг, мижозни тинч жойга ўтказинг, қистаманг. Безовталик деменция, руҳий касаллик, оғриқ ёки дори таъсирида бўлиши мумкин, шифокорга йўлланг.

5. Азбестоз (МКБ-10: J61)

Мазмуни: Азбест чангини узоқ вақт нафас олиш натижасида ўпканинг чандиқланиши. Касб касаллиги ҳисобланади, нафас қисилиши ва йўталга олиб келади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касб касаллиги билан касалланган шахс меҳнат лаёқатини йўқотиш даражасини аниқлаш учун ТИЭКга йўналтирилиши мумкин. Мижознинг ишлаган жойи ва иш стажи ҳақидаги ҳужжатларини йиғишга ёрдам беринг.

6. Аккомодация фалажи (МКБ-10: H52.5)

Мазмуни: Кўз гавҳарининг яқин ва узоқдаги нарсаларга фокусланиш қобилияти йўқолиши (кўз мушаги фалажи оқибатида). Одам, айниқса яқиндаги ёзувларни, ноаниқ кўради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ўқиш, ёзиш ва ҳужжатларни тўлдиришда қийналиши мумкин. Катта ҳарфли матнлардан фойдаланинг, кўз шифокорига мурожаат қилишга ёрдам беринг.

7. Алалия (нутқ ривожланишининг бузилиши: экспрессив, рецептив) (МКБ-10: F80.1; F80.2)

Мазмуни: Эшитиши ва ақли соғлом болада мия нутқ марказлари шикастланиши сабабли нутқ ривожланмаслиги: бола ё гапира олмайди (экспрессив), ё маъносини тушунмайди (рецептив).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола ва оилани логопед, дефектолог ва психоневролог билан таништиринг, эрта аралашув хизматига йўналтиринг. Ота-оналарга болага тушунарли ва содда қилиб гапиришни тушунтиринг.

8. Алаҳлашли (шизотипик) бузилишлар (МКБ-10: F21–F29)

Мазмуни: Шизофрения гуруҳига яқин руҳий касалликлар: одамда асоссиз гумон, ғалати ишонч (масалан, уни кузатишяпти деган фикр) ва алаҳлашлар пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижознинг гапларига қарши чиқманг ва уни ишонтиришга уринманг, лекин унинг қўрқувини тушунишингизни билдиринг. Психиатр кузатуви ва дориларнинг доимий қабули муҳим, оилани ушбу касаллик ҳақида хабардор қилинг.

9. Алкоголизм (спиртли ичимликка қарамлик) (МКБ-10: F10.2)

Мазмуни: Спиртли ичимликсиз яшай олмаслик, ичишни тўхтата олмаслик ва вақт ўтиши билан организмнинг шикастланиши билан кечадиган касаллик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни айбламай, касаллик сифатида қабул қилинг. Наркология хизмати ҳақида маълумот беринг, оилани (болалар, зўравонлик хавфи) ўрганинг. Даволанишни шифокор назоратида ўтказиш керак.

10. Аллергик ринит (МКБ-10: J30)

Мазмуни: Чанг, ўсимлик гули, ҳайвон жуни каби аллергенларга бурун шиллиқ қаватининг реакцияси: бурун битиши, бурундан сувсимон суюқлик оқиши, тез-тез акса уриш, кўз қичиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик юқумли эмас, лекин кундалик ҳаётни қийинлаштиради. Аллергенни аниқлаш ва ундан узоқ юришга ёрдам беринг, уй шароитини ҳисобга олинг.

11. Аллергия (аллергик реакция) (МКБ-10: T78.4)

Мазмуни: Организмнинг безарар моддага (дори, озиқ-овқат, чанг, ари заҳри) ортиқча жавоб бериши: тошма, қичиш, шиш, нафас қийинлашуви.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижознинг нимага аллергияси борлигини аниқлаб, ҳужжатларда белгиланг ва шу моддалардан сақланинг. Нафас қийинлашса ёки бет-лаб шишса, дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг.

12. Альбинизм (МКБ-10: E70.3)

Мазмуни: Тана рангини берувчи модда (пигмент)нинг туғма етишмаслиги. Тери, соч ва кўзлар оч рангда бўлади, кўриш заифлашади, тери қуёшдан тез куяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўриш пасайиши ногиронлик белгилашга асос бўлиши мумкин. Қуёшдан ҳимояланиш ва кўз шифокори назоратига ёрдам беринг; мактабда болага қулайлик яратилишини таъминланг.

13. Альцгеймер касаллиги (МКБ-10: G30; F00)

Мазмуни: Бош мия ҳужайралари аста-секин нобуд бўлиб, хотира, фикрлаш ва ўзини эплаш қобилияти йўқолади. Кексаларда деменциянинг энг кўп учрайдиган сабаби.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз яқинларини танимай қолиши мумкин; уни айбламанг ва тузатишга уринманг. Хавфсизликни (газ, эшик, адашиш) таъминланг, тартибни ўзгартирманг, оила билан парвариш режасини тузинг.

14. Амавроз (тўлиқ кўрлик) (МКБ-10: H54.0)

Мазмуни: Кўзнинг ёруғликни ҳам сезмаслиги, яъни тўлиқ кўрлик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ТИЭК орқали ногиронлик (одатда I гуруҳ) белгиланади; ҳасса, Брайл мосламаси каби воситалар берилади. Ҳужжатларни овоз чиқариб ўқиб беринг, хонада буюмлар жойини ўзгартирманг.

15. Амиелия (орқа миянинг туғма йўқлиги) (МКБ-10: Q06.0)

Мазмуни: Бола орқа мияси бутунлай шаклланмасдан туғилиши. Жуда оғир туғма нуқсон.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай ҳолат одатда ҳаёт билан мос келмайди, оилага чуқур руҳий ёрдам керак. Ота-оналарга психологик қўллаб-қувватлаш хизматини таклиф қилинг, эҳтиёж бўлса паллиатив ёрдамга йўналтиринг.

16. Ампутациядан кейинги ҳолат (чўлтоқ) (МКБ-10: Z89)

Мазмуни: Қўл ёки оёқ (ёки уларнинг бир қисми) жарроҳлик йўли билан олиб ташланганидан кейинги ҳолат. Қолган қисми «чўлтоқ» дейилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Протез-ортопедия мосламаси кераклигини ТИЭК белгилашини мижозга тушунтиринг. Фантом оғриқ (йўқ аъзода оғриқ сезиш), руҳий тушкунлик ва ҳаракатланишдаги қийинчиликларни ҳисобга олинг, кўникиш даврида қўллаб-қувватланг.

17. Анафилактик шок (МКБ-10: T78.2)

Мазмуни: Аллергиянинг энг оғир шакли: дори, озиқ-овқат ёки ари чақишидан кейин бир неча дақиқада нафас қийинлашади, қон босими тушади, одам ҳушдан кетиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ҳаёт учун хавфли: дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг. Бемор ёнида бўлинг, ётқизиб оёқларини сал кўтаринг, нафас йўллари ёпилмаслигини назорат қилинг.

18. Анемия (апластик, гипопластик шакли) (МКБ-10: D61)

Мазмуни: Суяк кўмиги қон ҳужайраларини етарли ишлаб чиқара олмаслиги. Оқибатда ҳолсизлик, тез чарчаш, кўкариш ва қон кетиш кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир касаллик, кўпинча қон қуйишни талаб қилади ва ногиронлик белгилашга асос бўлади. Инфекциядан ҳимояланишга ва қон қуйиш учун транспорт ёрдамига эътибор беринг.

19. Анемия (ирсий гемолитик) (МКБ-10: D58)

Мазмуни: Қизил қон таначалари туғма нуқсон сабабли тез парчаланиб кетиши, шу сабабли камқонлик, рангпарлик ва сариқлик кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик ирсий, шу сабабли оиладаги бошқа болаларни текширтириш муҳим. Мижознинг тез-тез шифокор кўригидан ўтишига ва зарур бўлса ногиронлик белгилаш учун ТИЭКга мурожаат қилишига ёрдам беринг.

20. Анемия (камқонлик) (МКБ-10: D64.9)

Мазмуни: Қонда гемоглобин камайиши: одам тез чарчайди, боши айланади, ранги оқариб кетади. Сабаби кўпинча темир етишмаслиги ёки қон йўқотиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кексалар, болалар ва ҳомиладор аёлларда кўп учрайди. Мижозни қон таҳлилига ва тўйимли овқатланишга йўналтиринг; яширин сабаб (масалан, ичдан қон кетиши) бўлиши мумкин, шифокорга йўлланг.

21. Аниридия (кўз камалагининг туғма йўқлиги) (МКБ-10: Q13.1)

Мазмуни: Кўзнинг рангли қисми (камалак парда) бутунлай ёки қисман бўлмаслиги. Ёруғликка сезувчанлик ортади, кўриш заифлашади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ёруғ нурдан кўзойнак билан ҳимояланиши керак. Глаукома ва катаракта хавфи юқори, кўз шифокори назоратини таъминланг; кўриш даражасига қараб ногиронлик кўрилади.

22. Анкилоз (бўғим қотиб қолиши) (МКБ-10: M24.6)

Мазмуни: Бўғимда ҳаракат бутунлай ёки деярли йўқолиши, бўғим «қотиб» қолиши. Жароҳат, яллиғланиш ёки операциядан кейин пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз кийиниш, юриш ва ўзини парвариш қилишда қийналади. Реабилитация машқлари ва ёрдамчи воситалар (ҳасса, ходунок) ҳақида маълумот беринг; бир нечта йирик бўғим қотса, ногиронлик кўрилади.

23. Анкилозловчи спондилоартрит (Бехтерев касаллиги) (МКБ-10: M45)

Мазмуни: Умуртқа поғонаси ва бел-думғаза бўғимларининг сурункали яллиғланиши, оқибатда умуртқа қотиб, эгилмай қолади. Эрталаб бел ва орқанинг қотиши ҳамда оғриши хос.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик кўпинча ёш эркакларда бошланади. Узоқ ўтириш ёки оғир юк кўтариш уни оғирлаштиради. Мунтазам даволаш гимнастикаси муҳим; оғир шаклида ногиронлик белгиланади.

24. Анофтальм (кўз олмасининг туғма йўқлиги) (МКБ-10: Q11.1)

Мазмуни: Бир ёки иккала кўз олмасининг туғма бўлмаслиги.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Икки кўзда бўлса — тўлиқ кўрлик, ногиронликка аниқ асос. Кўз протези ҳақида маълумот беринг; бола тифлопедагог билан ишлаши ва махсус таълимга эҳтиёжини ҳисобга олинг.

25. Антракоз (МКБ-10: J60)

Мазмуни: Кўмир чангини узоқ вақт нафас олиш оқибатида ўпканинг шикастланиши, асосан кончилар касаллиги. Нафас қисилиши ва йўтал билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касб касаллиги; меҳнат лаёқати йўқотилиши даражасини аниқлаш учун ТИЭКга йўналтирилади. Иш жойи ва стажи ҳужжатларини тўплашга ёрдам беринг; чекишни ташлаш муҳим.

26. Анэнцефалия (МКБ-10: Q00.0)

Мазмуни: Бош мия ва бош суяги қисмларининг туғма бўлмаслиги. Ҳаёт билан мос келмайдиган оғир нуқсон.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оила жуда оғир руҳий ҳолатда бўлади, уларни айбламанг ва шошилтирманг. Психологик ёрдам, тиббий маслаҳат ва керак бўлса диний ёки маънавий қўллаб-қувватлаш воситаларини таклиф қилинг.

27. Апалик синдром (вегетатив ҳолат) (МКБ-10: R40.2; G93.4)

Мазмуни: Бош мия оғир шикастланганидан кейин одам кўзларини очади, ухлайди ва уйғонади, лекин атрофдагиларни англамайди ва онгли жавоб бермайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бемор парваришга тўлиқ муҳтож: озиқлантириш, гигиена, ёнбошга ағдариш (ётоқ яраларининг олдини олиш). Оилани парвариш усулларига ўргатинг, ногиронликни расмийлаштиришга ёрдам беринг.

28. Аралаш жароҳат: тос ҳалқаси ва скелет суяклари (МКБ-10: T02)

Мазмуни: Тос суяклари ва бошқа суякларнинг бир вақтда синиши (одатда йўл ҳодисаси ёки баландликдан йиқилиш оқибатида).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Узоқ даволаниш керак, бемор ётоқ ҳолатида қолиши мумкин. Ётоқ яраларининг олдини олиш, парваришга ёрдам, реабилитация ва ҳаракатланиш воситалари (кресло-аравача, ходунок) билан таъминлашни режалаштиринг.

29. Артериал гипертензия (гипертония касаллиги) (МКБ-10: I10)

Мазмуни: Қон босимининг сурункали меъёрдан юқори бўлиши (одатда 140/90 дан юқори). Узоқ вақт назорат қилинмаса, инсульт, инфаркт ва буйрак касалликларига олиб келади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дориларни ўзини яхши ҳис қилганда ҳам ҳар куни ичиш кераклигини тушунтиринг, босимини мунтазам ўлчаб туринг. Нутқ бузилса ёки тананинг бир томони бўшашса, 103 га қўнғироқ қилинг.

30. Артифакия (кўзга сунъий гавҳар қўйилган ҳолат) (МКБ-10: Z96.1)

Мазмуни: Катаракта операциясида хиралашган табиий кўз гавҳари олиб ташланиб, ўрнига сунъий гавҳар (линза) қўйилган ҳолат.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Операциядан кейин кўриш яхшиланади, лекин биринчи ҳафталарда кўзни ишқаламаслик, оғир юк кўтармаслик ва томчи дориларни вақтида томизиш керак. Кекса мижозларга томчи томизишда ёрдам кераклигини ҳисобга олинг.

31. Артрит (ревматоид) (МКБ-10: M06.9)

Мазмуни: Бўғимларнинг сурункали яллиғланиши, одатда қўл ва оёқ бармоқлари бўғимлари симметрик зарарланади. Эрталаб қотиш, оғриқ, шиш ва аста-секин бўғимлар шаклининг ўзгариши кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз тугма тақиш, идиш ушлашда қийналиши мумкин. Дориларни доимий ичиш ва ревматолог назорати муҳим. Оғир шаклида ногиронлик белгиланади, ёрдамчи воситалар ҳақида маълумот беринг.

32. Артрит (ювенил) (МКБ-10: M08)

Мазмуни: 16 ёшгача болаларда бўғимларнинг сурункали яллиғланиши. Бўғимлар шишади, оғрийди, бола ҳаракатдан қочади, баъзан иситма ва кўз зарарланиши ҳам бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мактабда жисмоний тарбияда қулайлик яратиш, дорини узлуксиз бериш ва кўз шифокорида мунтазам кўрикни ота-оналарга тушунтиринг. Оғир шакли ногиронлик белгилашга асос бўлиши мумкин.

33. Артрогрипоз (бўғимларнинг туғма қотиши) (МКБ-10: Q74.3)

Мазмуни: Боланинг бир нечта бўғими қотиб (контрактура), қўл-оёқлари эгилмай ёки ёзилмай туғилиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола ҳаракатда чекланади, лекин ақли кўпинча соғлом. Эрта реабилитация, массаж ва ортопед назорати муҳим. Ногиронликни белгилатиш ва кресло-аравача каби воситаларга эҳтиёжни аниқлашда ёрдам беринг.

34. Аспергер синдроми (МКБ-10: F84.5)

Мазмуни: Аутизм спектридаги енгил шакл: одамнинг нутқи ва ақли соғлом, лекин у мулоқотда, ҳиссиётларни тушунишда қийналади, бир хил одатларга ёпишиб олади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга аниқ, қисқа, ёзма кўрсатмалар беринг, мажозий гаплардан сақланинг. Ўзгаришларни олдиндан огоҳлантиринг, шовқин ва гавжумлик безовта қилишини ҳисобга олинг.

35. Астеник синдром (астения) (МКБ-10: F48.0)

Мазмуни: Узоқ давом этувчи ҳолсизлик, тез чарчаш, диққатнинг пасайиши, жаҳлдорлик ва уйқу бузилиши. Кўпинча сурункали касаллик, стресс ёки оғир юкламадан кейин пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дам олиш тартиби, мунтазам уйқу ва овқатланишни тавсия этинг. Сабаби яширин касаллик ёки депрессия бўлиши мумкин, шифокорга йўлланг; лаёқатни баҳолашда буни ҳисобга олинг.

36. Асцит (қориндаги суюқлик йиғилиши) (МКБ-10: R18)

Мазмуни: Қорин бўшлиғида суюқлик тўпланиб, қорин катталашиши. Кўпинча жигар циррози, юрак етишмовчилиги ёки саратон оқибатида бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бемор нафас қисилиши ва юришда қийналади. Туз ва суюқликни чеклаш бўйича шифокор тавсиялари бажарилишини назорат қилинг. Оғир ҳолда парваришга муҳтож бўлади, паллиатив ёрдам керак бўлиши мумкин.

37. Атаксия (ирсий) (МКБ-10: G11)

Мазмуни: Ирсий касалликлар гуруҳи: мия ҳаракатларни мувофиқлаштирувчи қисмининг (мияча) шикастланиши оқибатида юриш чайқалувчан, нутқ чўзиқ, қўллар ноаниқ ҳаракат қилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик секин зўрайиб боради. Йиқилишдан сақланишга, уй хавфсизлигига (тутқичлар, силлиқ полсиз) ва юриш воситаларига ёрдам беринг; оилага тиббий-генетик маслаҳатни тавсия этинг.

38. Атаксия (ҳаракатлар мувофиқлигининг бузилиши) (МКБ-10: R27.0)

Мазмуни: Мушаклар кучли бўлса ҳам ҳаракатлар ноаниқ ва мувофиқлашмаган: одам маст каби чайқалиб юради, нарса ушлашга қийналади. Мия, айниқса мияча зарарланишида кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни маст деб ўйламанг. Йиқилиш хавфи юқори, юрганда ёнида бўлинг. Тўсатдан бошланган атаксия инсульт белгиси бўлиши мумкин — зудлик билан 103 га қўнғироқ қилинг.

39. Атеросклероз (МКБ-10: I70)

Мазмуни: Қон томирлар деворида ёғ (холестерин) тўпланиб, томирларнинг торайиши ва қотиши. Юрак, мия ва оёқларга қон боришини қийинлаштиради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Инфаркт ва инсульт хавфини оширади. Мижозга чекмаслик, ёғли овқатни камайтириш, ҳаракатни ошириш ва дориларни мунтазам ичишни тушунтиринг. Кексада юрганда оқсаш сабаби шу бўлиши мумкин.

40. Атетоз ва гиперкинезлар (МКБ-10: R25.8)

Мазмуни: Бош мия касалликларида одам иродасига бўйсунмайдиган секин, буралувчи (атетоз) ёки тез, тартибсиз (гиперкинез) ҳаракатлар. Ухлаганда йўқолади, ҳаяжонда кучаяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай ҳаракатлар мижознинг ихтиёрида эмас, уни айбламанг ва кулманг. Овқатланиш, кийиниш ва ёзишда ёрдам керак бўлиши мумкин. Болалар церебрал фалажи ва бошқа асаб касалликларида кўп учрайди.

41. Аутизм (атипик) (МКБ-10: F84.1)

Мазмуни: Аутизм белгилари кечроқ (3 ёшдан кейин) ёки тўлиқ бўлмаган кўринишда пайдо бўладиган шакли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола ва оилага ташхис ҳақида тушунтириш беринг. Эрта аралашув, махсус таълим ва мулоқот кўникмаларини ривожлантирувчи машғулотларга йўналтиринг; болани шовқин ва кутилмаган ўзгаришлардан эҳтиёт қилинг.

42. Аутизм (болалар аутизми) (МКБ-10: F84.0)

Мазмуни: Болалик даврида бошланадиган, атрофдагилар билан мулоқот қилиш, нутқ ва ўйинда ўзига хослик, бир хил ҳаракатларни такрорлаш билан кечадиган ривожланиш бузилиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўзга тик қарашдан қочиш ва исмга жавоб бермаслик ота-она «тарбиясизлиги» эмас. Эрта ёрдам ва ПТПК орқали логопед, психолог, махсус таълимга йўналтиринг, оилани қўллаб-қувватланг.

43. Афазия (нутқ ёки нутқни тушунишнинг йўқолиши) (МКБ-10: R47.0)

Мазмуни: Бош мия шикастланиши (инсульт, жароҳат) оқибатида нутқнинг ёки айтилган гапни тушунишнинг қисман ёки тўлиқ йўқолиши. Ақл сақланиб қолиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ақлан соғлом бўлиши мумкинлигини унутманг, унга болага гапиргандек гапирманг. Секин, қисқа жумлалар, имо-ишора ва расмлардан фойдаланинг, жавобга вақт беринг. Логопед билан ишлаш тикланишга ёрдам беради.

44. Афакия (кўз гавҳарининг йўқлиги) (МКБ-10: H27.0)

Мазмуни: Кўзда гавҳар (линза) бўлмаслиги, одатда катаракта операциясидан кейин, баъзан жароҳатдан кейин. Кўриш линза ёки кўзойнаксиз жуда заиф бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга махсус кўзойнак ёки контакт линза кераклигини, кўз шифокори назорати муҳимлигини тушунтиринг. Кўриш пасайиши даражасига қараб ногиронлик масаласини кўриш мумкин.

45. Афакия (туғма) (МКБ-10: Q12.3)

Мазмуни: Бола кўзида гавҳар туғма бўлмаслиги.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўриш ривожланиши учун эрта тиббий ёрдам ва тўғрилаш воситалари керак. Ота-оналарни эрта аралашув ва кўз шифокори кўригига йўналтиринг; махсус таълим эҳтиёжини ПТПК белгилайди.

46. Афония (овознинг йўқолиши) (МКБ-10: R49.1)

Мазмуни: Овоз пайларининг касаллиги ёки руҳий сабаблар туфайли одамнинг овози чиқмай, фақат шивирлаб гапириши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз билан юзма-юз ва секин гаплашинг, ёзув қоғози ёки планшетдан фойдаланинг. Тўсатдан пайдо бўлган бўлса, ЛОР шифокори ва керак бўлса психолог кўригига йўлланг.

47. Ахондрогенез (МКБ-10: Q77.0)

Мазмуни: Суяк ва тоғай ривожланишининг оғир туғма бузилиши, бола жуда калта қўл-оёқлар билан туғилади. Одатда ҳаёт билан мос келмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оила оғир руҳий ҳолатда бўлади. Психологик ёрдам ва шифокор билан маслаҳатлашув, керак бўлса паллиатив ёрдам имкониятлари ҳақида маълумот беринг.

48. Ахондроплазия (паканалик, суяк ўсишининг бузилиши) (МКБ-10: Q77.4)

Мазмуни: Суякларнинг, айниқса қўл-оёқларнинг калта қолиши билан кечадиган ирсий касаллик. Одамнинг бўйи паст, танаси нисбатан узун, ақли соғлом бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай одамга мослаштирилган муҳит (паст ўриндиқ, оёқ қўйғич) керак. Касаллик ногиронлик белгилашга асос бўлиши мумкин. Камситишдан ҳимоя қилинг, жамиятга ва меҳнатга мослашишига ёрдам беринг.

49. Ацетонурия (МКБ-10: R82.4)

Мазмуни: Сийдикда ацетон (кетон) моддаларининг пайдо бўлиши. Қандли диабетда, узоқ оч қолганда ёки болаларда иситма ва қайт қилишдан кейин учрайди. Нафасдан ацетон ҳиди келади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қандли диабети бор мижозда бу хавфли белги: диабетик команинг олдини олиш учун шифокорга зудлик билан мурожаат қилинг. Болаларда кўп ичириш ва шифокор кўриги зарур.

Б

50. Бачадон тушиши (МКБ-10: N81)

Мазмуни: Аёлларда бачадон ва қин деворларининг пастга сурилиши, оғир ҳолда бачадоннинг ташқарига чиқиши. Оғир юк кўтариш, кўп туғиш ва кексалик сабаб бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Аёллар уялиб, шифокорга боришдан тортинади. Мижозни уялтирмай, кўрикка ва даволашга йўналтиринг; оғриқ ва сийдик тута олмаслик каби шикоятлар борлигини сўранг.

51. Безовталикли бузилиш (хавотир бузилиши) (МКБ-10: F41)

Мазмуни: Узоқ вақт давомида аниқ сабабсиз ёки сабабга номутаносиб ортиқча хавотир, ваҳима, юрак тез уриши, бўғилиш ҳисси ва уйқусизлик билан кечадиган руҳий ҳолат.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга «хавотирланманг» деб айтавермасдан, ҳолатини жиддий қабул қилинг. Нафасни секинлаштириш, мунтазам кун тартиби ва овқатланиш ёрдам беради. Узоқ давом этса, психотерапевт ёки психиатрга йўналтиринг.

52. Биполяр аффектив бузилиш (МКБ-10: F31)

Мазмуни: Кайфиятнинг кескин ўзгариши билан кечадиган руҳий касаллик: баъзан ҳаддан ташқари кўтаринки ва тинч туролмайдиган (мания), баъзан чуқур тушкун (депрессия) даврлар навбатлашади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўтаринки даврда мижоз пулни исроф қилиши, хавфли қарор қабул қилиши мумкин; тушкун даврда суицид хавфи ортади. Дориларни узлуксиз ичиш муҳим, ҳолат ўзгарса шифокорга хабар беринг.

53. Блефароспазм (қовоқлар тиришиши) (МКБ-10: G24.5)

Мазмуни: Кўз қовоқларининг ихтиёрсиз, тез-тез ёки узоқ вақт қисилиб қолиши. Оғир ҳолда одам вақтинча кўрмай қолади, гарчи кўзи соғлом бўлса ҳам.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз йўлда юришда, машина ҳайдашда ва ўқишда хавф остида бўлади. Уни ёлғиз қолдирманг, кўчада кузатиб юринг. Неврологга мурожаат қилишни тавсия этинг; баъзи даво усуллари мавжуд.

54. Болалар церебрал фалажи (БЦФ) (МКБ-10: G80)

Мазмуни: Мия шикастланиши (туғишгача, туғиш пайтида ёки илк йилларда) оқибатида ҳаракат ва мувозанат бузилиши. Умрбод қолади, лекин зўрайиб бормайди; нутқ ва кўриш ҳам таъсирланиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлик белгилаш, реабилитация дастури (РЯТД), кресло-аравача, ходунок каби воситалар ва ПТПК орқали таълим йўналишини аниқлашда ёрдам беринг; ота-оналарни қўллаб-қувватланг.

55. Болдир суяклари синиши (МКБ-10: S82)

Мазмуни: Болдирдаги катта ёки кичик болдир суякларининг ёки иккаласининг синиши. Одатда гипс ёки операция билан даволанади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бемор бир неча ҳафта юролмайди: ҳасса, қўлтиқ таёқ ёки аравача ва уйда ёрдамчи керак. Кексаларда йиқилишнинг олдини олинг. Узоқ тикланмаса, контрактура ва ногиронликка олиб келиши мумкин.

56. Бош мия жароҳати (оқибатлари) (МКБ-10: S06)

Мазмуни: Бош мия шикастланишидан (урилиш, йиқилиш, йўл ҳодисаси) кейин қоладиган хотира бузилиши, бош оғриғи, нутқ ва ҳаракат бузилишлари, шахс ва хулқ ўзгариши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз жаҳлдор ёки унутувчан бўлиши мумкин — бу «феъли» эмас, касаллик оқибати. Реабилитация, невролог назорати ва ногиронлик масаласини кўриб чиқинг; газ ва дори хавфсизлигини таъминланг.

57. Бош мия сили (МКБ-10: A17)

Мазмуни: Сил микобактериясининг бош мия пардаларини зарарлаши (сил менингити). Иситма, кучли бош оғриғи, қайт, ҳушдан кетиш билан кечади; ўта хавфли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дарҳол касалхонага ётқизиш керак. Узоқ даволаниш (камида бир йил) ва қатъий дори қабули зарур. Оила аъзоларини текширтириш ва беморнинг дорини ташлаб юбормаслигини назорат қилиш муҳим.

58. Бош мия ўсмаси (хавфли) (МКБ-10: C71)

Мазмуни: Бош миядаги хавфли ўсма. Бош оғриғи, қайт, тутқаноқ, кўриш ва нутқ бузилиши ёки хулқ ўзгариши билан намоён бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бемор ва оила оғир руҳий ҳолатда бўлади, ҳамдардлик билан муомала қилинг. Онкологик даво ва ногиронлик масалаларида ёрдам беринг; кейинги босқичда паллиатив ёрдам ҳақида айтинг.

59. Бронхиал астма (МКБ-10: J45)

Мазмуни: Нафас йўллари (бронхлар)нинг сурункали яллиғланиши, натижада вақти-вақти билан нафас қисилиши, ҳуштаксимон хириллаш, йўтал ва бўғилиш хуружлари бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ингалятор (нафас дориси)ни доим ёнида олиб юриши керак. Хуружни қўзғатувчи омилларни (чанг, тутун, ҳайвон жуни, совуқ) камайтиринг. Ингалятор ёрдам бермаса, 103 га қўнғироқ қилинг.

60. Бронхит (сурункали) (МКБ-10: J42)

Мазмуни: Бронхларнинг узоқ давом этувчи яллиғланиши: йилига камида уч ой давомида, икки йил кетма-кет балғамли йўтал. Асосан чекувчилар ва зарарли чангда ишловчиларда учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Энг муҳими — чекишни тўхтатиш. Совуқ ва чангдан сақланиш, эмлаш, нафас машқлари керак. Балғам қонли бўлса ёки нафас қисилса, зудлик билан шифокорга йўлланг.

61. Бруцеллёз (МКБ-10: A23)

Мазмуни: Касал чорва моллари (қўй, эчки, сигир) ёки термик ишлов берилмаган (хом) сут маҳсулотлари орқали юқадиган касаллик. Иситма, терлаш, бўғим ва мушак оғриқлари билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Деҳқон ва чорвадорлар орасида кўп учрайди. Тўлиқ даволаниш муҳим, акс ҳолда касаллик сурункали бўлади. Мижозга пастеризацияланмаган сутдан сақланиш ва чорва билан қўлқопда ишлашни тушунтиринг.

62. Буйрак тушиши (нефроптоз) (МКБ-10: N28.8)

Мазмуни: Буйрак ўз жойидан пастга сурилиши. Бел оғриғи, айниқса тик турганда ёки юк кўтарганда кучаяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга оғир юк кўтармасликни тушунтиринг. Баъзи ҳолларда махсус бандаж тавсия қилинади (253-қарорда қорин девори чурраси ва буйрак тушганлиги учун бандаж киритилган).

63. Буйрак ўсмаси (хавфли) (МКБ-10: C64)

Мазмуни: Буйракдаги хавфли ўсма. Сийдикда қон пайдо бўлиши, бел оғриғи, озиш ва ҳолсизлик билан намоён бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга онкологик диспансерга тез йўлланма олишга ёрдам беринг. Буйраги олиб ташланганда қолган буйракни асраш (шифокор тавсиялари) муҳим. Ногиронлик ва ижтимоий ёрдам масалаларини кўриб чиқинг.

64. Буллёз эпидермолиз (МКБ-10: Q81)

Мазмуни: Тери жуда нозик бўлиб, озгина ишқаланишдан ҳам пуфак ва яралар пайдо бўладиган оғир ирсий касаллик. Болаларни «капалак болалар» дейишади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болани кўтарганда ва кийинтирганда эҳтиёт бўлинг, пуфакларни босманг. Махсус боғлам қиммат, оила молиявий ёрдамга муҳтож. Ногиронлик белгиланади, оилага руҳий қўллаб-қувватлаш керак.

65. Бурсит (МКБ-10: M71)

Мазмуни: Бўғим атрофидаги суюқлик халтачасининг (бурса) яллиғланиши. Ўша жой шишади, қизаради ва оғрийди (елка, тирсак, тизза).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўп тиз чўкиб ёки бир хил ҳаракат қилиб ишлайдиганларда кўп учрайди. Мижозга бўғимни дам олдириш, оғир юкдан сақланиш ва шифокорга мурожаат қилиш тавсия этилади.

66. Бўйин қийшиқлиги (спастик) (МКБ-10: G24.3)

Мазмуни: Бўйин мушакларининг ихтиёрсиз қисқариши оқибатида бош бир томонга бурилиб ёки эгилиб қолиши, баъзан бош қалтираши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ўзини ноқулай ҳис қилиши ва уялиши мумкин. Юз ёки бўйинга қўл билан енгил тегиб туриш баъзан ҳолатни енгиллаштиради. Невролог даволаши мумкин (масалан, инъекциялар). Мижозга меҳрибон ва эътиборли муносабатда бўлинг.

67. Бўри танглай (танглай ёриғи) (МКБ-10: Q35)

Мазмуни: Бола оғзининг устки қисми (танглай) туғма очиқ бўлиши. Бундай болалар овқатланишда ва гапиришда қийналади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола жарроҳлик йўли билан даволанади, сўнг логопед билан ишлаш керак. Оилага махсус сўргич ва даволаш босқичлари ҳақида маълумот беринг; ютиш бузилса, ногиронлик ҳам белгиланади.

68. Бўғим беқарорлиги (МКБ-10: M25.3)

Мазмуни: Бўғим бойламларининг бўшашиши туфайли унинг тез-тез чиқиши ёки «ўйнаб» туриши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз йиқилиш ва қайта шикастланиш хавфи остида. Бойлам тутувчи бандаж ёки ҳассадан фойдаланиш, мушакларни мустаҳкамловчи машқлар ёрдам беради. Ортопедга мурожаат қилишни тавсия этинг.

В

69. Варикоз кенгайиш (оёқ веналари) (МКБ-10: I83)

Мазмуни: Оёқдаги веналарнинг кенгайиб, буралиб, бўртиб чиқиши. Оёқда оғирлик, шиш, қичиш ва баъзан яралар пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Узоқ тик туриш ёки ўтириш касалликни оширади. Эластик пайпоқ ва ҳаракат фойдали. Қизарган, оғриқли жой ёки яра чиқса — тромбофлебит хавфи, шифокорга зудлик билан йўлланг.

70. Вестибуляр бузилишлар (МКБ-10: H81)

Мазмуни: Ички қулоқдаги мувозанат аъзосининг касаллиги: бош айланиши, кўнгил айниши, юришда чайқалиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Йиқилиб жароҳатланиш хавфи юқори, айниқса кексаларда. Бошни тез бурмаслик, кўчада ёнида юриш ва уйда хавфсизлик (йўлакда бўш жой) муҳим. ЛОР ва неврологга мурожаат қилинг.

71. Вилсон касаллиги (гепатолентикуляр дегенерация) (МКБ-10: E83.0)

Мазмуни: Организмда мис алмашинувининг ирсий бузилиши: мис жигар ва мияда тўпланиб, жигар касаллиги, қўл қалтираши, нутқ бузилиши ва руҳий ўзгаришларга олиб келади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дорини умр бўйи ичиш ва мисга бой овқатлардан (жигар, ёнғоқ, шоколад) сақланиш керак. Касаллик ирсий, қариндошларни текширтириш муҳим; ногиронлик масаласини ўз вақтида кўтаринг.

72. Вильямс синдроми (МКБ-10: Q87.1)

Мазмуни: Ирсий синдром: юрак ва қон томир нуқсонлари, ўзига хос юз тузилиши, ақлий ривожланишнинг орқада қолиши ва ҳамма билан тез дўстлашувчанлик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола ортиқча ишонувчан бўлгани учун ёт одамлардан алданиши ва хавф остида қолиши мумкин. Юрак шифокорига мунтазам кўрсатиш, махсус таълим ва эрта аралашув хизматларига йўналтириш керак.

73. Вирусли гепатит В (сурункали) (МКБ-10: B18.1)

Мазмуни: Жигарнинг В вируси билан узоқ давом этувчи яллиғланиши. Қон ва жинсий алоқа орқали юқади, вақт ўтиши билан циррозга олиб келиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оддий мулоқот ва умумий ошхонадан фойдаланиш хавфли эмас; беморни камситманг. Тиш чўткаси, устарани алоҳида сақлаш, оилани эмлаш ва беморни шифокор назоратига йўналтириш керак.

74. Вирусли гепатит С (сурункали) (МКБ-10: B18.2)

Мазмуни: Жигарнинг С вируси билан узоқ вақт давом этувчи яллиғланиши. Асосан қон орқали юқади ва йиллар давомида белгисиз кечиб, циррозга олиб келиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ҳозир касаллик самарали даволанади. Мижозга ўз вақтида текширувдан ўтиш ва даволаниш кераклигини тушунтиринг. Устара, игнани алоҳида ишлатишни айтинг, камситманг.

Г

75. Галлерворден–Шпатц касаллиги (МКБ-10: G23.0)

Мазмуни: Нодир ирсий касаллик: мия чуқур қисмларида темир тўпланиб, ҳаракат, мушак тонуси ва нутқ аста-секин бузилади, ақл ҳам пасайиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик секин зўрайиб боради: ногиронлик, ҳаракатланиш воситалари (кресло-аравача) ва доимий парвариш масаласини ўз вақтида кўтаринг. Оилага тиббий-генетик маслаҳат ва руҳий қўллаб-қувватлаш керак.

76. Гастрит (МКБ-10: K29)

Мазмуни: Ошқозон шиллиқ қаватининг яллиғланиши: қорин оғриғи, кўнгил айниши, ачишиш, тўқлик ҳисси.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга тартибли овқатланиш, аччиқ ва ёғли таомлардан, чекиш ва спиртли ичимликдан сақланишни тушунтиринг. Қонли қайт ёки қора нажас пайдо бўлса, зудлик билан 103 га қўнғироқ қилинг.

77. Гемартроз (бўғимга қон қуйилиши) (МКБ-10: M25.0)

Мазмуни: Бўғим ичига қон тўпланиши: бўғим шишади, оғрийди, ҳаракат қийинлашади. Гемофилияда тез-тез учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай бўғимни ҳаракатлантирмаслик ва тезда тиббий ёрдам кўрсатиш керак. Такрорий қон қуйилишлар бўғимни емириб, контрактурага олиб келади. Гемофилияси бор мижозда зудлик билан гематолог кўригини таъминланг.

78. Гемианопсия ва кўриш майдонининг торайиши, скотома (МКБ-10: H53.4)

Мазмуни: Кўриш майдонининг бир қисми тушиб қолиши (ўнг ёки чап томонни кўрмаслик) ёки кўз олдида қора доғ (скотома). Инсульт ва глаукомада кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз «кўр» томонидаги нарсаларга урилиши мумкин (масалан, овқатнинг ярмини кўрмайди). Нарсаларни кўринадиган томонга қўйинг, кўчада ёнида юринг. Майдон жуда тор бўлса, ногиронлик кўрилади.

79. Гемиплегия (тананинг бир томони фалажи) (МКБ-10: G81)

Мазмуни: Тананинг бир томонидаги қўл ва оёқ ҳаракатининг тўлиқ йўқолиши. Кўпинча инсульт ёки мия жароҳатидан кейин бўлади (парез — тўлиқ бўлмаган кучсизлик).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз парваришда ёрдамга муҳтож. Фалаж томонни жароҳатдан сақланг, ётоқ яраларининг олдини олиш учун ҳар икки соатда ҳолатини ўзгартиринг. Реабилитация, воситалар ва ногиронлик масаласида ёрдам беринг.

80. Гемобластозлар (қон ва лимфа тўқимаси ўсмалари) (МКБ-10: C81–C96)

Мазмуни: Қон яратувчи ва лимфа тўқималарининг хавфли ўсмалари гуруҳи (лейкозлар, лимфомалар).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Узоқ ва оғир даволаниш (химиотерапия) керак, иммунитет пасаяди. Беморни инфекциядан ҳимоя қилиш ва стационарга қатнов учун транспорт ёрдами муҳим; ногиронликни ўз вақтида расмийлаштиринг.

81. Геморрагик синдром (қон кетишга мойиллик) (МКБ-10: D69.9)

Мазмуни: Қон ивиш тизимининг бузилиши оқибатида осон кўкариш, бурундан ва милкдан қон кетиш, терида майда нуқтасимон қон қуйилишлар.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни жароҳатдан сақлаш ва аспирин каби қонни суюлтирувчи дориларни шифокорсиз бермаслик муҳим. Қон тўхтамаса ёки қон билан қайт қилса, зудлик билан 103 га қўнғироқ қилинг.

82. Гемофилия А (МКБ-10: D66)

Мазмуни: Қоннинг ивиши учун зарур VIII омил етишмаслигидан келиб чиқадиган ирсий касаллик (асосан эркакларда). Озгина жароҳатдан ҳам қон узоқ тўхтамайди, бўғимларга қон қуйилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Етишмайдиган омил дорисининг ўз вақтида етказилишини назорат қилинг. Жароҳатдан ва мушакка инъекциядан сақланиш муҳим. Ногиронликка аниқ асос; оилага ирсийлик ҳақида тушунтиринг.

83. Гемофилия В (МКБ-10: D67)

Мазмуни: Қоннинг ивиши учун зарур IX омил етишмаслигидан келиб чиқадиган ирсий касаллик (А шаклидан енгилроқ кечиши мумкин). Белгилари ва хавфлари гемофилия А каби.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Парваришда гемофилия А билан бир хил чоралар кўрилади: қон кетишнинг олдини олиш, дорини ўз вақтида қабул қилиш ва бўғимларни асраш. Ногиронликка ва тегишли реабилитацияга ёрдам беринг.

84. Гепатит (вирусли гепатитлар гуруҳи) (МКБ-10: B15–B19)

Мазмуни: Вируслар келтириб чиқарадиган жигар яллиғланиши. А гепатит ифлосланган сув, овқат ва ювилмаган қўллар орқали, В ва С гепатитлар қон орқали юқади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қўл ювиш, тоза сув ичиш ва гигиена буюмларини алоҳида ишлатиш юқишнинг олдини олади. Касалларни камситманг. Сариқлик, тўқ рангли сийдик ва ҳолсизликда шифокорга мурожаат қилишни тавсия этинг.

85. Гепатоспленомегалия (МКБ-10: R16.2)

Мазмуни: Жигар ва талоқнинг бир вақтнинг ўзида катталашиши. Бу алоҳида касаллик эмас, балки жигар, қон ёки модда алмашинуви касалликларининг белгиси.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз қорин оғирлиги, тез тўйиш ва ҳолсизликдан шикоят қилиши мумкин. Сабабини аниқлаш учун шифокор ва текширувга йўналтиринг. Талоқ катта бўлса, қорин жароҳатидан сақланиш керак.

86. Гестация муддатига нисбатан кам вазнли туғилиш (МКБ-10: P05)

Мазмуни: Чақалоқнинг ҳомиладорлик муддатига нисбатан кам вазн билан туғилиши; бундай болаларда ривожланишда орқада қолиш ва касалланиш хавфи юқори.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Педиатр ва невролог кўриги, тўғри овқатлантириш ва эмлаш муҳим. Ривожланишда орқада қолиш кўринса, болани эрта аралашув хизматига йўналтиринг.

87. Гидроцефалия (орттирилган) (МКБ-10: G91)

Мазмуни: Бош мия бўшлиқларида суюқлик тўпланиши, кейинчалик (жароҳат, менингит, ўсмадан сўнг) пайдо бўлади. Бош оғриғи, қайт, уйқучанлик, юриш ва хотира бузилиши билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Операция (шунт қўйиш) билан даволанади. Мижоз ва яқинларига шунт ишламай қолиш белгиларини тушунтиринг: бош оғриғи кучайиши, қайт, ҳолсизлик. Бундай ҳолда шифокорга зудлик билан мурожаат қилинг.

88. Гидроцефалия (туғма) (МКБ-10: Q03)

Мазмуни: Болада бош мия суюқлиги кўп йиғилиб, бош катталашиши ва мия босилиши. Ривожланиш орқада қолиши, талваса ва кўриш бузилиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болада шунт операцияси кераклигини ва уни назорат қилишни ота-оналарга тушунтиринг. Эрта аралашув, невролог кузатуви ва оғир ҳолларда ногиронлик ва ўзгалар парваришига муҳтожлик белгилаш бўйича ёрдам беринг.

89. Гиперактивлик ва диққат етишмаслиги синдроми (СДВГ) (МКБ-10: F90.0)

Мазмуни: Боланинг диққатини узоқ жамлай олмаслиги, ҳаддан ташқари ҳаракатчанлиги ва ўйламай иш қилиши. Бу «тарбиясизлик» эмас, мия ривожланишининг хусусияти.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ота-она ва ўқитувчига жазо эмас, аниқ қоидалар, кичик вазифалар ва мақташ самарали эканини тушунтиринг. Психолог ва психоневролог билан ишлаш, мактабда қулайлик яратиш лозим.

90. Гиперметропия (узоқни кўрарлик) (МКБ-10: H52.0)

Мазмуни: Кўзнинг яқин масофадаги нарсаларни ноаниқ кўриши. Ўқиш ёки ёзишда кўз чарчайди ва бош оғрийди. Юқори даражасида болаларда ғилайликка олиб келиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болада бош оғриғи ва ўқишдан қочиш сабаби кўриш бўлиши мумкин: кўз шифокорига йўлланг. Кўзойнак билан тўғриланади. Юқори даражаси махсус таълим эҳтиёжига асос бўлиши мумкин.

91. Гипертермия (иситма) (МКБ-10: R50)

Мазмуни: Тана ҳароратининг 38 даражадан юқори кўтарилиши. Ўзи касаллик эмас, юқумли ва бошқа касалликларнинг белгиси.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўп суюқлик беринг, ҳароратни ўлчаб боринг, иссиқ ўраманг. Ҳарорат 39 дан ошса ёки талваса, ҳушдан кетиш бўлса, зудлик билан 103 га қўнғироқ қилинг.

92. Гипогликемия (қонда шакар камайиши) (МКБ-10: E16.2)

Мазмуни: Қонда шакар миқдорининг тез пасайиши: қўл титраши, терлаш, очлик, ҳолсизлик, ҳушдан кетиш. Диабетда дори ортиқча ёки овқат кам бўлганда кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ҳушида бўлса, дарҳол шакар, асал ёки ширин чой беринг. Ҳушсиз бўлса, оғзига ҳеч нарса солманг ва зудлик билан 103 га қўнғироқ қилинг. Овқатни ўтказиб юбормаслик муҳим.

93. Гипоксия (кислород етишмаслиги) (МКБ-10: R09.0)

Мазмуни: Қон ва тўқималарда кислород камайиши. Лаб ва бармоқларнинг кўкариши, нафас қисилиши, боши айланиши ва чалкашлик белгилари.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Шошилинч ҳолат: мижозни ўтқазиб, тоза ҳавога чиқаринг ва 103 га қўнғироқ қилинг. Сурункали ўпка ва юрак касаллигида уйда кислород аппарати керак бўлиши мумкин.

94. Гипопаратиреоз (МКБ-10: E20)

Мазмуни: Қалқонсимон без орқасидаги паратироид безларнинг етарли гормон ишлаб чиқармаслиги, натижада қонда кальций камайиб, мушак тортишиши, қўл-оёқ увишиши ва талваса бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз кальций ва D витамини дориларини умр бўйи ичиши мумкин. Дорини ташламаслигини ва қон таҳлилини мунтазам топширишини назорат қилинг. Талваса бўлса, зудлик билан шифокорга мурожаат қилинг.

95. Гипотиреоз (орттирилган) (МКБ-10: E03.9)

Мазмуни: Қалқонсимон безнинг гормонни кам ишлаб чиқариши. Ҳолсизлик, совуқни кўтара олмаслик, вазн ортиши, қабзият, терининг қуруқлиги, хотира ва кайфият пасайиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кексаларда деменция ёки депрессия билан адаштирилиши мумкин. Қон таҳлили билан осон аниқланади, гормон дори билан даволанади. Дорини ҳар куни ва бир вақтда ичиш муҳимлигини тушунтиринг.

96. Гипотиреоз (туғма) (МКБ-10: E03.1)

Мазмуни: Боланинг қалқонсимон бези гормон ишлаб чиқармай туғилади. Даволанмаса ақлий ва жисмоний ривожланиш орқада қолади. Чақалоқда скрининг орқали эрта аниқланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Эрта (биринчи ойларда) даво бошланса, бола тўлиқ соғлом ривожланади. Ота-оналарга дорини умр бўйи тўхтатмасдан бериш кераклигини тушунтиринг. Бу ногиронлик белгилаш асослари рўйхатидаги касалликлардан.

97. Гипотония (қон босимининг пасайиши) (МКБ-10: I95)

Мазмуни: Қон босимининг меъёрдан паст бўлиши, боши айланиши, кўз олдининг қоронғилашиши ва ҳолсизлик билан намоён бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ўтирган ёки ётган жойидан секин туриши керак, акс ҳолда йиқилиши мумкин. Кексаларда дори таъсири ва овқатланишни текширинг. Ҳушдан кетса, ётқизиб, оёқларини кўтаринг.

98. Гипотрофия (озиқланиш етишмовчилиги) (МКБ-10: E44–E46)

Мазмуни: Болада тана вазнининг ёшига нисбатан кам бўлиши, озиқланиш етишмаслиги оқибатида вазн ва ўсишнинг орқада қолиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Сабаби камбағаллик, нотўғри овқатлантириш, касаллик ёки эътиборсизлик бўлиши мумкин. Оила шароитини ўрганинг, овқатланиш бўйича маслаҳат ва керак бўлса моддий ёрдамга йўналтиринг. Вазнни мунтазам ўлчаб боринг.

99. Гипофизар нанизм (МКБ-10: E23.0)

Мазмуни: Мия ости безининг ўсиш гормонини кам ишлаб чиқариши туфайли одам бўйининг жуда паст (эркакда 130 см, аёлда 120 см гача) бўлиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ўсиш гормони эрта берилса, самара беради. Ногиронлик белгилаш асослари рўйхатига киради. Камситишдан ҳимоя қилиш ва жамиятга мослашишига ёрдам бериш муҳим.

100. Гистиоцитоз (МКБ-10: D76)

Мазмуни: Иммун ҳужайралар (гистиоцитлар)нинг ортиқча кўпайиши билан кечадиган нодир касаллик, суяк, тери, ўпка ва жигарни зарарлайди. Хавфли шакли ҳам бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай беморлар узоқ ва мураккаб даволанади. Оилага молиявий, ижтимоий ва руҳий қўллаб-қувватлаш беринг. Хавфли гистиоцитоз ногиронлик белгилаш асосий рўйхатларига киради.

101. Глаукома (МКБ-10: H40)

Мазмуни: Кўз ичи босимининг ошиши оқибатида кўриш нервининг шикастланиши ва кўриш майдонининг торайиши. Даволанмаса, бутунлай кўрликка олиб келади, аввалига белгиларсиз кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: 40 ёшдан катталарга кўз босимини йилига бир марта текширтиришни тавсия этинг. Томчи дорилар умр бўйи ҳар куни томизилади; ўтказиб юбориш кўрликка олиб келади.

102. Глаукома (туғма) (МКБ-10: Q15.0)

Мазмуни: Чақалоқ ёки болада кўз ичи босимининг туғма юқори бўлиши. Кўз катталашиб, ёруғликдан қўрқиш ва кўз ёши оқиши билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Эрта жарроҳлик даво кўришни сақлаб қолиши мумкин; ота-оналарга болада кўз катталиги ёки хиралигини кўрганда тезда шифокорга боришни тушунтиринг. Кўриш пасайса, махсус таълим эҳтиёжи ва ногиронлик белгиланади.

103. Гломерулонефрит (сурункали) (МКБ-10: N03)

Мазмуни: Буйрак фильтрларининг узоқ давом этувчи яллиғланиши: шиш, юқори қон босими, сийдикда оқсил ва қон. Вақт ўтиши билан буйрак етишмовчилигига олиб келади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга туз ва суюқликни чеклаш, шифокор тавсиясига амал қилиш ва сийдик таҳлилини мунтазам топширишни тушунтиринг. Гемодиализда ногиронлик белгиланади, қатнов бўйича ёрдам керак бўлади.

104. Гломерулонефрит (ўткир) (МКБ-10: N00)

Мазмуни: Буйрак фильтрларининг тўсатдан яллиғланиши, кўпинча томоқ ёки тери инфекциясидан кейин: юз шиши, «гўшт ювиндиси» рангидаги сийдик, юқори босим.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни дарҳол стационарга йўлланг. Болаларда кўп учрайди. Даволаниш ва парҳезга (тузсиз овқат) амал қилишни оила билан бирга назорат қилинг.

105. Глянцман тромбастенияси (МКБ-10: D69.1)

Мазмуни: Қон пластинкалари (тромбоцитлар)нинг ирсий нуқсони, шу сабабли қон ивиши бузилади: тез-тез бурун, милк қон кетиши ва кўкаришлар.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни жароҳатдан сақлаш, аспирин ва шунга ўхшаш дориларни ичмаслик муҳим. Оғир қон кетишда зудлик билан тиббий ёрдам керак. Касалликнинг ирсий эканини ҳисобга олиб, оилани хабардор қилинг.

106. Гонартроз (тизза бўғими артрози) (МКБ-10: M17)

Мазмуни: Тизза бўғими тоғайининг емирилиши. Юрганда, зинадан чиқаётганда оғриқ, бўғимда «қирсиллаш» ва ҳаракат чекланиши билан кечади. Кексаларда кўп учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга вазнни камайтириш, ҳассадан фойдаланиш ва даволаш гимнастикаси ёрдам беради. Узоқ юриш ва зинапоялардан қочиш лозим. Оғир шаклида бўғимни протезлаш (эндопротезлаш) керак бўлиши мумкин.

107. Гоше касаллиги (МКБ-10: E75.2)

Мазмуни: Ферментнинг ирсий етишмовчилиги: талоқ, жигар ва суякларда махсус моддалар йиғилиб, камқонлик, талоқ катталашиши ва суяк оғриқлари кузатилади. Орфан (нодир) касалликлардан.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Фермент алмаштирувчи дорини давомли қабул қилиш ҳаётни сақлаб қолади. Дори қиммат, таъминот масаласини кўтаринг. Касаллик ирсий, қариндошларни текширтиринг; ногиронлик ва реабилитацияни кўриб чиқинг.

Д

108. Даун синдроми (МКБ-10: Q90)

Мазмуни: 21-жуфтда учта хромосома бўлиши (трисомия 21) билан боғлиқ туғма ҳолат: ўзига хос кўриниш, секин ривожланиш, кўпинча юрак нуқсони.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола эрта ёшдан махсус машғулотларга (логопед, дефектолог) муҳтож. Оилага боланинг имкониятлари ҳақида тўғри маълумот беринг, камситишдан ҳимоя қилинг, ПТПК орқали таълим масаласига ёрдам беринг.

109. Делирий (онг хиралашуви) (МКБ-10: F05)

Мазмуни: Тўсатдан онг хиралашуви: одам чалкашади, алаҳлайди, баъзан йўқ нарсаларни кўради. Кўпинча кексаларда иситма, инфекция ёки дори таъсирида бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу шошилинч ҳолат, деменция эмас: тўсатдан бошланади ва сабаби топилса, даволанади. Мижозни тинч, ёруғ хонада ушлаб, зудлик билан шифокорга ёки 103 га хабар беринг.

110. Деменция (МКБ-10: F03)

Мазмуни: Мия ишлашининг аста-секин бузилиши: хотира, фикрлаш ва ўзини эплаш пасаяди. Бу оддий қариш эмас, касаллик; энг кўп сабаби — Альцгеймер.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз унутиши, адашиши ва яқинларини танимаслиги мумкин: уни айбламанг, тортишманг, тинч гаплашинг. Хавфсизликни (газ, эшик, адашиш) таъминланг; оилани парвариш ва васийлик масалаларига тайёрлашга ёрдам беринг.

111. Депрессия (МКБ-10: F32; F33)

Мазмуни: Икки ҳафтадан ортиқ давом этадиган чуқур тушкунлик, ҳаётдан завқ олмаслик, ҳолсизлик, уйқу ва иштаҳа бузилиши. Бу «ялқовлик» ёки «феъл» эмас, даволанадиган касаллик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга «ўзингни қўлга ол» деманг, уни тинглаб, жиддий қабул қилинг. «Яшашнинг маъноси йўқ» каби гаплар бўлса, ёлғиз қолдирманг ва зудлик билан шифокорга йўналтиринг.

112. Дерматит (МКБ-10: L30.9)

Мазмуни: Терининг яллиғланиши: қизариш, қичиш, тошма, баъзан пўст ташлаш. Сабаби аллергия, кимёвий моддалар, совун ёки бошқа таъсирот бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик юқумли эмас, мижозни четлаб ўтманг. Таъсир қилувчи нарсани (кир ювиш воситаси, қўлқоп) аниқлаб, ундан сақланишга ёрдам беринг; ётоқ беморда терини тоза ва қуруқ сақланг.

113. Дерматополимиозит (МКБ-10: M33)

Мазмуни: Нодир касаллик: иммунитет нотўғри ишлаб, мушаклар ва терини яллиғлантиради. Мушаклар кучсизлашади (зинага чиқиш, қўлни кўтариш қийин), терида тошма пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир шаклида мижоз ўзини парвариш қила олмайди, ногиронлик белгиланиши мумкин. Дорини узлуксиз ичиш муҳим. Болада мактабдаги шароитга эътибор беринг.

114. Диабетик кома (МКБ-10: E10.0; E11.0)

Мазмуни: Қандли диабетда қон шакари жуда баланд ёки жуда паст бўлиб кетганда одамнинг ҳушдан кетиши. Ҳаёт учун хавфли ҳолат.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Диабетли одам ҳушсиз ётса, дарҳол 103 га қўнғироқ қилиб, диабети борлигини айтинг; ҳушсизга овқат ёки ичимлик берманг. Дори ва овқатланишни назорат қилинг.

115. Диабетик нефропатия (МКБ-10: E11.2)

Мазмуни: Қандли диабет оқибатида буйракларнинг аста-секин шикастланиши. Аввалига белгисиз, кейин шиш, қон босими ошиши ва буйрак етишмовчилиги пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга қон шакари ва босимни назорат қилиш буйракни сақлашини тушунтиринг. Йилига бир марта сийдик ва қон таҳлили топширилади; оғир босқичда гемодиализ ва ногиронлик масаласи туғилади.

116. Диабетик ретинопатия (МКБ-10: E11.3; H36.0)

Мазмуни: Қандли диабет туфайли кўзнинг тўр парда томирларининг шикастланиши. Кўриш аста-секин пасаяди ва даволанмаса кўрлик бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Диабетли мижоз кўриши яхши бўлса ҳам йилига бир марта кўз шифокорида кўрикдан ўтиши шарт. Кўриш пасайса, овозли глюкометр каби воситалар ҳақида маълумот беринг.

117. Диабетик оёқ синдроми (диабет тўпиғи) (МКБ-10: E10.5; E11.5)

Мазмуни: Диабетда оёқ нервлари ва томирлари шикастланиб, панжада узоқ тузалмайдиган яралар пайдо бўлиши. Оғир ҳолда оёқ кесилиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга оёғини ҳар куни кўздан кечириш, ялангоёқ юрмаслик ва қулай пойабзал кийишни тушунтиринг. Кичик яра чиқса ҳам, дарҳол шифокорга боринг; мураккаб ортопедик пойабзал мавжуд.

118. Дизартрия (талаффузнинг бузилиши) (МКБ-10: R47.1)

Мазмуни: Нутқ мушаклари яхши ишламагани сабабли сўзларнинг ноаниқ талаффуз қилиниши. Одам нима демоқчи эканини билади, лекин тили айланмайди. Инсульт, БЦФда учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижознинг гапини бўлмасдан, диққат билан тинглаб, керак бўлса қайтариб сўранг. Уни асабийлаштирманг ва «ақли йўқ» деб ўйламанг. Логопед билан ишлаш ёрдам беради.

119. Дисбактериоз (МКБ-10: K63.8)

Мазмуни: Ичакдаги фойдали ва зарарли бактериялар мувозанатининг бузилиши: қорин дам бўлиши, ич кетиши ёки қотиши. Кўпинча антибиотик ичгандан кейин пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Одатда оғир касаллик эмас, лекин мижозни безовта қилади. Тўғри овқатланиш ва шифокор тавсияси ёрдам беради. Узоқ давом этса ёки қон аралаш бўлса, шифокорга йўналтиринг.

120. Дислексия ва дисграфия (ўқиш ва ёзишнинг махсус бузилиши) (МКБ-10: F81)

Мазмуни: Ақли ва кўриши соғлом болада ўқиш (дислексия) ва ёзиш (дисграфия) ўрганишдаги доимий қийинчилик: ҳарфларни аралаштириш, сўзларни хато ёзиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болани «ялқов» ёки «ақлсиз» деб айбламанг. Логопед ёки махсус педагог билан ишлаш керак. Мактабда қўшимча вақт ва қулай шароит ҳақида ўқитувчи билан келишиш мумкин.

121. Дистония (МКБ-10: G24)

Мазмуни: Мушакларнинг ўз-ўзидан қисқариб қолиши натижасида тананинг бир қисми ғайритабиий ҳолатда қотиб қолиши ёки буралиб қолиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ўзини ноқулай ҳис қилиши ва уялиши мумкин. Уни масхара қилишдан ҳимоя қилинг. Неврологга мурожаат қилиш керак: дори ва махсус инъекциялар ёрдам беради.

122. Дисфагия (ютишнинг бузилиши) (МКБ-10: R13)

Мазмуни: Овқат ёки сувни ютишда қийналиш. Инсульт, Паркинсон, деменция ва бошқа касалликларда учрайди. Овқат нафас йўлига тушиб, пневмонияга олиб келиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни ўтирган ҳолатда, секин ва кичик бўлакларда овқатлантиринг, овқатни майдалаб ёки қуюқ қилинг. Йўталса ёки бўғилса, овқатни тўхтатинг. Оғир ҳолда зонд керак бўлади.

123. Дисфория (МКБ-10: R45.2)

Мазмуни: Бадқовоқлик, тушкунлик ва жаҳлдорлик аралаш қўпол кайфият. Одам ҳеч нарсадан қониқмайди, тез жаҳли чиқади. Эпилепсия ва руҳий касалликларда кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижознинг бундай ҳолати унинг хоҳиши эмас, касаллик белгиси бўлиши мумкин. Тортишувга киришманг, ҳолатни тинчлантириб, пайт келганда шифокорга айтинг.

124. Дудуқланиш (МКБ-10: F98.5)

Мазмуни: Нутқнинг оқимли бўлмаслиги: товуш ёки бўғинларни такрорлаш, чўзиш ёки гап ўртасида тўхтаб қолиш. Ҳаяжонда кучаяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижознинг гапини тугатиб қўйманг, шошилтирманг, сабр билан тинглаб туринг. Болани масхарадан ҳимоя қилиб, логопедга йўналтиринг; оғир даражаси ПТПК хулосасида махсус таълим асоси бўлиши мумкин.

125. Дюшен мушак дистрофияси (МКБ-10: G71.0)

Мазмуни: Асосан ўғил болалардаги оғир ирсий касаллик: мушаклар кучсизланиб, бола 10–12 ёшда юролмай қолади, сўнг нафас ва юрак мушаклари заифлашади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болага кресло-аравача, ортопедик воситалар, нафас ва юрак назорати керак. Касаллик ирсий; ногиронлик белгиланади, оилага руҳий қўллаб-қувватлаш керак.

Е

126. Елка периартрози (МКБ-10: M75)

Мазмуни: Елка бўғими атрофидаги пайлар ва мушакларнинг яллиғланиши. Қўлни кўтарганда ёки орқага олганда кучли оғриқ пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз кийиниш, сочни тараш ва юкни кўтаришда қийналиши мумкин. Қўлни бир ҳолатда узоқ ушламаслик, дори ва даволаш гимнастикаси ёрдам беради. Узоқ давом этса, ортопед кўригига йўналтиринг.

127. Елка суягининг одатланган чиқиши (МКБ-10: M24.4)

Мазмуни: Елка бўғимининг бир неча марта чиқиб кетиши, ҳатто кичик ҳаракатдан ҳам. Бойламлар бўшашиб қолади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз қўлини баландга кўтарганда ёки орқага ташлаганда эҳтиёт бўлиши керак. Чиққан бўғимни ўзингиз жойига солишга уринманг, шифокорга олиб боринг. Такрорий чиқишларда операция тавсия этилиши мумкин.

128. Елка чигалининг жароҳати (МКБ-10: S14.3)

Мазмуни: Бўйиндан қўлга борувчи нерв тўпламининг шикастланиши. Йўл ҳодисаси, йиқилиш ёки туғруқ жароҳатида бўлади. Қўл бўшашиб, ҳаракатланмай қолади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Чигалнинг тўлиқ шикастланиши ногиронлик белгиланадиган касалликлар рўйхатида. Мижозга реабилитация ва, керак бўлса, қўл учун ортез ёки протез ҳақида маълумот беринг. Тикланиш секин бўлади, сабр қилишга чақиринг.

Ё

129. Ёзув спазми (МКБ-10: F48.8)

Мазмуни: Ёзиш пайтида қўл мушакларининг қисилиб қолиши ёки қалтираши, шу сабабли ёзиш қийинлашади. Бошқа ишларда қўл яхши ишлайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ёзув кўп бўладиган касбдагиларда (бухгалтер, ўқитувчи) учрайди. Мижозга дам олиш, махсус ручка ёки компьютердан фойдаланишни маслаҳат беринг ва неврологга йўналтиринг.

Ж

130. Жигар етишмовчилиги (МКБ-10: K72)

Мазмуни: Жигарнинг вазифаларини (қонни тозалаш, ҳазм қилиш) бажара олмай қолиши. Сариқлик, қорин шиши, қон кетиш, ҳолсизлик, оғир ҳолда чалкашлик кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир ҳолат, бемор тез-тез касалхонага муҳтож. Спиртли ичимлик ва хавфли дорилардан воз кечиш керак. Чалкашлик ёки қонли қайтда зудлик билан 103 га қўнғироқ қилинг.

131. Жигарнинг катталашиши (гепатомегалия) (МКБ-10: R16.0)

Мазмуни: Жигарнинг ҳажми катталашиши. Бу алоҳида касаллик эмас, жигар, юрак ёки қон касалликларининг белгиси.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ўнг қовурға остида оғирлик ёки оғриқдан шикоят қилиши мумкин. Сабабини аниқлаш учун шифокор ва текширувга йўлланг. Спиртли ичимликдан тийилиш лозим.

132. Жигар фибрози (МКБ-10: K74.0)

Мазмуни: Жигарда чандиқ тўқиманинг пайдо бўлиши, одатда узоқ яллиғланиш (гепатит, спирт) оқибатида. Циррознинг олдинги босқичи; ўз вақтида даволанса, жараённи тўхтатиш мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни шифокор назоратига ва керак бўлса гепатитни даволашга йўналтиринг. Спиртли ичимлик ичмаслик ва тўғри овқатланиш муҳим. Эрта босқичда аниқланиши циррознинг олдини олади.

133. Жигар циррози (МКБ-10: K74)

Мазмуни: Жигар тўқимаси чандиққа алмашиб, унинг ишлаши бузилиши. Сабаби — гепатит, спиртли ичимлик. Қорин шиши (асцит), сариқлик, қон кетиш билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Спиртли ичимлик мутлақо мумкин эмас, тузни чеклаш ва дориларни тартиб билан ичиш керак. Оғир босқичда ногиронлик ва парваришга муҳтожлик белгиланади. Қонли қайтда 103 га қўнғироқ қилинг.

134. Жигар ўсмаси (хавфли) (МКБ-10: C22)

Мазмуни: Жигарнинг хавфли ўсмаси (саратон). Қорин оғриғи, озиб кетиш, ҳолсизлик ва сариқлик билан кечади. Кўпинча сурункали гепатит ёки цирроз фонида пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни онкологик диспансерга йўналтиринг ва ногиронлик расмийлаштиришга ёрдам беринг. Беморга ва оилага руҳий қўллаб-қувватлаш керак; кейинги босқичларда паллиатив ёрдам ҳақида маълумот беринг.

З

135. Заиф кўрарлик (кўришнинг кескин пасайиши) (МКБ-10: H54.1; H54.2)

Мазмуни: Кўзойнак билан ҳам яхши кўрмаслик: одам катта нарсаларни кўради, лекин майда ёзувларни, юзларни ва тафсилотларни ажрата олмайди. Тўлиқ кўрлик эмас.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга катта ҳарфли ёзув, яхши ёруғлик ва контрастли ранглар (оқ фонда қора ёзув) қўл келади. Нарсаларни доимий жойида сақланг. Кўриш даражасига қараб ногиронлик ва воситалар (лупа) масаласини кўринг.

136. Заҳарли гепатит (МКБ-10: K71)

Мазмуни: Жигарнинг заҳарли моддалардан зарарланиши: ортиқча дори (масалан, парацетамол), спиртли ичимлик, кимёвий моддалар ёки заҳарли замбуруғлар. Сариқлик, ҳолсизлик, қорин оғриғи пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни заҳарловчи моддадан зудлик билан узоқлаштириш ва шифокорга мурожаат қилиш керак. Мижозга дорини ўзбошимчалик билан кўп ичмаслик ва спиртли ичимликдан сақланиш лозимлигини тушунтиринг.

И

137. Иммунитет танқислиги (туғма) (МКБ-10: D80–D84)

Мазмуни: Боланинг иммунитет тизими туғма заиф бўлиши, шу сабабли у тез-тез ва оғир касалланади, инфекциялар узоқ давом этади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болани инфекциядан ҳимоя қилиш (гавжумдан узоқ тутиш, қўл ювиш) ва эмлаш бўйича шифокор тавсияларига амал қилинг. Оғир шакли ногиронликка асос; оилага ёрдам беринг.

138. Инсульт (бош мия қон айланишининг ўткир бузилиши) (МКБ-10: I64)

Мазмуни: Мияга қон келишининг тўсатдан бузилиши (томир тиқилади ёки ёрилади): бир томон фалажи, нутқ бузилиши, юз қийшайиши, кучли бош оғриғи.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Шошилинч ҳолат: белгилар кўринса, дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг, ҳар дақиқа муҳим. Беморга ҳеч нарса едирманг ва ичирманг. Инсультдан кейин узоқ реабилитация керак бўлади.

139. Инсультнинг оқибатлари (МКБ-10: I69)

Мазмуни: Инсультдан кейин қоладиган муаммолар: тананинг бир томони фалажи, нутқ ва ютиш бузилиши, хотира пасайиши, кайфият ўзгариши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ногиронлик ва парваришга муҳтож бўлиши мумкин. Реабилитация, ётоқ яраларининг олдини олиш ва ёрдамчи воситаларда ёрдам беринг; депрессия кўп учрайди, ҳолатини кузатинг.

140. Инфарктдан кейинги кардиосклероз (МКБ-10: I25.2)

Мазмуни: Юрак инфарктидан кейин юрак мушагида қолган чандиқ. Бу жойлар қисқармайди, шу сабабли юрак кучсизроқ ишлайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга дориларни мунтазам ичиш, оғир жисмоний юкламадан сақланиш ва шифокор назоратида бўлиш керак. Нафас қисилиши ва шиш кучайса, шифокорга мурожаат қилиш лозим. Оғир ҳолларда ногиронлик белгиланади.

141. Инфаркт миокард (МКБ-10: I21)

Мазмуни: Юрак мушаги бир қисмига қон бориши тўхтаб, ҳужайралар ҳалок бўлиши: кўкракда кучли сиқувчи оғриқ, чап қўл ва жағга тарқалади, терлаш, қўрқув.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ҳаёт учун хавфли: дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг. Мижозни ярим ўтирган ҳолатда ушлаб, тинч туришини таъминланг. Кейин реабилитация ва дориларни мунтазам ичиш керак.

142. Иссиқ уриши (офтоб уриши) (МКБ-10: T67.0)

Мазмуни: Қаттиқ иссиқ ёки қуёшда узоқ қолишдан тана ҳароратининг ошиб кетиши: бош оғриғи, кўнгил айниши, ҳолсизлик, чалкашлик, ҳушдан кетиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни дарҳол салқин жойга олиб ўтиб, танасини нам латта билан артинг, сув беринг. Ҳушдан кетган бўлса, 103 га қўнғироқ қилинг. Кексалар ва болалар айниқса хавф остида.

143. Ихтиоз (туғма) (МКБ-10: Q80)

Мазмуни: Терининг туғма қуруқлиги ва пўст ташлаши («балиқ тангачасига» ўхшаш). Тери қалинлашиб, ёрилиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай одамлар терисини кўп намлантириши, махсус кремлардан фойдаланиши керак. Касаллик юқумли эмас, камситманг. Болалар мактабда масхараланишидан ҳимоя қилиниши лозим.

144. Ичак атрезияси (МКБ-10: Q41–Q42)

Мазмуни: Чақалоқда ичакнинг бир қисми туғма битиб қолиши ёки бўлмаслиги, шунинг учун овқат ўта олмайди. Чақалоқ қайт қилади, қорни дам бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Туғилгандан кейин зудлик билан жарроҳлик керак. Операциядан кейин баъзи болаларга стома (қорин деворидаги тешик) қўйилади. Оилага парваришни ўргатинг ва ёрдам имкониятларини тушунтиринг.

145. Ишемик юрак касаллиги (ИЮК) (МКБ-10: I20–I25)

Мазмуни: Юрак томирлари торайиб, юрак мушагига қон ва кислород етарли бормаслиги. Стенокардия (кўкрак оғриғи) ва инфаркт шу касалликка киради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга чекмаслик, ёғли овқатни камайтириш, ҳаракатни ошириш ва дориларни мунтазам ичиш кераклигини тушунтиринг. Кўкракда оғриқ 15 дақиқадан узоқ давом этса, 103 га қўнғироқ қилинг.

К

146. Кандидоз (МКБ-10: B37)

Мазмуни: Замбуруғ (кандида) келтириб чиқарадиган инфекция: оғиз, тери, жинсий аъзолар ёки ички аъзоларда оқ карашлар, қичишиш. Иммунитет пасайганда кўпаяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ОИВ-инфекцияси ва қандли диабетда кўп учрайди. Оғиздаги оқ карашлар кекса ёки ётоқ беморда ютишни қийинлаштириши мумкин. Гигиенага эътибор бериш ва шифокорга йўналтириш керак.

147. Кардиомиопатия (МКБ-10: I42)

Мазмуни: Юрак мушагининг ўзи касалланиши: катталашиши, қалинлашиши ёки кучсизланиши. Юрак қонни яхши ҳайдай олмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Нафас қисилиши, шиш ва тез чарчаш билан кечади. Мижозга юкламадан сақланиш, тузни камайтириш ва дориларни ичишни тушунтиринг. Оғир ҳолларда ногиронлик белгиланади.

148. Кардит (юрак яллиғланиши) (МКБ-10: I51.4)

Мазмуни: Юрак мушаги ёки пардаларининг яллиғланиши. Кўпинча инфекциядан кейин ёки ревматизм фонида ривожланади. Юрак уриши тезлашади, нафас қисилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болаларда томоқ оғриғидан кейин юрак шикоятлари пайдо бўлса, шифокорга олиб бориш керак. Бемор дам олиши ва шифокор кўрсатмасига қатъий амал қилиши лозим.

149. Катаракта (кексалик) (МКБ-10: H25)

Мазмуни: Кўз гавҳарининг хиралашиши: одам нарсаларни тумандек, хира кўради. Кексаларда кўп учрайди ва операция билан даволанади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз йиқилиш, дори ичишда адашиш ва ҳужжатларни ўқий олмаслик хавфи остида. Кўз шифокорига йўналтириб, операцияга ёрдам беринг; операция кўришни одатда яхши тиклайди.

150. Катаракта (туғма) (МКБ-10: Q12.0)

Мазмуни: Боланинг кўз гавҳари туғилишидан хира бўлиши. Бола кам кўриши ёки кўз қорачиғи оқ бўлиб кўриниши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўришни сақлаш учун имкон қадар эрта (кичик ёшда) операция қилиш керак. Ота-оналарга боланинг кўзи оқиш кўринса, дарҳол кўз шифокорига боришни тушунтиринг.

151. Кахексия (ҳолдан тойиш) (МКБ-10: R64)

Мазмуни: Жуда озиб кетиш ва мушакларнинг йўқолиши билан кечадиган оғир ҳолат. Саратон, ОИВ, оғир юрак ва ўпка касалликларининг сўнгги босқичида кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ўзини парвариш қила олмайди, овқатланиш ва ётоқ яраларининг олдини олиш муҳим. Овқатни оз-оздан, тез-тез беринг. Бу ҳолат ўзгалар парваришига муҳтожлик ва паллиатив ёрдам эҳтиёжини кўрсатиши мумкин.

152. Кексалик заифлиги (МКБ-10: R54)

Мазмуни: Кексаларда кучнинг камайиши, тез чарчаш, озиш, секин юриш ва тез-тез йиқилиш. Оддий қариш эмас, парваришга муҳтожликка олиб келувчи ҳолат.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижозни гериатр кўригига йўналтириб, овқатланиши, дориси ва уйдаги хавфсизлигини текширинг. Йиқилишнинг олдини олиш, ёлғизликни камайтириш ва керак бўлса, уйда парвариш хизматини ташкил қилиш лозим.

153. Кератоконъюнктивит (МКБ-10: H16.2)

Мазмуни: Кўзнинг шох пардаси ва қовоқ шиллиқ қаватининг бирга яллиғланиши: кўз қизаради, ёш оқади, оғрийди, ёруғликка қарай олмайди. Одатда вирусли ва юқумли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни кўз шифокорига йўллаш керак. Дастрўмол ва сочиқни алоҳида ишлатиш, қўлни тез-тез ювиш ва кўзни ишқаламаслик юқишнинг олдини олади.

154. Кессон касаллиги (МКБ-10: T70.3)

Мазмуни: Сув остидан ёки юқори босимли жойдан тез кўтарилганда қонда азот пуфакчалари пайдо бўлиши. Бўғим оғриғи, бош айланиши, нафас қисилиши ва фалаж бўлиши мумкин. Ғаввос ва кончиларнинг касб касаллиги.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу касб касаллиги ҳисобланади, меҳнат лаёқатининг йўқотилишини белгилаш учун ТИЭКга йўналтирилади. Мижознинг иш ҳужжатларини тўплашга ёрдам беринг.

155. Кифоз (МКБ-10: M40)

Мазмуни: Умуртқа поғонасининг орқага қараб ортиқча эгилиши («букирлик»). Кексаларда ва ўсмирларда учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир даражаси (3–4) болаларда ПТПК хулосасида махсус таълим асоси бўлади. Мижозга тўғри ўтириш, даволаш гимнастикаси ва керак бўлса корсет ҳақида маълумот беринг.

156. Клайнфельтер синдроми (МКБ-10: Q98)

Мазмуни: Ўғил болаларда қўшимча X хромосома борлиги билан боғлиқ ирсий ҳолат. Бўй баланд, мушаклар заиф, жинсий ривожланиш кечикади, ўқишда ва нутқда қийинчилик бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Эрта аниқланса, гормон даволаш ва таълим ёрдами бериш мумкин. Ўсмирга ҳурмат билан муносабатда бўлиш ва мактабдаги қийинчиликларда педагоглар билан ҳамкорлик қилиш муҳим.

157. Коксартроз (чаноқ-сон бўғими артрози) (МКБ-10: M16)

Мазмуни: Чаноқ-сон бўғими тоғайининг емирилиши. Чов ва сонда оғриқ, юриш қийинлашади, оқсаш пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга ҳасса, вазнни камайтириш ва даволаш гимнастикаси маслаҳат берилади. Оғир ҳолда бўғимни протезлаш (эндопротезлаш) операцияси қилинади. Йиқилиб, сон суягини синдириш хавфи кексаларда юқори.

158. Колобома (кўз тўқималарининг туғма нуқсони) (МКБ-10: Q13.0)

Мазмуни: Кўзнинг рангли пардаси ёки тўр пардасида туғма «тешик» ёки бўшлиқ бўлиши. Қорачиқ ўзига хос шаклда (калит тешигига ўхшаш) бўлади. Кўриш пасайиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўзойнак ва кўз шифокори назорати зарур. Кўриш даражасига қараб боланинг махсус таълим эҳтиёжи ва ногиронлиги белгиланиши мумкин.

159. Кома (МКБ-10: R40.2)

Мазмуни: Чуқур ҳушсизлик ҳолати: одам овоз ва оғриққа жавоб бермайди, кўзини очмайди. Бош мия жароҳати, инсульт, диабет ва заҳарланишда бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ҳаёт учун хавфли ҳолат. Дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг, одамни ёнбошига ётқизинг (қайт қилиб бўғилмаслиги учун), оғзига ҳеч нарса солманг.

160. Контрактура (бўғим ҳаракатининг чекланиши) (МКБ-10: M24.5)

Мазмуни: Бўғим тўлиқ букилмаслиги ёки ёзилмаслиги, мушак ва пайлар қисқариб қолгани сабабли. Узоқ ётган, фалаж ёки куйган беморларда кўп учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ётоқ беморларда контрактуранинг олдини олиш учун бўғимларни кунига бир неча марта секин ҳаракатлантириш ва ҳолатини ўзгартириш керак. Оғир контрактуралар ногиронлик ва парваришга муҳтожлик асоси бўлиши мумкин.

161. Конъюнктивит (МКБ-10: H10)

Мазмуни: Кўзнинг ташқи шиллиқ қаватининг яллиғланиши: кўз қизаради, ёш оқади, қовоқлар йиринг билан ёпишиб қолади. Вирус, бактерия ёки аллергиядан бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Юқумли бўлса, мижоз ўз дастрўмоли ва сочиғини алоҳида ишлатиши, қўлини тез-тез ювиши керак. Мактаб ёки болалар боғчасида бошқа болаларга юқиши мумкин. Шифокорга мурожаат қилишни тавсия этинг.

162. Корнелия де Ланге синдроми (МКБ-10: Q87.1)

Мазмуни: Нодир ирсий синдром: болада ўзига хос юз тузилиши, паст бўй, қўл-оёқ нуқсонлари, ақлий ривожланишнинг орқада қолиши ва овқат ҳазм қилиш муаммолари.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болаларга кўп мутахассис (невролог, гастроэнтеролог, логопед) назорати керак. Эрта аралашув ва ПТПК орқали таълим йўналишини аниқлашга ёрдам беринг; оилага руҳий қўллаб-қувватлаш керак.

163. Кретинизм (йод танқислигидан, микседематоз тури) (МКБ-10: E00.1)

Мазмуни: Йод танқислиги туфайли қалқонсимон без ишламаслигидан бола туғилгандан бошлаб ақлий ва жисмоний ривожланишда орқада қолиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Эрта аниқланса, даволаш самарали. Оилага йодланган туздан фойдаланишни тушунтиринг; ақлий нуқсон ва ногиронлик масаласида ПТПК ва ТИЭКка йўналтиринг.

164. Крон касаллиги (МКБ-10: K50)

Мазмуни: Ҳазм йўлларининг (кўпинча ингичка ичак) сурункали яллиғланиши. Қорин оғриғи, ич кетиш, озиш ва ҳолсизлик билан кечади, ёмонлашиш ва яхшиланиш даврлари навбатлашади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ўзини тез-тез ёмон сезиши мумкин, шунинг учун иш ва ўқишда тушуниш керак. Дориларни мунтазам ичиш ва парҳезга риоя қилиш муҳим. Оғир ҳолларда ногиронлик белгиланиши мумкин.

165. Куйдирги (сибир яраси) (МКБ-10: A22)

Мазмуни: Касал чорва моллари ёки уларнинг маҳсулотлари орқали юқадиган оғир юқумли касаллик. Терида қора яра пайдо бўлади, оғир шаклида ўпка ёки ичак зарарланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касал ҳайвон билан алоқа қилган ёки ёмон пиширилган гўшт еган мижозда терида қора яра пайдо бўлса, зудлик билан шифокорга ёки санитария-эпидемиология хизматига хабар беринг.

166. Куйиш (иссиқлик ва кимёвий) (МКБ-10: T20–T32)

Мазмуни: Иссиқ суюқлик, олов, қайноқ буюм ёки кимёвий модда сабабли терининг шикастланиши. Куйиш чуқурлиги бўйича 1–4 даражага бўлинади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Куйган жойни дарҳол 10–15 дақиқа салқин (муздек эмас) сув остида ушлаб туринг, пуфакларни ёрманг ва мойли крем суртманг. Катта юзали куйишда 103 га қўнғироқ қилинг. Боланинг куйиши оилада назоратсизлик ҳақида хабар бериши мумкин: уй шароитини текширинг. Тананинг 30% дан кўпини қоплаган чуқур куйиш ногиронлик асоси бўлади.

167. Курак суяги синиши (МКБ-10: S42.1)

Мазмуни: Елка камарининг курак суягида синиш, одатда кучли зарба ёки йиқилишдан. Елка ва кўкракда оғриқ, қўлни кўтара олмаслик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижоз бир неча ҳафта қўлидан кам фойдаланади. Кийиниш, овқатланиш ва ювинишда ёрдам керак. Қўлни боғлаш шифокор кўрсатмаси бўйича, кейин даволаш гимнастикаси бошланади.

168. Кушинг синдроми (Иценко–Кушинг) (МКБ-10: E24)

Мазмуни: Организмда кортизол гормони ортиқча бўлиши: юз юмалоқланади, қорин семиради, қўл-оёқлар ориқлайди, қон босими ва шакар ошади, суяклар мўртлашади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга ташқи кўриниши ўзгаргани учун руҳий қўллаб-қувватлаш керак. Ногиронлик белгиланиши мумкин. Бошқа сабаб билан кортизон гормонларини узоқ ичиш ҳам шундай ҳолатни келтириб чиқариши мумкин, шифокорсиз дорини тўхтатмаслик керак.

169. Кўз гавҳарининг силжиши ва чиқиши (МКБ-10: Q12.1; H27.1)

Мазмуни: Кўз гавҳари (линза) ўз жойидан силжиши ёки тўлиқ чиқиб кетиши. Туғма бўлиши ёки жароҳатдан кейин пайдо бўлиши мумкин. Кўриш бузилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўз шифокори кўриги ва, керак бўлса, жарроҳлик ёрдами керак. Болада кўриш пасайиши аниқланса, махсус таълим йўналиши масаласини кўтаринг.

170. Кўзнинг туғма аномалиялари (МКБ-10: Q13–Q15)

Мазмуни: Кўзнинг туғма ривожланиш нуқсонлари (камалак парда, тўр парда, кўриш нерви ва бошқа қисмлар). Кўриш турли даражада пасаяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болаларга эрта кўз назорати, кўзойнак ва махсус таълим кўмаги керак. ПТПК хулосаси билан таълим йўналиши аниқланади. Кўриш ўткирлигига қараб ногиронлик белгиланиши мумкин.

171. Кўкрак бези саратони (МКБ-10: C50)

Мазмуни: Кўкрак безидаги хавфли ўсма. Кўпинча кўкракда қаттиқ тугун, сўрғичдан суюқлик ёки тери ўзгариши билан пайдо бўлади. Эрта аниқланса, яхши даволанади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Аёлларни ҳар йили тиббий кўрикдан ўтишга ва кўкракни ўз-ўзини текширишга ундаш муҳим. Операциядан кейин кўкрак бези протези билан таъминлашда ёрдам беринг, руҳий қўллаб-қувватлаш кўрсатиш керак.

172. Кўкрак қафаси деформацияси (воронкасимон, товуқ кўкракли) (МКБ-10: Q67.6; Q67.7)

Мазмуни: Кўкрак қафасининг туғма ботиқлиги (воронкасимон) ёки олдинга бўртиб чиқиши (товуқ кўкракли). Оғир ҳолда юрак ва ўпка ишига халақит беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир (2–4) даражаси болалар учун ПТПК хулосасида асос бўлиши мумкин. Ўсмирлар ташқи кўриниши учун уялишади, руҳий қўллаб-қувватлаш керак. Даволаш гимнастикаси ва, зарур бўлса, жарроҳлик ёрдами мавжуд.

173. Кўриш нервининг атрофияси (МКБ-10: H47.2)

Мазмуни: Кўзни мия билан боғловчи кўриш нервининг нобуд бўлиши. Кўриш аста-секин ёки тўсатдан пасаяди ва кўзойнак ёрдам бермайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўриш даражасига қараб ногиронлик, ҳасса, овозли воситалар ва Брайл алифбоси керак бўлиши мумкин. Сабабини аниқлаш учун кўз шифокори ва неврологга мурожаат қилиш лозим.

174. Кўр-кар-соқовлик (МКБ-10: H90.3; H54.0)

Мазмуни: Кўриш ва эшитишнинг бир вақтда йўқолиши ёки кескин пасайиши. Одам дунё билан кўпинча фақат сезиш (терининг сезгиси) орқали алоқа қилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай одам ёрдамчи ва махсус таржимонсиз кундалик ишларни эплай олмайди. Мулоқот қўл ишоралари ва сезиш орқали бўлади. Юқори даражали ногиронлик ва парваришга муҳтожлик белгиланади.

Л

175. Ларингит (сурункали) (МКБ-10: J37.0)

Мазмуни: Ҳиқилдоқ шиллиқ қаватининг узоқ давом этадиган яллиғланиши. Овоз бўғилади, қуруқ йўтал ва томоқда қичишиш бўлади. Чекиш, чанг ва овозни зўриқтириш кучайтиради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Овози билан ишлайдиган одамларда (ўқитувчи, ашулачи) меҳнатга таъсир қилади. Мижозга чекмаслик, овозни асраш ва ЛОР шифокорига боришни тушунтиринг. Овоз бўғилиши 2–3 ҳафтадан ортиқ давом этса, текширтириш керак.

176. Лей касаллиги (митохондриал энцефалопатия) (МКБ-10: G31.8)

Мазмуни: Нодир ирсий касаллик: бола ҳужайралари энергия ишлаб чиқара олмайди, шу сабабли бош мия зарарланади. Мушаклар бўшашади, ҳаракат ва нутқ орқага кетади, нафас бузилади. Касаллик аста-секин оғирлашиб боради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай бола доимий парваришга муҳтож бўлади. Оилага руҳий қўллаб-қувватлаш, паллиатив ёрдам ва техник воситалар (кресло-аравача, махсус ўрин) масаласида кўмак беринг. Ногиронлик ва парваришга муҳтожлик белгиланишига ёрдам беринг.

177. Лейкодистрофия (МКБ-10: E75.2)

Мазмуни: Бош мия оқ моддасининг ирсий касаллиги. Бола аввал соғлом ўсади, кейин ҳаракати, кўриши, эшитиши ва ақли аста-секин ёмонлашади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик зўрайиб боради, бола ва оилага узоқ муддатли ёрдам керак. Парвариш, ётоқ яраларининг олдини олиш, овқатлантириш масалаларида оилани ўргатинг. Ногиронлик белгиланадиган касалликлар рўйхатига киради.

178. Лейкоз (қон саратони) (МКБ-10: C91–C95)

Мазмуни: Суяк кўмигида ғайритабиий қон ҳужайралари кўпайиб, соғлом қон ҳужайраларини сиқиб чиқариши. Ҳолсизлик, рангпарлик, тез-тез инфекция, қон кетиш, иситма белгилари бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Узоқ даволаниш (химиотерапия) керак бўлади, бемор инфекциядан эҳтиёт бўлиши лозим. Болалар ва катталарнинг оилаларига молиявий ва руҳий ёрдам беринг. Ногиронлик ва даволаниш учун йўлланма расмийлаштиришга кўмаклашинг.

179. Лимфоаденопатия (МКБ-10: R59)

Мазмуни: Лимфа тугунларининг катталашиши (бўйин, қўлтиқ ёки чов соҳасида). Кўпинча инфекцияга жавоб бўлади, баъзан жиддий касаллик (лимфома, лейкоз) белгиси.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ўзи оғримайдиган, тобора катталашаётган тугун бўлса, шифокорга боришни тавсия қилинг. Қўрқмаслик ва кечиктирмасликни тушунтиринг.

180. Лимфоид лейкоз (МКБ-10: C91)

Мазмуни: Қон саратонининг бир тури: ўсма лимфоцит деб аталувчи ҳужайралардан ривожланади. Болаларда энг кўп учрайдиган қон саратони.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болалар даволанса, кўпинча тузалади, лекин даволаниш узоқ давом этади. Оила касалхонага қатнаш, мактабдан узоқ қолиш ва молиявий қийинчиликларда ёрдамга муҳтож. Бола ўқишни давом эттириши учун мактаб билан келишинг.

181. Лимфома (МКБ-10: C81–C85)

Мазмуни: Лимфа тизимининг хавфли ўсмаси. Лимфа тугунлари катталашади, ҳарорат, кечаси терлаш ва озиш бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бемор онкологик даволашга муҳтож. Йўлланма, ногиронлик ва даволаниш даврида иш ёки ўқиш масалаларида ёрдам беринг. Руҳий қўллаб-қувватлаш муҳим.

182. Лимфостаз (фил оёқлик) (МКБ-10: I89.0)

Мазмуни: Лимфа суюқлигининг чиқиб кета олмаслиги сабабли оёқ ёки қўлнинг доимий шишиб, йўғонлашиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Шишган оёқ юришни қийинлаштиради, тери ёрилса, инфекция тушади. Мижозга терини тоза сақлаш, оёқни юқори кўтариб дам олиш ва эластик бинт ёки чулкдан фойдаланишни тушунтиринг.

M

183. Маймоқлик (туғма) (МКБ-10: Q66)

Мазмуни: Боланинг оёқ панжаси туғма ичкарига қараб қийшайиб туриши. Эрта даволанса (гипс, махсус ортез, баъзан операция), деярли тузалади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ота-оналарга болани туғилгандан кейин зудлик билан ортопедга олиб боришни тушунтиринг. Даволаш кечикса, бола оқсаб қолиши мумкин. Даволаш давомида махсус пойабзал ва ортезлар керак бўлади.

184. Мальабсорбция (ичакда сўрилиш бузилиши) (МКБ-10: K90)

Мазмуни: Ичак овқат моддаларини (оқсил, ёғ, витаминлар) яхши сўра олмаслиги. Узоқ давом этган ич кетиш, озиш, ҳолсизлик ва шиш пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз озиб кетиши ва ҳолсизланиши мумкин, шунинг учун овқатланишини кузатинг. Шифокор тавсия қилган парҳезга риоя қилишга ёрдам беринг. Болаларда ўсиш орқада қолиши мумкин.

185. Манқалик (бурундан гапириш, ринолалия) (МКБ-10: R49.2)

Мазмуни: Нутқ товушларининг бурундан чиқиши. Сабаби — танглай нуқсони («бўри оғиз») ёки бурун-томоқ мушаклари заифлиги.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болага жарроҳлик ва логопед ёрдами керак. Болани масхара қилишдан ҳимоя қилинг, ота-оналарни эрта даволашга йўналтиринг.

186. Марфан синдроми (МКБ-10: Q87.4)

Мазмуни: Бириктирувчи тўқиманинг ирсий касаллиги: бўй баланд, қўл-оёқ ва бармоқлар жуда узун, кўриш ёмон, юрак ва йирик қон томирлар ҳам зарарланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай одамларга оғир жисмоний юклама ва тўқнашув спорти мумкин эмас, чунки йирик қон томир ёрилиши хавфли. Кўз ва юрак шифокорлари назоратида бўлишини таъминланг. Мактабда жисмоний тарбияда енгиллик керак бўлиши мумкин.

187. Менингит (мия пардалари яллиғланиши) (МКБ-10: G00–G03)

Мазмуни: Бош ва орқа мияни ўраб турган пардаларнинг яллиғланиши, кўпинча инфекциядан. Кучли бош оғриғи, юқори ҳарорат, бўйин мушакларининг қотиши, қайт қилиш бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Хавфли шошилинч ҳолат, 103 га дарҳол қўнғироқ қилинг. Касалликдан кейин эшитиш, кўриш ва ақлий ривожланиш бузилиши қолиши мумкин. Болаларнинг оилаларига эмлашнинг аҳамиятини тушунтиринг.

188. Метастаз (МКБ-10: C79)

Мазмуни: Хавфли ўсма ҳужайраларининг асосий жойидан бошқа аъзоларга (суяк, жигар, ўпка, мия) тарқалиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Метастаз пайдо бўлиши касалликнинг оғир босқичига ўтганини билдиради. Бемор кучли оғриқ ва ҳолсизликка эга бўлиши мумкин, паллиатив ёрдам ва оилага руҳий қўллаб-қувватлаш зарур.

189. Меъда саратони (МКБ-10: C16)

Мазмуни: Меъданинг хавфли ўсмаси. Бошида белгиси билинмайди, кейин қорин оғриғи, иштаҳа пасайиши, озиш, қора рангли нажас пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Узоқ давом этган меъда оғриғи ва озиш бўлса, мижозни кечиктирмай текширувга юборинг. Онкологик беморга ногиронлик, овқатланиш ва парваришда ёрдам беринг.

190. Миастения (МКБ-10: G70.0)

Мазмуни: Мушаклар тез толиқиб қолиши билан кечадиган касаллик: қовоқлар тушиб кетади, юз, ютиш ва нафас мушаклари кучсизланади. Кечга томон кучаяди, дам олингандан кейин енгиллашади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дориларни вақтида ичиш жуда муҳим. Ютиш ёки нафас қийинлашса, зудлик билан 103 га қўнғироқ қилинг. Мижозга энг оғир ишларни кундузги соатларга режалаштиришни маслаҳат беринг.

191. Миелодиспластик синдром (МКБ-10: D46)

Мазмуни: Суяк кўмигининг қон ҳужайраларини меъёрида ишлаб чиқара олмаслиги. Кўпинча кексаларда учрайди, камқонлик, инфекция ва қон кетиш хавфи бор.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз тез-тез қон қуйишга муҳтож бўлиши мумкин. Ҳолсизлик ва инфекция хавфини ҳисобга олиб, парвариш ва шифокорга қатнашда ёрдам беринг.

192. Миелоид лейкоз (МКБ-10: C92)

Мазмуни: Қон саратонининг бир тури: суяк кўмигидаги миелоид ҳужайралардан ривожланади. Тез ривожланиши мумкин, инфекция, қон кетиш ва ҳолсизлик билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Шошилинч ва узоқ даволаш керак, бемор касалхонада кўп вақт ўтказади. Оила учун молиявий ва руҳий қўллаб-қувватлаш зарур, ногиронлик расмийлаштиришга ёрдам беринг.

193. Микрофтальм (МКБ-10: Q11.2)

Мазмуни: Кўз олмасининг туғма кичик бўлиши. Кўриш пасаяди ёки умуман бўлмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болага кўз шифокори назорати ва кўриш даражасига қараб махсус таълим йўналиши керак. Тўлиқ кўрмаса, Брайл ёзуви ва ҳассага ўргатиш керак.

194. Микроцефалия (МКБ-10: Q02)

Мазмуни: Бош чаноқ ва мия ҳажмининг меъёридан кичик бўлиши. Одатда ақлий ривожланиш орқада қолади, тутқаноқ ва ҳаракат бузилишлари бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болага эрта аралашув, дефектолог ва невролог назорати керак. ПТПК орқали таълим йўналишини аниқлаш ва оилага ногиронлик белгилашда ёрдам беринг.

195. Минимал онг ҳолати (МКБ-10: R40.2)

Мазмуни: Оғир мия шикастидан кейин одам кўзи очиқ, лекин онги жуда чекланган: баъзан оддий топшириққа жавоб беради ёки қарайди, лекин мулоқот қила олмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай бемор тўлиқ парваришга муҳтож: овқатлантириш, ётоқ яраларининг олдини олиш, ҳолатини ўзгартириш. Оилага ҳолатнинг қандай бўлишини тушунтиринг ва руҳий қўллаб-қувватланг.

196. Миопатия (МКБ-10: G72)

Мазмуни: Мушакларнинг ўзи касалланиши натижасида мушаклар кучсизланиши. Асаб касаллигидан эмас, мушакларнинг ўзидан бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз зинадан чиқиш, ўриндан туриш ва қўлини кўтаришда қийналади. Йиқилишлардан сақланиш, даволаш гимнастикаси ва керак бўлса техник воситалар билан таъминлашга ёрдам беринг.

197. Миопия (яқинни кўрарлик) (МКБ-10: H52.1)

Мазмуни: Узоқдаги нарсаларни хира, яқин нарсаларни яхши кўриш. Кўзойнак ёки линза билан тузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болада бошланса, ўқишга таъсир қилади: мактабда олд партага ўтқазиш керак. Юқори даражадаги (оғир) яқинни кўрарлик ногиронлик белгиланадиган ҳолатлар рўйхатига киради.

198. Миофиброз ва мушак йиртилиши (МКБ-10: M62.6)

Мазмуни: Мушак толаларининг зўриқиш, зарба ёки ортиқча юкдан йиртилиши ва чандиқ пайдо бўлиши. Оғриқ ва ҳаракат чекланиши бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга дам олиш, эҳтиёт бўлиш ва шифокор тавсия қилган машқларни тушунтиринг. Жисмоний меҳнат қилувчиларда меҳнат лаёқатига таъсир қилиши мумкин.

199. Мия лат ейиши (контузия) (МКБ-10: S06.2)

Мазмуни: Бош мия тўқимасининг зарбадан майда қон қуйилиши билан шикастланиши. Чайқалишдан оғирроқ: ҳушдан кетиш, чалкашлик, нутқ ёки ҳаракат бузилиши бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дарҳол шифокорга олиб бориш керак. Оқибатида хотира, диққат ва кайфият ўзгариши қолиши мумкин, мижозни бундай ҳолатда кузатинг ва реабилитацияга йўналтиринг.

200. Мия чайқалиши (комоция) (МКБ-10: S06.0)

Мазмуни: Бошга зарбадан кейин мия вақтинча ишламай қолиши: қисқа муддатли ҳушдан кетиш, бош оғриғи, кўнгил айниши, бош айланиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Жароҳатдан кейин дарҳол шифокорга мурожаат қилинг. Бир неча кун тинч ётиш, экран ва зўриқишдан сақланиш керак. Қайт, ҳушсизлик ёки чалкашлик кучайса, 103 га қўнғироқ қилинг.

201. Мия қон айланишининг бузилиши (цереброваскуляр касалликлар) (МКБ-10: I60–I69)

Мазмуни: Бош мия қон томирлари касалликлари гуруҳи: инсульт, қон қуйилиш, томир торайиши ва уларнинг оқибатлари.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қон босими юқори бўлган ва кекса мижозлар хавф гуруҳида. Босимни назорат қилиш, чекмаслик ва дориларни мунтазам ичиш инсультнинг олдини олади. Оқибатлар ногиронлик ва парваришга муҳтожликка олиб келиши мумкин.

202. Моноцитар лейкоз (МКБ-10: C93)

Мазмуни: Қон саратонининг бир тури: ўсма моноцит деб аталувчи оқ қон ҳужайраларидан ривожланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бошқа лейкозлар каби узоқ даволаш, инфекциядан сақланиш ва оилага қўллаб-қувватлаш керак. Ногиронлик ва даволаниш масалаларида кўмак беринг.

203. Мослашув бузилиши (МКБ-10: F43.2)

Мазмуни: Ҳаётдаги катта ўзгариш (ишдан айрилиш, кўчиш, яқинини йўқотиш, касаллик) туфайли пайдо бўлган тушкунлик, хавотир, уйқу бузилиши ва ишга қобилиятнинг пасайиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу кўпинча вақтинчалик ҳолат, суҳбат ва қўллаб-қувватлаш ёрдам беради. Мижозни тинглаб, психолог ёрдамига йўналтиринг. Узоқ давом этса, депрессияга айланиши мумкин.

204. Мохов (лепра) (МКБ-10: A30)

Мазмуни: Секин ривожланувчи юқумли касаллик: тери, нервлар ва шиллиқ қаватлар зарарланади. Терида доғлар, сезувчанлик йўқолиши ва шакл ўзгаришлари бўлади. Замонавий даво билан тузалади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касалликка нисбатан қўрқув ва камситиш кучли, шунинг учун мижоз ижтимоий жиҳатдан ёлғиз қолиши мумкин. Оддий мулоқот билан деярли юқмайди. Мижознинг ҳуқуқларини ҳимоя қилинг ва даволанишини назорат қилинг.

205. Муковисцидоз (кистозли фиброз) (МКБ-10: E84)

Мазмуни: Ирсий касаллик: ўпка ва ҳазм аъзоларида қуюқ ёпишқоқ шилимшиқ тўпланади. Бола тез-тез йўталади, зотилжам билан касалланади, яхши ўсмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болага мунтазам дори, нафас машқлари ва махсус овқатланиш керак. Инфекциядан сақланиш муҳим. Касаллик оғир ва узоқ даволаш талаб этади, оилага молиявий ва руҳий ёрдам бериш керак.

206. Мукополисахаридозлар (МКБ-10: E76)

Мазмуни: Модда алмашинувининг нодир ирсий касалликлар гуруҳи: организмда мураккаб қандлар тўпланиб, суяклар, юрак, кўз ва миянинг шикастланишига олиб келади. Бола ўсиши ва ақли орқада қолади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик аста-секин зўрайиб боради. Оилага узоқ муддатли ёрдам керак. Ногиронлик ва таълим йўналишини ПТПК орқали аниқлашда кўмак беринг.

207. Мушак атрофияси (спинал) (МКБ-10: G12)

Мазмуни: Орқа миядаги ҳаракат нерв ҳужайраларининг нобуд бўлиши натижасида мушакларнинг аста-секин қуриб, кучсизланиши. Чақалоқ ёки болаларда оғир шакли бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз юролмай, ютиш ва нафасда қийналиши мумкин. Кресло-аравача, нафасни қўллаб-қувватловчи мосламалар ва доимий парвариш керак. Оилага ногиронлик белгилаш ва руҳий қўллаб-қувватлашда ёрдам беринг.

208. Мушак дистрофияси (зўрайиб борувчи) (МКБ-10: G71)

Мазмуни: Мушаклар аста-секин кучсизланиб, қуриб борадиган ирсий касалликлар гуруҳи. Бунга Дюшен касаллиги ҳам киради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик секин зўрайиб боради, мижоз вақт ўтиши билан кресло-аравача ва парваришга муҳтож бўлади. Йиқилишдан сақланиш, нафас ва юрак назорати, оилага руҳий қўллаб-қувватлаш зарур.

Н

209. Нажас оқмаси (МКБ-10: K63.2)

Мазмуни: Ичак билан тери ёки бошқа аъзо ўртасида ҳосил бўлган ғайритабиий тешик (канал), шу орқали нажас ташқарига ёки нотўғри жойга чиқади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ҳолатидан қаттиқ уялади ва ўзини ёлғиз ҳис қилади. Тери парвариши, гигиена ва жарроҳга мурожаат қилиш керак. Бундай ҳолат одамни ижтимоий ҳаётдан узиб қўйиши мумкин, шунинг учун руҳий қўллаб-қувватланг.

210. Нажас тута олмаслик (МКБ-10: R15)

Мазмуни: Нажаснинг беихтиёр чиқиб кетиши. Кексаларда, асаб касалликлари ва орқа мия жароҳатларида учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни камситманг, бу касаллик белгиси. Тез-тез ювиш, гигиеник воситалар (памперс) ва терини парваришлаш керак. Ҳожатхонага қулай йўл бўлишини таъминланг. Бу ўзгалар парваришига муҳтожликнинг муҳим белгиси.

211. Наркомания (гиёҳвандлик) (МКБ-10: F11–F16; F19)

Мазмуни: Гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишга касаллик даражасидаги қарамлик: одам модданисиз ўзини эплай олмайди, ундан воз кеча олмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни айбламасдан, наркология хизматига ва даволанишга йўналтиринг. Оила аъзоларига ёрдам беринг. Тикланиш давомида иш, оила ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш муҳим. Ҳаддан ташқари кўп миқдорда қабул қилинганда (овердоз) ёки ҳушдан кетганда 103 га қўнғироқ қилинг.

212. Нафас қисилиши (МКБ-10: R06.0)

Мазмуни: Нафас етишмаслиги ҳисси, нафас олишнинг қийинлашиши ёки тезлашиши. Юрак, ўпка касалликлари, камқонликда, баъзан ҳаяжонда ҳам кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тўсатдан кучли нафас қисилиши бўлса ёки лаблар кўкарса, 103 га қўнғироқ қилинг. Мижозни ярим ўтирган ҳолатда ўтқазиб, тор кийимини бўшатинг ва тоза ҳаво кириши учун деразани очинг.

213. Невроз ва неврастения (МКБ-10: F48)

Мазмуни: Руҳий зўриқиш ва стрессдан пайдо бўлган асаб тизими ҳолсизлиги: тез чарчаш, асабийлик, уйқу бузилиши, бош оғриғи. Бу руҳий касаллик эмас.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга дам олиш, тартибли кун режими, енгил жисмоний машқ ва суҳбат ёрдам беради. Узоқ давом этса, психолог ёки неврологга йўналтиринг. Мижоз билан тинч ва тушунувчан бўлинг.

214. Нейродегенератив касалликлар (зўрайиб борувчи) (МКБ-10: G30–G32; G35; G37; G60–G64)

Мазмуни: Асаб тизими ҳужайралари аста-секин нобуд бўлиб, ҳаракат, хотира ва бошқа вазифалар ёмонлашиб борадиган касалликлар гуруҳи (Альцгеймер, Паркинсон, кўп ўчоқли склероз ва ҳоказо).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай касалликлар тўлиқ тузалмайди, мижознинг эҳтиёжи вақт ўтиши билан ошади. Оилага парвариш бўйича ўргатиш, ногиронлик ва ўзгалар парваришига муҳтожлик масаласида кўмак ва руҳий қўллаб-қувватлаш керак.

215. Нейросенсор карлик (МКБ-10: H90.3)

Мазмуни: Ички қулоқ ёки эшитиш нервининг зарарланиши сабабли эшитиш йўқолиши. Эшитиш мосламаси енгил ва ўрта даражада ёрдам беради; оғир ҳолларда кохлеар имплант қўлланилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз билан юзма-юз, равшан гаплашинг, имо-ишора тилидан фойдаланинг. Болалар учун эрта аниқлаш, эшитиш мосламаси ва нутқ машғулотлари жуда муҳим. Ногиронлик ва техник воситалар масаласида ёрдам беринг.

216. Нейрофиброматоз (МКБ-10: Q85.0)

Мазмуни: Ирсий касаллик: терида «қаҳва-сут» рангли доғлар ва нерв бўйлаб кўп сонли юмшоқ ўсмалар (тугунлар) пайдо бўлади. Ўсмалар одатда хавфсиз, лекин ўсиб, оғриқ ва нуқсон келтириши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ташқи кўриниш сабабли мижоз камситилиши мумкин, руҳий қўллаб-қувватланг. Мунтазам шифокор кўриги керак. Касаллик ирсий бўлгани сабабли оилани маслаҳатга йўналтиринг.

217. Нефрит (МКБ-10: N05)

Мазмуни: Буйракларнинг яллиғланиши. Шиш, қон босими ошиши, сийдикда қон ёки оқсил пайдо бўлиши билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга парҳез (тузни камайтириш), дориларни вақтида ичиш ва шамоллашдан сақланиш муҳимлигини тушунтиринг. Сурункали шаклида буйрак етишмовчилиги ривожланиши мумкин.

218. Нефротик синдром (МКБ-10: N04)

Мазмуни: Буйрак касаллиги: сийдик орқали кўп оқсил йўқотилади, организмда шиш пайдо бўлади (айниқса юз ва оёқларда).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болаларда кўп учрайди. Даволаш узоқ давом этади, парҳез ва дориларга (гормонларга) қатъий риоя қилиш керак. Инфекциядан сақланиш муҳим. Мактаб ва боғча билан келишиб, болага қулай шароит яратинг.

219. Ниманн–Пик касаллиги (МКБ-10: E75.2)

Мазмуни: Нодир ирсий касаллик: организм ҳужайраларида ёғсимон модда тўпланиб, жигар, талоқ ва бош мия зарарланади. Бола ақли ва ҳаракати аста-секин орқага кетади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик зўрайиб боради, оилага узоқ муддатли парвариш ва руҳий қўллаб-қувватлаш керак. Ногиронлик белгилаш ва паллиатив ёрдам масаласида кўмак беринг.

220. Нистагм (кўзнинг беихтиёр ҳаракати) (МКБ-10: H55)

Мазмуни: Кўз олмаларининг беихтиёр тез-тез тебраниши. Кўриш пасайиши ёки асаб касалликлари билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай одам кўрганда қийналади, ўқишда зўриқади. Болалар мактабда яхши ёритилган жойда ўтириши ва катта ёзувдан фойдаланиши керак. Сабабини аниқлаш учун кўз шифокорига йўналтиринг.

221. Нооперабел юрак-қон томир касаллиги (МКБ-10: I51.9)

Мазмуни: Юрак ёки қон томир касаллиги, унга операция қилиб бўлмайдиган ҳолат (жуда оғир бўлгани ёки соғлиғи сабабли).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз дори билан қўллаб-қувватланади, оғир жисмоний иш ва стрессдан сақланиши керак. Ногиронлик ва ўзгалар парваришига муҳтожлик масаласини кўриб чиқинг. Руҳий қўллаб-қувватлаш зарур.

222. Носпецифик ярали колит (МКБ-10: K51)

Мазмуни: Йўғон ичак шиллиқ қаватининг сурункали яллиғланиши ва яралар пайдо бўлиши. Қонли ич кетиш, қорин оғриғи, озиш билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик зўрайиш ва тинч даврлар билан кечади. Мижозга парҳез ва дориларни мунтазам ичиш муҳимлигини тушунтиринг. Оғир ҳолларда ногиронлик белгиланиши ва стома керак бўлиши мумкин.

223. Нунан синдроми (МКБ-10: Q87.1)

Мазмуни: Ирсий синдром: ўзига хос юз тузилиши, паст бўй, юрак нуқсони ва кўпинча ўқишда қийинчилик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Юрак шифокори назорати зарур. Таълим ва ривожланишда ёрдам керак бўлиши мумкин: ПТПК орқали йўналиш аниқланади. Оилага эрта аралашув хизматини таништиринг.

224. Нур касаллиги (радиация таъсири) (МКБ-10: T66)

Мазмуни: Юқори радиация таъсири натижасида пайдо бўладиган касаллик: кўнгил айниши, ҳолсизлик, тери ва қон ҳужайраларининг шикастланиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Радиация таъсирида қолган мижозни зудлик билан шифокорга йўналтиринг. Оғир шакли ва узоқ оқибатлари (саратон) ногиронлик белгилаш учун асос бўлади. Тегишли ҳужжатларни йиғишга ёрдам беринг.

225. Нутқ ривожланишининг бузилиши (МКБ-10: F80)

Мазмуни: Болада нутқнинг ёшига мос ривожланмаслиги: гапира бошлашнинг кечикиши, сўзларни нотўғри талаффуз қилиш ёки жумла тузишдаги қийинчиликлар.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ота-оналарга болани эрта логопедга олиб боришни тушунтиринг, кутиб ўтирманг. Эшитиш қобилиятини ҳам текширтиринг. ПТПК орқали таълимнинг қулай шакли аниқланади.

О

226. Облитерацияловчи эндартериит (МКБ-10: I70.2)

Мазмуни: Оёқ артерияларининг торайиб, берк бўлиб қолиши. Юрганда оёқда оғриқ пайдо бўлиб, тўхтаб дам олганда ўтади. Чекувчи эркакларда кўп учрайди. Оғир ҳолда оёқ гангренаси ривожланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга чекишни ташлашнинг аҳамиятини, оёқни совуқдан ва жароҳатдан асрашни тушунтиринг. Оёқда яра пайдо бўлса, шифокорга дарҳол боринг. Оғир ҳолда ногиронлик ва протез керак бўлиши мумкин.

227. Обсессив-компульсив бузилиш (МКБ-10: F42)

Мазмуни: Руҳий ҳолат: одам мажбурий фикрлар (масалан, «қўлим кир») ва уларни босиш учун такрорий ҳаракатлар (тинмай қўл ювиш, текшириш) билан қийналади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз бунинг ортиқчалигини тушунади, лекин ўзини тўхтата олмайди. Уни «ақлдан озган» деб ҳисобламанг ва мажбурламанг. Психотерапевт ва психиатр ёрдами ижобий натижа беради.

228. Овоз бурмалари тугунлари (МКБ-10: J38.2)

Мазмуни: Овоз бурмаларида (ҳиқилдоқдаги овоз ҳосил қилувчи пардалар) кичик қаттиқ тугунлар (қалинлашишлар). Овоз бўғилади ва тез чарчайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўпинча овозни кўп зўриқтирадиган кишиларда учрайди (ўқитувчилар, ашулачилар). ЛОР шифокори кўриги, овозга дам бериш ва камроқ қичқириш ёрдам беради.

229. ОИВ-инфекцияси (одам иммунитет танқислиги вируси) (МКБ-10: B20–B24)

Мазмуни: Иммунитет тизимини аста-секин заифлаштирувчи вирус. Уни даволаш учун антиретровирус терапия бор: дориларни мунтазам ичиб, одам узоқ яшаши ва бошқаларга вирусни юқтирмаслиги мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ОИВ оддий мулоқот (қўл бериш, бирга овқатланиш, қучоқлаш) орқали юқмайди. Мижоз ҳақидаги маълумотни сир сақлаш қатъий мажбурият. Камситишга йўл қўйманг, дориларни узлуксиз ичишни қўллаб-қувватланг ва СПИДга қарши курашиш маркази билан ҳамкорлик қилинг.

230. ОИТС (орттирилган иммунитет танқислиги синдроми) (МКБ-10: B20–B24)

Мазмуни: ОИВ-инфекциясининг энг оғир босқичи: иммунитет жуда пасайиб, организм оддий инфекциялар ва ўсмаларга бардош бера олмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай беморга тиббий ва ижтимоий-руҳий ёрдам, парвариш ва ёлғизликдан сақлаш керак. Касалликка нисбатан қўрқув ва камситиш ҳолларида мижознинг ҳуқуқларини ҳимоя қилинг.

231. Олигофрения (ақлий заифлик): енгил даража (МКБ-10: F70)

Мазмуни: Ақлий ривожланишнинг туғма ёки эрта ёшда пайдо бўлган камлиги, енгил шакли. Одам ўқишда қийналади, лекин оддий кўникмаларни ўрганади, маълум даражада мустақил яшайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай одамга содда ва аниқ тушунтириш, соддалаштирилган таълим дастури ва меҳнат малакаси керак. Алдовчилар ва фирибгарлардан ҳимоя қилинг. ПТПК орқали таълим йўналишини аниқланг.

232. Олигофрения (ақлий заифлик): мўътадил даража (МКБ-10: F71)

Мазмуни: Ақлий заифликнинг ўрта даражаси. Одам содда гапларни тушунади, ўзига хизмат қилишни ўрганади, лекин ўқиш, ёзиш ва мураккаб ишларни эплай олмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Доимий назорат ва йўналтириш керак. Мижоз оддий меҳнатга ўргатилиши мумкин (ёрдам билан). Оилага парвариш ва ногиронлик расмийлаштиришда кўмак беринг.

233. Олигофрения (ақлий заифлик): оғир даража (МКБ-10: F72)

Мазмуни: Ақлий заифликнинг оғир даражаси. Нутқ жуда чекланган, кундалик эҳтиёжларни ўзи қондира олмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижоз кундалик ишларда (овқатланиш, гигиена) доимий ёрдамга муҳтож. Ўзгалар парваришига муҳтожлик ва ногиронлик белгиланади. Оилага руҳий қўллаб-қувватлаш ва дам олиш хизматлари ҳақида маълумот беринг.

234. Олигофрения (ақлий заифлик): чуқур даража (МКБ-10: F73)

Мазмуни: Ақлий заифликнинг энг оғир даражаси. Одам нутқни тушунмайди, ўзига хизмат қила олмайди, одатда бошқа жисмоний касалликлари ҳам бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижоз ҳар соат тўлиқ парваришга муҳтож. Оилага катта руҳий ва молиявий қийинчилик тушади; уй шароитида парвариш ёки махсус ижтимоий муассасаларга жойлаштириш масаласини кўриб чиқинг.

235. Онг хиралашуви (намозшомсимон хира ҳолат) (МКБ-10: R41.0)

Мазмуни: Онгнинг қисман хиралашиши: одам атрофдагиларни, вақт ва жойни англамайди, чалкашиб юради, бироз вақт ўзини нотўғри тутади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу эпилепсия, мия жароҳати ва бошқа касалликларда бўлиши мумкин. Мижозни ёлғиз қолдирманг, ўзига зарар етказмаслигини таъминланг, шифокорга хабар беринг.

236. Онкологик касалликлар (хавфли ўсмалар, саратон) (МКБ-10: C00–C97)

Мазмуни: Организмнинг бирор аъзосида ҳужайралар назоратсиз кўпайиб, хавфли ўсма ҳосил қилиши ва бошқа аъзоларга тарқалиши мумкин бўлган касалликлар гуруҳи.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Эрта аниқланса, кўп турлари даволанади, шунинг учун мижозларни мунтазам кўрикдан ўтишга ундаш керак. Беморга ва оилага руҳий, молиявий ва ҳужжатлар бўйича (ногиронлик, йўлланма) ёрдам беринг.

237. Оппортунистик инфекциялар (МКБ-10: B20–B24)

Мазмуни: Иммунитети жуда паст одамларда (асосан ОИВ-инфекциясида) пайдо бўладиган инфекциялар, соғлом одамда улар камдан-кам касаллик келтиради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай инфекциялар ОИВ-инфекцияси оғирлашганини кўрсатади. Мижозни зудлик билан шифокорга йўналтиринг ва дориларни мунтазам ичишни қўллаб-қувватланг.

238. Органик астеник бузилиш (энцефалоастеник ҳолат) (МКБ-10: F06.6)

Мазмуни: Бош мия шикастидан (жароҳат, инфекция, қон томир касаллиги) кейин пайдо бўладиган ҳолсизлик: тез чарчаш, диққатнинг пасайиши, асабийлик, бош оғриғи, уйқу бузилиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни ортиқча юкламанг, топшириқларни бўлаклаб беринг, дам олишга имкон яратинг. Ишда ёки ўқишда енгиллик керак бўлиши мумкин. Невролог назорати муҳим.

239. Орнитоз (пситтакоз) (МКБ-10: A70)

Мазмуни: Қушлар (каптар, тўтиқуш) орқали юқадиган инфекция: иситма, бош оғриғи, йўтал, зотилжам белгилари билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қушлар билан яқин алоқа қилган мижозда зотилжам белгилари пайдо бўлса, шифокорга қушлар билан алоқасини айтишни тушунтиринг. Антибиотик билан даволанади.

240. Орқа мия жароҳати (МКБ-10: T09.3)

Мазмуни: Йўл ҳодисаси, йиқилиш ёки сувга сакрашдан орқа миянинг шикастланиши. Жароҳат даражасидан пастда фалаж ва сезувчанликнинг йўқолиши, сийдик ва нажасни тута олмаслик бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижоз кўпинча кресло-аравачага муҳтож. Ётоқ яраларининг олдини олиш, катетер парвариши, реабилитация ва уйдаги тўсиқларни (зинапоя, тор эшик) бартараф этишда ёрдам беринг. Руҳий қўллаб-қувватлаш жуда муҳим.

241. Орқа мия сили (МКБ-10: A17)

Мазмуни: Сил микобактериясининг орқа мия ёки унинг пардаларига тарқалиши. Оёқларда кучсизлик, сезгининг йўқолиши, бел оғриғи ва фалаж бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу оғир, узоқ даволаш талаб этувчи касаллик. Мижозга сил дориларини узлуксиз ичишни тушунтиринг, даволашни назорат қилинг. Фалаж қолса, ногиронлик ва реабилитация масаласини кўтаринг.

242. Орқа мия ўсмаси (МКБ-10: C72.0)

Мазмуни: Орқа мияда ёки унинг атрофида ўсма. Бел ёки бўйин оғриғи, оёқ ва қўлларда кучсизлик, сезгининг йўқолиши ва сийдик тутиш бузилиши бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижозни нейрохирург ва онкологга йўналтиринг. Операциядан кейин реабилитация ва ногиронлик расмийлаштиришга ёрдам беринг.

243. Остеоартроз (бўғимлар артрози) (МКБ-10: M15–M19)

Мазмуни: Бўғим тоғайининг емирилиши. Бўғимда оғриқ, ҳаракатда қийинлик, юклама кўтарганда кучаяди. Кексаларда кўп учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга оғир юк кўтармаслик, вазнни камайтириш, ҳассадан фойдаланиш ва даволаш гимнастикасини тавсия қилинг. Оғир ҳолда бўғим протезлаш (эндопротез) операцияси қилинади.

244. Остеогенез (тугалланмаган, «шиша суяк» касаллиги) (МКБ-10: Q78.0)

Мазмуни: Суяклар жуда мўрт бўлган ирсий касаллик: болада озгина зарбадан суяк синиши мумкин. Кўзнинг оқ пардаси кўкимтир тусда бўлиши ва эшитиш пасайиши кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болани эҳтиёткорлик билан кўтариш ва ушлаш керак. Яхши мақсадда ўйнаганда ҳам жароҳатланиши мумкин, шунинг учун уйдаги муҳитни хавфсиз қилинг. Ота-оналарни болага зўравонлик қилишда асоссиз айблаш мумкин эмас: суякнинг бундай синиши касаллик сабабли. Ногиронлик белгиланиши мумкин.

245. Остеомиелит (суяк яллиғланиши) (МКБ-10: M86)

Мазмуни: Суяк ва суяк кўмигининг йирингли яллиғланиши. Қаттиқ оғриқ, юқори ҳарорат, шиш бўлади, баъзан сурункали бўлиб қолади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Узоқ антибиотик ва кўпинча операция керак. Сурункали шаклида ярадан йиринг оқади, шунинг учун гигиена ва бинт алмаштиришда ёрдам керак. Суякнинг оғир шикастланиши ногиронликка олиб келиши мумкин.

246. Остеопороз (суякларнинг сийраклашуви) (МКБ-10: M81)

Мазмуни: Суяк мустаҳкамлигининг пасайиши, суяклар мўртлашади. Кексаларда, айниқса аёлларда кўп учрайди. Озгина йиқилишдан сон суяги, билак ёки умуртқа синиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Йиқилишнинг олдини олиш энг муҳим: уйдаги тўсиқларни олиб ташланг. Кальций ва D витаминига бой овқат, қуёшда юриш ва машқ ёрдам беради. Кексаларни остеопороз текширувидан ўтказишга ёрдам беринг.

247. Остеохондроз (умуртқа поғонаси) (МКБ-10: M42)

Мазмуни: Умуртқалар орасидаги тоғай дискларининг емирилиши. Бел ёки бўйин оғриғи, оёқ ёки қўлга оғриқ тарқалиши ва увишиш билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга оғир юк кўтармаслик, қаттиқ ўринда ухлаш, даволаш гимнастикаси ва тўғри ўтиришни тавсия қилинг. Оғир ҳолда бел ёки бўйин корсети керак бўлиши мумкин.

248. Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси (МКБ-10: K25; K26)

Мазмуни: Меъда ёки ўн икки бармоқли ичак шиллиқ қаватидаги яра. Қорин юқорисида оғриқ (одатда оч қорингa), кўнгил айниши, баъзан қонли қайт бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга парҳез, спиртли ичимлик ва чекишдан воз кечиш, дориларни ичиш муҳимлигини тушунтиринг. Қора нажас ёки қонли қайт бўлса, дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг.

249. Оқма яра (қайталанувчи) (МКБ-10: L98.4)

Мазмуни: Тери ва остидаги тўқимада узоқ тузалмайдиган, қайта-қайта очиладиган яра. Қон айланиши бузилганда, тананинг ҳаракатсиз қисмларида кўп учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга яранинг тозалигини сақлаш, ўз вақтида бинтни алмаштириш ва шифокорга мурожаат қилиш муҳимлигини тушунтиринг. Узоқ ётган беморда ётоқ яраси билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.

250. Оғиз бўшлиғи саратони (МКБ-10: C06)

Мазмуни: Оғиз ичи, тил ёки лабнинг хавфли ўсмаси. Узоқ тузалмайдиган яра ёки оқ доғ, ютиш қийинлиги билан намоён бўлади. Чекиш ва нос ишлатиш хавфни оширади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғизда икки ҳафтадан ортиқ тузалмайдиган яра ёки доғ бўлса, мижозни шифокорга юборинг. Чекишни ва нос ишлатишни ташлашга ундаш муҳим. Операциядан кейин овқатланиш ва нутқ бўйича ёрдам керак бўлиши мумкин.

П

251. Паник бузилиш (МКБ-10: F41.0)

Мазмуни: Тўсатдан пайдо бўладиган кучли қўрқув хуружлари: юрак тез уради, нафас қисади, қўллар титрайди, «ўлиб қоламан» деган ҳис пайдо бўлади. Хуруж 10–30 дақиқа давом этади, лекин ҳаёт учун хавфли эмас.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Хуруж пайтида мижозга тинч гапиринг: «Бу ўтиб кетади, мен ёнингдаман», секин чуқур нафас олишга чақиринг. Хуруж такрорланса, психиатр ёки психотерапевтга йўналтиринг.

252. Панэнцефалит (ним ўткир склерозловчи) (МКБ-10: A81.1)

Мазмуни: Қизамиқ вируси туфайли бир неча йилдан кейин пайдо бўладиган нодир ва оғир мия касаллиги. Болада ақл, нутқ ва ҳаракат аста-секин ёмонлашади, тутқаноқ пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу касалликнинг олдини қизамиққа қарши эмлаш орқали олиш мумкин. Касал бола доимий парваришга муҳтож. Оилага руҳий қўллаб-қувватлаш ва паллиатив ёрдам керак.

253. Параплегия (оёқлар фалажи) (МКБ-10: G82.0–G82.2)

Мазмуни: Икки оёқнинг тўлиқ ҳаракатсизлиги, одатда орқа мия шикастидан келиб чиқади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз кресло-аравачага муҳтож, ётоқ яралари, сийдик ва нажас назорати масаласи бор. Реабилитация, уй шароитини мослаштириш (пандус, кенг эшик) ва руҳий қўллаб-қувватлаш керак. Ногиронлик белгиланади.

254. Парез ва плегия (фалажлик) (МКБ-10: G81–G83)

Мазмуни: Парез — мушак кучининг қисман йўқолиши (заифлик), плегия — тўлиқ фалаж. Бир қўл, бир оёқ, тананинг бир ярми ёки тўрт оёқ-қўл зарарланиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга ҳаракат даражасига қараб парвариш, кийиниш ва овқатланишда ёрдам керак. Реабилитация, ходунок ёки кресло-аравача ва уйни мослаштириш масалаларида ёрдам беринг.

255. Паркинсон касаллиги (МКБ-10: G20)

Мазмуни: Бош мия касаллиги: қўл ва бошнинг титраши, ҳаракатнинг секинлашиши, мушакларнинг қотиши ва юришнинг ўзгариши («майда қадамлар»). Дорилар билан бошқарилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга дориларни қатъий вақтида ичиш керак. Йиқилиш хавфи юқори, шунинг учун уйни хавфсиз қилинг. Нутқ секин ва паст бўлиши мумкин: сабр билан тинглаб, шошилтирманг. Кейинги босқичларда парвариш керак бўлади.

256. Пемфигус (пуфакчали касаллик) (МКБ-10: L10)

Мазмуни: Оғир аутоиммун тери касаллиги: терида ва оғиз шиллиқ қаватида катта пуфаклар ва яралар пайдо бўлади. Даволанмаса, ҳаётга хавфли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бемор кучли гормонал дориларни узлуксиз ичиши керак, ўзбошимчалик билан тўхтатиш хавфли. Тери парваришига ва инфекциядан сақланишга ёрдам беринг. Юқумли эмас.

257. Периартериит (тугунчали) (МКБ-10: M30.0)

Мазмуни: Қон томирлар деворининг аутоиммун яллиғланиши. Иситма, оғриқ, озиш, терида тугунчалар ва ички аъзолар (буйрак, нервлар) зарарланиши бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Узоқ ва кучли даволаш керак. Мижоз шифокор назоратида бўлиши ва дориларни мунтазам ичиши лозим. Оғир ҳолларда ногиронлик белгиланиши мумкин.

258. Перивентрикуляр лейкомаляция (МКБ-10: P91.2)

Мазмуни: Чала туғилган чақалоқларда бош мия қоринчалари атрофидаги оқ модданинг шикастланиши (қон билан таъминланиш етишмаслигидан). Кейинчалик болада БЦФ (мия фалажи) ривожланиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болаларни эрта реабилитацияга олиб келиш жуда муҳим. Невролог назорати, массаж, даволаш гимнастикаси ва эрта аралашув хизматлари натижани яхшилайди.

259. Перитонит (МКБ-10: K65)

Мазмуни: Қорин бўшлиғи пардасининг яллиғланиши. Кучли қорин оғриғи, тахта каби қаттиқ қорин, юқори ҳарорат, қайт билан кечади. Ҳаёт учун хавфли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қорин оғриғи кучли ва тўхтамаса, дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг. Оғриқ қолдирувчи дори ёки сув ичирманг ва қорнини иситманг. Тез жарроҳлик ёрдами керак.

260. Периферик нервлар жароҳати (МКБ-10: T14.4)

Мазмуни: Қўл ва оёқ нервларининг кесилиш, эзилиш ёки чўзилишдан шикастланиши. Мушаклар кучсизланиши, сезги йўқолиши ёки увишиш бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тикланиш секин кечади (ойлар). Мижозга реабилитация, массаж ва машқларни мунтазам қилиш муҳимлигини тушунтиринг. Қўл ёки оёқ заиф бўлса, ортез ёки бошқа восита керак бўлиши мумкин.

261. Пиелонефрит (сурункали) (МКБ-10: N11)

Мазмуни: Буйрак жоми ва буйрак тўқимасининг сурункали яллиғланиши (инфекциядан). Белда хира оғриқ, сийдикда ўзгариш, баъзан ҳарорат кўтарилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга совуқ қотмаслик, кўп суюқлик ичиш ва даволанишни охиригача олиб бориш муҳимлигини тушунтиринг. Ҳомиладор аёлларда хавфлироқ.

262. Плеврит (МКБ-10: R09.1)

Мазмуни: Ўпкани ўраб турган парданинг яллиғланиши. Нафас олганда кўкракда санчиқ оғриқ, йўтал, баъзан иситма бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўпинча зотилжам ёки сил билан боғлиқ бўлади, шунинг учун сабабини аниқлаш керак. Мижозни шифокорга йўналтиринг ва тавсияларга амал қилишини назорат қилинг.

263. Пневмокониоз (МКБ-10: J64)

Мазмуни: Чанг (кўмир, силикат, асбест) нафас орқали ўпкага тушиши натижасида ўпканинг доимий шикастланиши. Касб касаллиги: йўтал ва нафас қисилиши аста-секин кучаяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижозлар кончилар, қурувчилар ва ишчилар орасида учрайди. ТИЭК орқали касб касаллиги сифатида расмийлаштириш мумкин. Чекишни ташлаш ва чангли жойдан узоқ бўлиш керак.

264. Пневмония (зотилжам) (МКБ-10: J18)

Мазмуни: Ўпканинг ўткир инфекцион яллиғланиши: юқори ҳарорат, йўтал, нафас қисилиши ва кўкрак оғриғи. Кексалар, болалар ва ётоқ беморларда оғир кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни шифокорга юборинг, антибиотикни охиригача ичиш муҳим. Узоқ ётган кексаларда зотилжам ўлимга олиб келиши мумкин, шунинг учун уларнинг ҳолатини тез-тез ўзгартиринг ва чуқур нафас олишга ундаш керак.

265. Пневмосклероз (МКБ-10: J84.1)

Мазмуни: Ўпка тўқимасининг чандиқ тўқимага алмашиши. Ўпка эластиклигини йўқотади, нафас қисилиши ва йўтал пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз жисмоний юкламани кўтара олмайди. Оғир ҳолларда уйда кислород ва ногиронлик керак бўлиши мумкин. Чекиш ва совуқ қотишдан сақланиш муҳим.

266. Подагра (МКБ-10: M10)

Мазмуни: Қонда сийдик кислотаси кўпайиб, бўғимларда (кўпинча оёқ бош бармоғида) тузлар тўпланиши. Тўсатдан кучли оғриқ ва шиш хуружлари бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга парҳез (гўшт, балиқ, спиртли ичимликни чеклаш) ва кўп суюқлик ичиш муҳимлигини тушунтиринг. Хуруж пайтида оёқни ҳаракатлантириб бўлмайди ва иш қобилияти вақтинча пасаяди.

267. Полиневропатия (МКБ-10: G62)

Мазмуни: Кўп сонли периферик нервларнинг шикастланиши: қўл ва оёқ панжаларида увишиш, куйиш ҳисси, сезувчанликнинг йўқолиши, кучсизлик. Диабет ва спиртли ичимликдан кўп бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Сезувчанлик йўқолгани сабабли мижоз жароҳат ёки куйишни сезмаслиги мумкин, шунинг учун оёқ ва қўлини ҳар куни кўздан кечиринг. Диабетда қон шакарини назорат қилиш муҳим.

268. Полиомиелит (МКБ-10: A80)

Мазмуни: Вирусли юқумли касаллик, асосан болаларда: орқа миянинг зарарланиши натижасида оёқ ёки қўлнинг бўшашган фалажи пайдо бўлади. Эмлаш орқали олдини олиш мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ота-оналарни болаларни эмлашга ундаш жуда муҳим. Бола ногирон бўлиб қолса, реабилитация, ортопедик воситалар ва таълимда ёрдам керак.

269. Полиомиелит асоратлари (МКБ-10: B91)

Мазмуни: Полиомиелитдан кейин қоладиган оқибатлар: оёқ ёки қўл мушакларининг қуриши, бўғимлар деформацияси, оқсоқлик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга ортопедик пойабзал, ҳасса, ортез ёки аравача керак бўлиши мумкин. Ногиронлик белгиланади ва реабилитация режасига кўмак беринг.

270. Помпе касаллиги (гликоген тўпланиш касаллиги) (МКБ-10: E74.0)

Мазмуни: Нодир ирсий касаллик: мушакларда гликоген тўпланиб, мушаклар (юрак ва нафас мушаклари ҳам) кучсизланади. Болаларда оғир кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Нафас қисилиши ва ҳаракат қийинлиги бўлади. Махсус дори билан даволаш мумкин. Мижоз юрак, нафас ва ҳаракат бўйича мутахассислар назоратида бўлиши, оилага эса қўллаб-қувватлаш керак.

271. Портал гипертензия (МКБ-10: K76.6)

Мазмуни: Жигарга борувчи қон томирда босимнинг ошиши (кўпинча циррозда). Қорин шиши (асцит), қизилўнгач томирларининг кенгайиши ва қон кетиши хавфи бор.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қонли қайт — шошилинч ҳолат, 103 га қўнғироқ қилинг. Мижоз спиртли ичимликдан бутунлай воз кечиши ва шифокор назоратида бўлиши керак.

272. Постгипоксик бош мия шикастланиши (МКБ-10: P91; G93.1)

Мазмуни: Бош мия кислород етишмаслигидан (туғруқ пайтида, юрак тўхташи ёки бўғилиш оқибатида) шикастланиши. Оқибатда ақл, ҳаракат, нутқ бузилиши ва тутқаноқ бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болага эрта реабилитация керак, ота-оналарни мунтазам машғулотларга йўналтиринг. Оғир ҳолларда доимий парвариш ва ногиронлик белгиланади.

273. Посттравматик стресс бузилиши (ПТСР) (МКБ-10: F43.1)

Мазмуни: Қўрқинчли воқеадан (уруш, зўравонлик, авария, табиий офат) кейин узоқ вақт давом этадиган руҳий ҳолат: кабуслар, воқеани тез-тез эслаш, хавотир, доимий ҳушёрлик ва асабийлик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни воқеани батафсил сўзлашга мажбурламанг. Хавфсиз муҳит яратинг, тинч ва ҳурмат билан гаплашинг. Психолог ва психиатр ёрдамига йўналтиринг.

274. Прадер–Вилли синдроми (МКБ-10: Q87.1)

Мазмуни: Ирсий касаллик: гўдакликда мушаклар бўш, кейин боланинг очлик ҳисси тўхтамайди, жуда семириб кетади. Ақлий ривожланиш кечикади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болага овқатни қулф остида сақлаш ва қаттиқ парҳез керак бўлади, чунки у ўзини тия олмайди. Оилага бу ҳақда тушунтиринг ва қўллаб-қувватланг. ПТПК орқали таълим йўналишини аниқланг.

275. Преретинопатия (чала туғилганлар ретинопатияси) (МКБ-10: H35.1)

Мазмуни: Чала туғилган чақалоқларда кўзнинг тўр пардасидаги қон томирларнинг нотўғри ривожланиши. Даволанмаса, кўриш йўқолиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Чала туғилган чақалоқларни кўз шифокорига кўрсатиш шарт, кечиктириш кўрликка олиб келади. Ота-оналарга шу ҳақда хабар беринг.

276. Пролежни (ётоқ яралари) (МКБ-10: L89)

Мазмуни: Узоқ ётган беморнинг суяк чиқиб турган жойларида (думба, товон, елка) босим натижасида терининг ва остидаги тўқиманинг ўлиши ҳамда яра пайдо бўлиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Олдини олиш мумкин: ҳар 2 соатда бемор ҳолатини ўзгартиринг, терини тоза ва қуруқ сақланг, махсус матрас ишлатинг. Қизариш пайдо бўлса, дарҳол чоралар кўринг. Оилага ўргатиш ижтимоий ходимнинг муҳим вазифаси.

277. Психоз (МКБ-10: F29)

Мазмуни: Оғир руҳий ҳолат: одам воқеликни нотўғри қабул қилади, алаҳлайди, бор бўлмаган нарсаларни кўради ёки эшитади (галлюцинация).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз билан тортишманг ва унинг алаҳсирашини рад этмай, тинч гаплашинг. Агар ўзига ёки бошқаларга хавф бўлса, зудлик билан 103 га ёки руҳий хизматга хабар беринг.

278. Психологик ривожланишнинг аралаш бузилишлари (МКБ-10: F83)

Мазмуни: Боланинг нутқ, ўқиш, ёзиш ёки ҳаракат қобилиятлари бир нечта соҳада бир вақтда орқада қолиши, аммо ақлий заифлик бўлмаслиги.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола «дангаса» ёки «тарбиясиз» эмас. Эрта аралашув, логопед, дефектолог ва психологга йўналтиринг; ПТПК орқали таълим шаклини белгилашга ёрдам беринг.

279. Психопатия (шахсият бузилиши) (МКБ-10: F60)

Мазмуни: Хулқ-атвор ва ўзини тутишнинг барқарор бузилиши: бошқаларнинг ҳис-туйғуларига бепарволик, жаҳлдорлик, қоидаларни менсимаслик. Бу ақлий заифлик эмас.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижоз билан чегараларни аниқ белгиланг ва тинч туринг. Оилада ва ишда низолар кўп бўлади. Психолог ёки психиатр кўриги ва оилага маслаҳат керак.

280. Псориаз (МКБ-10: L40)

Мазмуни: Терининг сурункали юқумсиз касаллиги: тананинг турли жойларида қизарган, қалин, оқ тангачали доғлар пайдо бўлади. Қичишади, зўрайиб-тинчиб туради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу юқумли эмас: мижозни четлаб ўтманг. Одамлар камситиши сабабли мижоз ўзини ёмон ҳис қилади. Стресс кучайтиради, шунинг учун руҳий қўллаб-қувватлаш муҳим.

281. Псориаз (артропатик) (МКБ-10: L40.5)

Мазмуни: Псориаз билан бирга бўғимларнинг яллиғланиши (оғриқ, шиш, қотиш). Бармоқ бўғимлари деформациясига олиб келиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир шакли ҳаракатни чеклайди ва меҳнат қобилиятини пасайтиради, ногиронлик келтириб чиқариши мумкин. Мижозга мунтазам даволаш ва даволаш гимнастикаси керак.

282. Пульмонэктомиядан кейинги ҳолат (ўпка олиб ташланган) (МКБ-10: Z90.2)

Мазмуни: Ўпканинг бири операция билан олиб ташланган ҳолат (саратон, сил ёки бошқа сабабдан). Қолган ўпка нафас олишни таъминлайди, лекин нафас қисилиши бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз оғир жисмоний ишни қила олмайди, шамоллаш ва инфекциядан сақланиши керак. Ногиронлик ва меҳнат шароитини енгиллаштириш масаласини кўриб чиқинг.

Р

283. Радикуломиелопатия (МКБ-10: G55)

Мазмуни: Умуртқа поғонасидаги ўзгаришлар сабабли орқа мия ва ундан чиқувчи нерв илдизларининг эзилиши. Оёқ ёки қўлда оғриқ, кучсизлик ва сезги бузилиши бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз юришда қийналиши мумкин, ногиронлик белгилаш зарурати туғилиши мумкин. Нейрохирург кўриги ва реабилитация, ортез ёки корсет керак бўлиши мумкин.

284. Радикулопатия (МКБ-10: M54.1)

Мазмуни: Нерв илдизининг эзилиши ёки яллиғланиши: белдан оёққа (ёки бўйиндан қўлга) тарқалувчи оғриқ, увишиш ва кучсизлик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга оғир юк кўтармаслик, қаттиқ ўринда ётиш ва шифокор тавсияларига амал қилиш керак. Оғриқ уйқу ва ишга халақит беради, оғир ҳолда операция қилинади.

285. Рахит (МКБ-10: E55)

Мазмуни: Болаларда D витамини етишмаслигидан суякларнинг нотўғри ўсиши: оёқлар эгри, бош катта, кўкрак деформацияси, тишлар кеч чиқади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ота-оналарга болани қуёшда юргизиш, тўғри овқатлантириш ва шифокор берган D витаминини ичириш кераклигини тушунтиринг. Эрта аниқланса, осон тузалади.

286. Ревматик хорея (Сиденхем хореяси) (МКБ-10: I02)

Мазмуни: Болаларда томоқ инфекциясидан кейин бошланадиган ревматик касаллик: қўл-оёқ ва юз мушакларининг ихтиёрсиз, тартибсиз ҳаракатлари.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола ихтиёрсиз ҳаракатлари учун айбланмасин, мактаб ва уйда сабр қилинг. Шифокор назорати ва юрак текшируви керак, чунки юрак зарарланиши мумкин.

287. Ретинобластома (тўр парда ўсмаси) (МКБ-10: C69.2)

Мазмуни: Кичик болаларда кўзнинг тўр пардасида пайдо бўладиган хавфли ўсма. Кўз қорачиғи оқариб, «мушук кўзи» каби кўринади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болада қорачиқнинг оқ тусга кириши — зудлик билан кўз шифокори ва онкологга боришга сабаб. Эрта аниқланса, кўриш сақланиши мумкин. Кўз олиб ташланса, кўз протези кераклиги ҳақида оилага тушунтиринг.

288. Ретт синдроми (МКБ-10: F84.2)

Мазмуни: Асосан қизларда учрайдиган нодир касаллик: аввал бола меъёрида ривожланади, кейин нутқ ва қўл ҳаракатлари йўқолади, қўлларни доимий «ювиш» ҳаракати пайдо бўлади, тутқаноқ бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола доимий парваришга муҳтож. Оилага руҳий қўллаб-қувватлаш, реабилитация ва ногиронлик расмийлаштиришда ёрдам беринг.

289. Риносинусит (МКБ-10: J32)

Мазмуни: Бурун ва унинг ён бўшлиқларининг яллиғланиши: бурун битиши, бош оғриғи, юз оғриғи, шилимшиқ ажралма.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга ўз вақтида даволаниш, бурунни тозалаш ва юқори ҳарорат ёки қаттиқ оғриқ бўлса, шифокорга боришни тавсия қилинг. Сурункали шакли ишга қобилиятга озгина таъсир қилади.

С

290. Семизлик (МКБ-10: E66)

Мазмуни: Тана вазнининг меъёрдан ортиқ бўлиши, организмда ёғнинг кўп тўпланиши. Юрак, қандли диабет, бўғим ва қон босими касалликлари хавфини оширади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни айбламанг ва масхара қилманг. Тўғри овқатланиш, ҳаракат ва шифокор назорати ёрдам беради. Оғир семизлик юришни қийинлаштириб, парваришга муҳтожликка олиб келиши мумкин.

291. Сепсис (МКБ-10: A41.9)

Мазмуни: Инфекциянинг қонга тарқалиб, бутун организмга таъсир қилиши («қон заҳарланиши»). Юқори ҳарорат, титроқ, юрак тез уриши, чалкашлик бўлади. Ҳаёт учун жуда хавфли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Яра, куйиш ёки инфекциядан кейин аҳволи тез ёмонлашган мижозда дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг. Ҳар соат муҳим.

292. Септик грануломатоз (МКБ-10: D71)

Мазмуни: Нодир туғма иммунитет касаллиги: ҳимоя ҳужайралари бактерия ва замбуруғларни йўқота олмайди. Бола тез-тез оғир йирингли инфекцияларга чалинади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болани инфекциядан эҳтиёт қилиш ва узоқ вақт доимий дори ичишни таъминлаш керак. Оилага молиявий ва руҳий ёрдам беринг. Ногиронлик белгиланиши мумкин.

293. Сийдик йўли оқмаси (МКБ-10: N36.0)

Мазмуни: Сийдик йўлида ғайритабиий тешик ҳосил бўлиб, сийдикнинг нотўғри жойдан чиқиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз доимо ҳўл бўлиши, терисида яра пайдо бўлиши ва уялиши мумкин. Гигиена воситалари, терини парваришлаш ва урологга йўналтириш керак. Операция ёрдам беради.

294. Сийдик пуфагининг экстрофияси (МКБ-10: Q64.1)

Мазмуни: Туғма нуқсон: сийдик пуфаги қорин олд девори ёпилмаганлиги сабабли ташқарида жойлашган бўлади. Кўп босқичли жарроҳлик талаб қилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болада сийдик тутиш бузилиши қолиши мумкин, катетер ва махсус гигиена воситалари керак. Оилага молиявий ва руҳий ёрдам бериш ва ногиронликни расмийлаштириш керак.

295. Сийдик тута олмаслик (МКБ-10: R32)

Мазмуни: Сийдикнинг беихтиёр оқиб кетиши. Кексаларда, туғруқдан кейин, асаб касалликлари ва орқа мия жароҳатида учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз уялиб, шифокорга айтмаслиги мумкин, мулойимлик билан сўранг. Гигиеник воситалар (памперс), тез-тез алмаштириш ва терини парваришлаш керак. Бу ўзгалар парваришига муҳтожликнинг белгиси.

296. Силикоз (МКБ-10: J62)

Мазмуни: Кварц чанги (кон, қурилиш, тош ишлаш) нафас орқали ўпкага тушиб, ўпканинг чандиқланиши. Касб касаллиги: нафас қисилиши ва йўтал аста-секин кучаяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни ТИЭК орқали касб касаллиги сифатида расмийлаштиришга ёрдам беринг. Чанг билан алоқани тўхтатиш ва чекмаслик керак. Сил билан қўшилиб кетиши мумкин.

297. Силикотуберкулёз (МКБ-10: J65)

Мазмуни: Силикоз билан сил касаллигининг бирга кечиши. Оғир ўпка касаллиги.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Сил қисми юқумли бўлиши мумкин, шунинг учун даволаниш қатъий назоратда бўлиши керак. Ногиронлик ва касб касаллиги ҳужжатларини расмийлаштиришга ёрдам беринг.

298. Сил касаллиги (туберкулёз) (МКБ-10: A15–A19)

Мазмуни: Сил микобактерияси келтириб чиқарадиган юқумли касаллик. Асосан ўпкани зарарлайди: узоқ давом этган йўтал, ҳарорат, тер, озиш. Тўлиқ тузалади, лекин даволаш камида 6 ой давом этади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дорилар ҳар куни ва узилишсиз ичилиши керак, акс ҳолда касаллик чидамли бўлиб қолади. Мижоз даволанишни тўхтатиб қўймаслиги учун уни қўллаб-қувватланг. Камситманг. Оила аъзоларини текширувга юборинг.

299. Сифилис (МКБ-10: A50–A53)

Мазмуни: Жинсий йўл билан юқадиган бактериал инфекция. Даволанмаса, юрак, мия ва бошқа аъзоларни зарарлайди. Антибиотик билан тузалади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни айбламасдан, даволанишга йўналтиринг. Жинсий шерикларини ҳам текширтириш керак. Маълумотни сир сақланг. Ҳомиладорларда болага юқиши мумкин.

300. Склероз (тарқоқ) (МКБ-10: G35)

Мазмуни: Бош ва орқа миянинг сурункали, аутоиммун касаллиги: кўриш бузилиши, мушаклар кучсизлиги, мувозанат бузилиши, увишиш. Зўрайиш ва тинч даврлар билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Иссиқ ва стресс аҳволни ёмонлаштиради. Мижознинг ҳолати вақти-вақти билан ўзгаради, шунга тушунинг. Реабилитация, ходунок ёки кресло-аравача ва ногиронлик масаласида ёрдам беринг.

301. Сколиоз (МКБ-10: M41)

Мазмуни: Умуртқа поғонасининг ён томонга қийшайиши. Болалар ва ўсмирларда ўсиш даврида кўп бошланади. Елкалар ва куракларнинг баландлиги турлича бўлиб кўринади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Эрта аниқланса, даволаш гимнастикаси ва корсет билан ривожланишни тўхтатиш мумкин. Оғир даражаси болалар учун ПТПК хулосасида муҳим. Ўсмирга корсет кийиш учун руҳий қўллаб-қувватлаш керак.

302. Сон бўғимининг жароҳатдан чиқиши (МКБ-10: S73.0)

Мазмуни: Сон суяги бошчасининг жароҳат (йўл ҳодисаси, йиқилиш) туфайли чаноқ косасидан чиқиб кетиши: кучли оғриқ, оёқ ҳолати ўзгаради, юриб бўлмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Шошилинч ҳолат: мижозни қимирлатмасдан 103 га қўнғироқ қилинг. Кейин реабилитация ва юриш воситалари (ҳасса, ходунок) керак; кексада йиқилишнинг олдини олинг.

303. Сон суяги синиши (МКБ-10: S72)

Мазмуни: Сон суягининг синиши. Кексаларда (остеопороз фонида) йиқилишдан кўп бўлади. Одам юра олмайди, кучли оғриқ бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Шошилинч жарроҳлик ёрдами керак. Кекса одам узоқ ётиб қолса, зотилжам ва ётоқ яралари хавфи ортади. Операциядан кейин реабилитация ва парваришга ёрдам беринг.

304. Сохта бўғим (МКБ-10: M84.1)

Мазмуни: Синган суякнинг битмай қолиши ва синган жойда бўғимга ўхшаш ҳаракатчанлик пайдо бўлиши. Оғриқ пайдо бўлиб, таянч қобилияти йўқолади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз оёғига таяна олмай қолиши мумкин. Қайта операция ёки ортопедик восита (ортез) керак бўлади. Ногиронлик масаласини кўриб чиқинг.

305. Спина бифида (умуртқа каналининг тўлиқсиз ёпилиши) (МКБ-10: Q05)

Мазмуни: Туғма нуқсон: умуртқа канали орқа томонда ёпилмаган, орқа мия ва пардалари чиқиб турган бўлиши мумкин. Оёқ фалажи, сийдик ва нажас тутиш бузилиши, гидроцефалия бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болага эрта операция, реабилитация, ортопедик воситалар ва катетер керак. Ота-оналарга ҳомиладорликдан олдин фолий кислотаси ичиш муҳимлигини тушунтиринг. Ногиронлик ва таълим йўналишини аниқлашда ёрдам беринг.

306. Спиртли жигар циррози (МКБ-10: K70.3)

Мазмуни: Спиртли ичимликни узоқ вақт суиистеъмол қилишдан жигар тўқимасининг чандиққа алмашиши ва жигар ишининг бузилиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Спиртдан тўлиқ воз кечиш — энг муҳим чора: мижозни наркология ва шифокорга йўналтиринг. Оғир босқичда ногиронлик ва парваришга муҳтожлик кўрилади; қонли қайтда 103 га қўнғироқ қилинг.

307. Спленомегалия (МКБ-10: R16.1)

Мазмуни: Талоқнинг катталашиши. Бу алоҳида касаллик эмас, қон, жигар ёки инфекция касалликларининг белгиси.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Катта талоқ зарбадан ёрилиб кетиши мумкин, шунинг учун мижозга тўқнашув билан боғлиқ спорт турларини чеклаш керак. Сабабини аниқлаш учун шифокорга юборинг.

308. Спондилолистез (МКБ-10: M43.1)

Мазмуни: Бир умуртқанинг пастдаги умуртқага нисбатан олдинга сурилиб кетиши. Бел оғриғи, оёққа тарқалувчи оғриқ бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга оғир юк кўтармаслик, корсет ва машқлар тавсия этилади. Оғир ҳолда операция қилинади. Меҳнат шароитини енгиллаштириш керак бўлиши мумкин.

309. Стенокардия (МКБ-10: I20)

Мазмуни: Юрак мушагига қон етишмаслигидан кўкракда сиқувчи, босувчи оғриқ. Одатда юрганда ёки ҳаяжонда пайдо бўлади ва дам олганда ёки дори (нитроглицерин) билан ўтади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозда доим нитроглицерин бўлиши керак. Оғриқ 15 дақиқадан узоқ давом этса ёки дори ёрдам бермаса, инфаркт бўлиши мумкин: дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг.

310. Страбизм (ғилайлик) (МКБ-10: H50)

Мазмуни: Кўзларнинг бирга бир нуқтага қарамаслиги: бири ичкарига, ташқарига ёки юқорига қараб кетади. Болаларда эрта даволанмаса, кўзнинг кўриши пасайиб қолади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ота-оналарни боласини эрта ёшда кўз шифокорига олиб боришга унданг. Кўзойнак, машқ ёки операция ёрдам беради. Болани масхара қилишдан ҳимоя қилинг.

311. Стресс реакцияси (ўткир) (МКБ-10: F43.0)

Мазмуни: Кучли қўрқув ёки йўқотишдан кейин бир неча соат ёки кун ичида пайдо бўладиган ҳолат: гангиш, безовталик, ҳис-туйғуларнинг ўчиши, уйқусизлик. Одатда бир неча кунда ўтади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Одамни ёлғиз қолдирманг, хавфсиз ва тинч жой беринг, иссиқ ичимлик ва суҳбат билан қўллаб-қувватланг. Узоқ давом этса, психолог ёки психиатрга йўналтиринг.

312. Суицидал фикрлар ва хатти-ҳаракатлар (МКБ-10: R45.8)

Мазмуни: Одамнинг ўзига ўзи қасд қилиш ҳақида ўйлаши, режалаштириши ёки бунга уриниши. Кўпинча депрессия, кучли стресс, ёлғизлик ва йўқотишлар фонида пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай гапларни ҳеч қачон енгил қабул қилманг ва сир сақлашга ваъда берманг. Мижозни ёлғиз қолдирманг, тинч ва ҳурмат билан тинглаб, унга шу заҳотиёқ ёрдам топишни таклиф қилинг. Дарҳол психиатр ёки 103 га хабар беринг. Хавфли воситаларни яқиндан олиб қўйиш хавфсизликка ёрдам беради.

313. Сунъий нафас аппаратига боғлиқлик (МКБ-10: Z99.1)

Мазмуни: Одамнинг мустақил нафас ола олмаслиги сабабли узоқ вақт нафас аппаратига (вентилятор) уланиб туриши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижозга доимий парвариш ва тиббий кузатув керак: аппарат ва электр таъминотини назорат қилинг, оилага парваришни ўргатинг, ногиронлик ва парваришга муҳтожлик масаласида ёрдам беринг.

314. Сунъий ритм юритувчиси (кардиостимулятор) борлиги (МКБ-10: Z95.0)

Мазмуни: Юрак уришини тартибга солувчи кичик асбоб кўкрак терисининг остига ўрнатилган бўлиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз кучли магнит майдонидан, МРТ ва баъзи тиббий асбоблардан эҳтиёт бўлиши керак. Мунтазам кардиолог назорати зарур; ҳушдан кетиш ёки юрак уришининг секинлашиши бўлса, шифокорга мурожаат қилинг.

315. Сурункали буйрак етишмовчилиги (ХБН) (МКБ-10: N18)

Мазмуни: Буйракларнинг қонни тозалаш қобилияти аста-секин йўқолиши. Шиш, ҳолсизлик, қон босимининг ошиши, иштаҳа йўқлиги белгилари бўлади. Охирги босқичда гемодиализ ёки буйрак кўчириб ўтказиш керак.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга парҳез, суюқлик чеклови ва дорилар муҳим. Диализга қатнаш учун транспорт ва ногиронлик масаласида ёрдам беринг.

316. Сурункали йирингли ўрта отит (мезотимпанит, эпитимпанит) (МКБ-10: H66.1; H66.2)

Мазмуни: Ўрта қулоқнинг узоқ давом этадиган йирингли яллиғланиши: қулоқдан йиринг оқади, эшитиш пасаяди. Эпитимпанит хавфлироқ, мия асоратига олиб келиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга қулоққа сув тушишидан сақланиш ва ЛОР назоратида даволаниш муҳим. Эшитиш пасайса, эшитиш мосламаси ёки ногиронлик масаласини кўриб чиқиш мумкин.

317. Сурункали нафас етишмовчилиги (МКБ-10: J96.1)

Мазмуни: Ўпканинг организмни кислород билан етарли таъминлай олмаслиги. Нафас қисилиши, ҳолсизлик, лаб ва тирноқларнинг кўкариши кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга уйда кислород аппарати керак бўлиши мумкин. Юкламани чеклаш, чекмаслик ва шамоллашдан сақланиш муҳим. Ногиронлик ва парваришга муҳтожлик масаласини кўтаринг.

318. Сурункали обструктив ўпка касаллиги (СООК) (МКБ-10: J44)

Мазмуни: Нафас йўлларининг доимий торайиши: узоқ давом этувчи йўтал, балғам, нафас қисилиши. Кўп ҳолларда чекиш сабаб бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Энг муҳими — чекишни ташлаш. Мижоз ингалятор дорисини мунтазам ва тўғри ишлатиши керак. Ёмонлашганда (кучли нафас қисилиши) 103 га қўнғироқ қилинг. Ногиронлик ва кислород масаласида ёрдам беринг.

319. Сурункали юрак етишмовчилиги (МКБ-10: I50)

Мазмуни: Юракнинг организмни етарли қон билан таъминлай олмаслиги: оёқларда шиш, нафас қисилиши, тез чарчаш, суюқлик йиғилиши сабабли вазннинг ортиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз тузни камайтириши, суюқликни чеклаши ва ҳар куни вазнини ўлчаб туриши керак. Бир неча кунда вазн тез ошса, шифокорга айтинг. Дориларни тўхтатмасликни тушунтиринг.

320. Суяк сили (МКБ-10: A18.0)

Мазмуни: Сил микобактериясининг суякларга (кўпинча умуртқа поғонаси ва катта бўғимларга) тарқалиши. Оғриқ, деформация ва камдан-кам ҳолда фалаж бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Узоқ даволаш керак, дорилар узилмаслиги муҳим. Умуртқа сили оқибатида букирлик ва ногиронлик бўлиши мумкин. Реабилитацияга ёрдам беринг.

321. Суяк ўсмаси (хавфли) (МКБ-10: C40–C41)

Мазмуни: Суякнинг хавфли ўсмаси (саркома). Болалар ва ўсмирларда кўп учрайди: суякда оғриқ, шиш, баъзан синиш бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Узоқ давом этувчи суяк оғриғини шифокорга кўрсатиш керак. Даволаш мураккаб: химиотерапия ва операция, баъзан оёқ ёки қўл кесилади, протез керак бўлади. Бемор ва оилага қаттиқ руҳий қўллаб-қувватлаш лозим.

Т

322. Талассемия (МКБ-10: D56)

Мазмуни: Ирсий қон касаллиги: гемоглобин нотўғри ишлаб чиқарилади, оғир камқонлик пайдо бўлади. Болалар қон қуйишга муҳтож бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мунтазам қон қуйиш ва темирни чиқарувчи дорилар керак. Никоҳдан олдин генетик текширув оилаларга касаллик хавфини аниқлашга ёрдам беради. Болага ногиронлик белгиланиши мумкин.

323. Талваса хуружи (МКБ-10: R56)

Мазмуни: Тананинг тўсатдан беихтиёр титраши, қотиши ёки ҳушдан кетиши билан намоён бўлувчи хуруж. Сабаби эпилепсия, ҳарорат, заҳарланиш бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Хуруж пайти одамни ёнбошига ётқизинг, бошини ҳимоя қилинг, оғзига ҳеч нарса солманг. Хуруж 5 дақиқадан ортиқ давом этса ёки биринчи марта бўлса, 103 га қўнғироқ қилинг.

324. Танглай ва лаб ёриғи (қуён лаб) (МКБ-10: Q37)

Мазмуни: Туғма нуқсон: лаб ва/ёки танглайда ёриқ. Бола эмиш, овқатланиш ва гапиришда қийналади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Жарроҳлик йўли билан тузатилади (болалигида). Ота-оналарга овқатлантириш усулларини ўргатинг, логопед ва ЛОР назоратини таъминланг. Болани масхара қилишдан ҳимоя қилинг.

325. Таносил касалликлари (МКБ-10: A50–A64)

Мазмуни: Асосан жинсий йўл билан юқадиган инфекциялар гуруҳи (сифилис, гонорея ва бошқалар).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни айбламасдан, шифокорга боришга ундаш, шерикларини текширтириш ва даволанишни охиригача олиб боришга ёрдам бериш керак. Маълумотни махфий сақланг.

326. Тендовагинит (МКБ-10: M65)

Мазмуни: Пай ва унинг атрофидаги пардаларнинг яллиғланиши: бармоқ, қўл бўғимида оғриқ, шиш ва ҳаракатда қийинлик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бир хил ҳаракатни кўп такрорловчи касблар (тикувчи, оператор) учун хос. Қўлга дам бериш, ортез ва шифокор даволаши ёрдам беради.

327. Тери саратони (МКБ-10: C44)

Мазмуни: Терининг хавфли ўсмаси. Узоқ тузалмайдиган яра, ўсиб борувчи доғ ёки тугун кўринишида бўлади. Қуёш нури кўп таъсир қилганда кўпаяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тери ўзгаришини эрта шифокорга кўрсатиш муҳим. Қуёшда узоқ қолмаслик ва бош кийими кийишни тавсия этинг. Эрта аниқланса, яхши даволанади.

328. Тетрада Фалло (МКБ-10: Q21.3)

Мазмуни: Туғма мураккаб юрак нуқсони: бола лаблари ва тирноқлари кўкариб туради, нафас қисилади. Операция билан тузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болага жарроҳлик керак, шунинг учун вақтида кардиолог кўригига йўналтиринг. Операциядан олдин юкламадан сақлаш керак. Оилага молиявий ва руҳий ёрдам беринг.

329. Тетраплегия (тўрт аъзо фалажи) (МКБ-10: G82.3–G82.5)

Мазмуни: Икки қўл ва икки оёқнинг фалажи, кўпинча бўйин соҳасида орқа мия шикастланишидан.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ҳамма ишда бошқа одам ёрдамига муҳтож: овқатланиш, ювиниш, ҳолатини ўзгартириш. Ётоқ яраларининг олдини олиш, махсус кресло-аравача, матрас, парвариш ва руҳий қўллаб-қувватлаш зарур.

330. Тизимли бошланувчи ювенил артрит (МКБ-10: M08.2)

Мазмуни: Болаларда бўғимларнинг сурункали яллиғланиши, иситма, тошма ва ички аъзоларнинг зарарланиши билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болада бўғим оғриғи ва ҳарорат бўлса, ревматологга юборинг. Узоқ давом этувчи даволаш ва реабилитация керак. Мактабда жисмоний тарбияда енгиллик керак бўлади.

331. Тизимли қизил югурик (МКБ-10: M32)

Мазмуни: Иммунитет тизими ўз организмига қарши ишлайдиган сурункали касаллик: юзда «капалак» шаклидаги тошма, бўғим оғриғи, буйрак ва бошқа аъзолар зарарланиши. Асосан ёш аёлларда учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қуёш нури ҳолатни ёмонлаштиради. Дорилар узилмаслиги керак. Оғир шаклида ногиронлик белгиланиши мумкин. Ҳомиладорликни шифокор билан режалаштириш керак.

332. Тик бузилишлари (МКБ-10: F95)

Мазмуни: Тез, беихтиёр, такрорланувчи ҳаракатлар ёки товушлар (кўз қисиш, елка тортиш, йўталиш). Стрессда кучаяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болага «тўхта» деб танбеҳ берманг, бу кучайтиради. Мактабда тушунтириш, масхарадан ҳимоя қилиш ва психиатр ёки невролог кўриги керак.

333. Тиреотоксикоз (МКБ-10: E05)

Мазмуни: Қалқонсимон безнинг ортиқча гормон ишлаб чиқариши: юрак уриши тезлашади, озиш, қўл титраши, асабийлик, терлаш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ўзини безовта, асабий тутиши касаллик таъсиридан. Дорилар билан даволанади. Кўз олмаси чиқиши ёки юрак уриши кучайса, шифокорга юборинг.

334. Товон суяги синиши (МКБ-10: S92.0)

Мазмуни: Товон суягининг синиши, одатда баландликдан тушганда. Оёққа таяниш қийин ва оғриқли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Узоқ вақт юришдан қочиш керак, оёқни юқорига қўйиб дам олиш лозим. Мижозга ҳасса ёки қўлтиқ таёқ, реабилитация керак. Касб билан боғлиқ бўлса, меҳнат майиблиги билан боғлиқ ҳужжатларни расмийлаштиринг.

335. Токсикомания (МКБ-10: F18)

Мазмуни: Гиёҳванд моддалар рўйхатига кирмаган заҳарли моддаларни (елим, бензин, ёнилғи буғлари) ҳидлаб, ундан қарамлик пайдо бўлиши. Кўпинча ўсмирларда учрайди. Мия ва жигарни шикастлайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ўсмирда оғиз ёки кийимдан кимёвий ҳид келиши, қизарган кўзлар ва ҳушёрлик йўқолиши кузатилса, ота-оналар ва наркологни хабардор қилинг. Уни жазолаш эмас, даволаш ва оилада қўллаб-қувватлаш керак.

336. Токсоплазмоз (МКБ-10: B58)

Мазмуни: Паразит келтириб чиқарадиган инфекция, кўпинча мушуклар ва яхши пиширилмаган гўшт орқали юқади. Соғлом одамда деярли билинмайди, лекин ҳомиладорлар ва ОИВли беморлар учун хавфли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ҳомиладор аёлларга мушук нажасидан узоқ бўлиш, гўштни яхши пиширish ва қўл ювишни тушунтиринг. Ҳомила зарарланса, болада кўриш, мия ва ривожланиш бузилиши бўлиши мумкин.

337. Тос-сон бўғимининг туғма чиқиши (МКБ-10: Q65)

Мазмуни: Бола сон суяги боши чаноқ косасидан чиқиб кетган ҳолда туғилиши. Эрта аниқланса, махсус боғлам билан тузалади. Кеч аниқланса, оқсоқлик бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ота-оналарга чақалоқни ортопед ва УЗИ текширувидан ўтказишни тушунтиринг. Қаттиқ ўраб-чулғаш (қаттиқ пеленка) тавсия этилмайди.

338. Тос суяклари синиши (МКБ-10: S32.8)

Мазмуни: Чаноқ суякларининг синиши, одатда йўл ҳодисаси ёки баландликдан тушиш оқибатида. Кўп қон йўқотиш ва ички аъзолар шикастланиши хавфи бор.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Шошилинч ёрдам керак: ҳаракатлантирмасдан 103 га қўнғироқ қилинг. Узоқ ётиш кераклиги сабабли ётоқ яраларининг олдини олиш ва реабилитацияда ёрдам беринг.

339. Трахеит (МКБ-10: J04.1)

Мазмуни: Нафас трахеяси (кекирдак) шиллиқ қаватининг яллиғланиши. Қуруқ, оғриқли йўтал, кўкрак орқасида ачишиш билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Одатда шамоллашдан кейин пайдо бўлади. Иссиқ ичимлик, ҳавони намлаш ва чекмаслик ёрдам беради. Йўтал узоқ давом этса, шифокорга юборинг.

340. Тремор (қалтироқ) (МКБ-10: R25.1)

Мазмуни: Қўл, бош ёки таннинг беихтиёр титраши. Паркинсон, қалқонсимон без касалликлари, стресс ва баъзи дориларда кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз овқатланиш, ёзиш, кийинишда қийналиши мумкин. Уни шошилтирманг, қулай ашё (оғир қошиқ, катта тугма) ёрдам беради. Сабабини аниқлаш учун неврологга йўналтиринг.

341. Тромбофлебит (МКБ-10: I80)

Мазмуни: Вена деворининг яллиғланиши ва қон лахтаси (тромб) ҳосил бўлиши. Оёқда оғриқ, қизариш, шиш бўлади. Лахта узилиб, ўпкага ўтса, ҳаётга хавфли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оёқ тўсатдан шишиб, оғриса, шифокорга дарҳол мурожаат қилинг. Узоқ ётиб қолган беморларда хавф юқори: ҳаракат ва эластик бинт ёрдам беради. Тўсатдан нафас қисилса, 103 га қўнғироқ қилинг.

342. Тромбоцитопатия (МКБ-10: D69.1)

Мазмуни: Қон пластинкалари (тромбоцитлар) сони меъёрида, лекин ишлаши бузилганлиги туфайли қон тўхташининг кечикиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозда осон кўкариш, бурундан қон кетиш бўлади. Аспирин ва ўхшаш дориларни шифокорсиз ичмаслик керак. Жароҳатдан сақланиш ва кичик операциядан олдин шифокорни огоҳлантириш муҳим.

343. Тромбоцитопеник пурпура (МКБ-10: D69.3)

Мазмуни: Қондаги тромбоцитлар сони камайиши, терида кўкимтир доғлар (қон қуйилиш), бурун ва милкдан қон кетиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола ўйнаганда зарба олмаслиги керак. Бош жароҳати ёки кучли қон кетишида 103 га қўнғироқ қилинг. Шифокор назорати ва дорилар муҳим.

344. Туретт синдроми (МКБ-10: F95.2)

Мазмуни: Асаб тизими касаллиги: бола ёки катта одам беихтиёр, такрорланувчи ҳаракатлар ва товушлар чиқаради (баъзан сўкиниш сўзлари). Хоҳиш билан тўхтата олмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу одобсизлик эмас, касаллик белгиси. Мактабда ўқитувчиларга тушунтиринг ва масхарадан ҳимоя қилинг. Психиатр ёки невролог назорати зарур.

345. Тутқаноқ статуси (МКБ-10: G41)

Мазмуни: Тутқаноқ хуружи 5 дақиқадан ортиқ давом этиши ёки хуружлар ораси ҳушга келмасдан кетма-кет такрорланиши. Ҳаёт учун хавфли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг. Одамни ёнбошига ётқизинг, бошини ҳимоя қилинг, оғзига ҳеч нарса солманг. Хуруж бошланган вақтни ёзиб қўйинг.

346. Тутқаноқ (эпилепсия) (МКБ-10: G40)

Мазмуни: Бош мия касаллиги: такрорланувчи тутқаноқ хуружлари билан намоён бўлади. Дорилар билан хуружларни деярли бартараф этиш мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дориларни узмасдан ичиш энг муҳим. Мижозга сувда ёлғиз сузиш, баландда ишлаш ва машина ҳайдаш мумкин эмас. Камситманг ва уни хуруж пайти қандай ёрдам беришни яқинларига ўргатинг. Баъзи ҳолларда ногиронлик белгиланади.

347. Туғма аномалиялар (ривожланиш нуқсонлари) (МКБ-10: Q00–Q99)

Мазмуни: Бола туғилишидан олдин организм ёки аъзолар ривожланишидаги нуқсонлар (юрак, мия, суяк, юз ва бошқалар).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болага эрта аралашув, махсус даволаш ва реабилитация керак. Оилага нуқсон сабаби билан боғлиқ айбловдан ҳимоя ва қўллаб-қувватлаш лозим. Ногиронлик ва таълим масаласида ёрдам беринг.

348. Туғма юрак нуқсонлари (МКБ-10: Q20–Q28)

Мазмуни: Юрак ёки йирик қон томирларининг туғма тузилиш нуқсонлари. Нафас қисилиши, лабларнинг кўкариши, ёмон ўсиш белгилари бўлади. Кўпчилиги жарроҳлик билан даволанади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кардиолог ва жарроҳ назорати зарур. Операцияга вақтида тайёргарлик кўришда оилага ёрдам беринг. Болага ортиқча юкламадан сақланиш лозим. Ногиронлик масаласини кўриб чиқинг.

349. Туғруқ жароҳати (МКБ-10: P10–P15)

Мазмуни: Туғруқ пайтида чақалоққа етказилган жароҳатлар: мия қон қуйилиши, суяк синиши, нерв шикастланиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оқибатида БЦФ, қўл фалажи (елка чигали) ва бошқа ногиронликлар бўлиши мумкин. Болага эрта реабилитация ва невролог назорати керак. Оилага тушунтириш ва қўллаб-қувватлаш бериш лозим.

350. Тўр парда ажралиши, ёрилиши (МКБ-10: H33)

Мазмуни: Кўзнинг тўр пардасининг ўз жойидан ажралиши ёки ёрилиши. Кўз олдида чақнаш, қора доғлар ёки «парда» пайдо бўлади. Шошилинч операция талаб қилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тўсатдан кўриш пасайса ёки кўз олдида парда пайдо бўлса, мижозни дарҳол кўз шифокорига олиб боринг. Кечикиш кўрликка олиб келади.

351. Тўр парда шикастланиши (МКБ-10: H35.9)

Мазмуни: Кўзнинг кўриш ҳужайралари жойлашган парданинг турли сабабли (диабет, қон босими, ёш, ирсият) зарарланиши. Кўриш пасаяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўриш даражасига қараб ногиронлик ва техник воситалар (лупа, ҳасса) кераклиги ҳал этилади. Қон босими ва шакарни назорат қилиш кўришни асрашга ёрдам беради.

352. Тўғри ичак атрезияси (МКБ-10: Q42)

Мазмуни: Чақалоқда тўғри ичак ёки орқа чиқарув тешигининг туғма битиб қолганлиги. Нажас чиқмайди. Шошилинч операция керак.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Операциядан кейин баъзан колостома керак бўлади. Оилани парваришга ўргатиш ва молиявий ёрдам имкониятларини тушунтиришда кўмак беринг. Кейинчалик нажас тутиш билан боғлиқ муаммолар бўлиши мумкин.

У

353. Уйқу апноэси (МКБ-10: G47.3)

Мазмуни: Уйқу пайтида нафаснинг тўхтаб-тўхтаб қолиши. Қаттиқ хуррак, кундузги уйқучанлик, эрталаб бош оғриғи бўлади. Семизлик билан боғлиқ бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозда кундузги уйқучанлик ҳайдаш ва иш хавфсизлигига таъсир қилади. Вазнни камайтириш ва шифокорга мурожаат қилиш керак. Юрак-қон томир касалликлари хавфини оширади.

354. Уйқусизлик (МКБ-10: G47.0)

Мазмуни: Ухлай олмаслик, уйқунинг юзаки бўлиши ёки эрта уйғониш, натижада кундузи ҳолсизлик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Сабаби стресс, депрессия, оғриқ ёки соғлиқ муаммоси бўлиши мумкин. Мижозга мунтазам кун тартиби, кечқурун қаҳва ва экрандан сақланишни тавсия қилинг. Узоқ давом этса, шифокорга юборинг. Дорини шифокорсиз ичмаслик керак.

355. Умуртқалараро диск чурраси (МКБ-10: M51)

Мазмуни: Умуртқалар орасидаги тоғай дискнинг чиқиб, нерв илдизини босиши. Белдан оёққа (ёки бўйиндан қўлга) тарқалувчи оғриқ, увишиш, кучсизлик бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга оғир юк кўтармаслик, тўғри ўтириш ва машқ тавсия этилади. Оёқ кучсизланиши ёки сийдик тутиш бузилиши бўлса, шошилинч шифокорга боринг. Оғир ҳолда операция керак.

Ф

356. Фабри касаллиги (МКБ-10: E75.2)

Мазмуни: Нодир ирсий касаллик: ҳужайраларда ёғсимон модда тўпланиб, бармоқларда куйдирувчи оғриқ, терида тошма, буйрак ва юрак зарарланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Махсус дори билан даволаш мумкин. Мижозни мутахассис назоратига йўналтиринг. Ирсий касаллик бўлгани сабабли оила аъзоларини ҳам текширишга ундаш керак.

357. Фебрил тутқаноқ (МКБ-10: R56.0)

Мазмуни: Кичик болаларда юқори ҳароратда пайдо бўладиган тутқаноқ. Кўпинча хавфсиз ва бола ўсган сари йўқолади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ота-оналарга хуруж пайти болани ёнбошига ётқизиш, оғзига ҳеч нарса солмаслик ва 103 га қўнғироқ қилишни тушунтиринг. Ҳарорат кўтарилганда шифокор тавсиясига амал қилинг.

358. Фенилкетонурия (МКБ-10: E70.0)

Мазмуни: Ирсий модда алмашинуви касаллиги: организм фенилаланин аминокислотасини қайта ишлай олмайди. Даволанмаса, боланинг ақлий ривожланиши орқада қолади. Чақалоқда скрининг орқали аниқланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болага туғилгандан бошлаб умр бўйи махсус парҳез (оқсилни чеклаш) керак. Парҳезга риоя қилинса, бола соғлом ўсади. Оилага махсус озиқ-овқатни олишда ёрдам беринг.

X

359. Хантингтон касаллиги (МКБ-10: G10)

Мазмуни: Ирсий, аста-секин зўрайиб борувчи мия касаллиги: беихтиёр ҳаракатлар, хотира ва фикрлашнинг бузилиши, кайфият ўзгариши. Одатда 30–50 ёшда бошланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик ирсий, оила аъзоларига генетик маслаҳат керак. Мижозга парвариш, руҳий қўллаб-қувватлаш ва депрессия, ўзини ўлдириш фикрларига эътибор керак. Кейинги босқичда доимий парвариш лозим.

360. Холестеатома (МКБ-10: H71)

Мазмуни: Ўрта қулоқда тери ҳужайраларидан ҳосил бўлган ўсиқ тўплам, у суякни емиради. Қулоқдан ёмон ҳидли йиринг, эшитиш пасайиши бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу хавфли ҳолат, мия асоратига олиб келиши мумкин. Операция керак, шунинг учун мижозни ЛОР шифокорига юборинг.

361. Хореоатетоз (МКБ-10: G25.5)

Мазмуни: Хорея (тез ҳаракатлар) ва атетоз (секин, чўзилувчан, буралувчи ҳаракатлар) бирга бўлиши. Кўпинча БЦФнинг бир шаклида учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болага ўтириш, овқатланиш ва ёзишда ёрдам керак. Махсус ўриндиқ, реабилитация ва нутқ машғулотлари билан қўллаб-қувватлаш лозим.

362. Хорея (МКБ-10: G25.5)

Мазмуни: Қўл, оёқ ва юзнинг тез, тартибсиз, беихтиёр ҳаракатлари. Ревматизм, Хантингтон касаллиги ва бошқа сабаблардан бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга яхши кўриниш ёки одоб талаб қилманг, бу ҳаракатларни у ушлаб қола олмайди. Сабабини аниқлаш учун неврологга юборинг. Йиқилишдан сақланинг.

363. Хромосома касалликлари (Эдвардс, Патау синдромлари) (МКБ-10: Q91)

Мазмуни: Хромосомалар сони ёки тузилиши ўзгаришидан келиб чиқадиган оғир туғма касалликлар. Эдвардс ва Патау синдромларида кўп аъзолар нуқсонли бўлади, болалар кўпинча узоқ яшамайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оила катта қайғуни бошдан кечиради. Руҳий қўллаб-қувватлаш, паллиатив ёрдам ва қарорларда ҳурмат билан ёнида бўлиш лозим. Ўзини айбдор ҳис қилмаслигини тушунтиринг.

Ц

364. Целиакия (МКБ-10: K90.0)

Мазмуни: Буғдой, арпа, жавдардаги глютен оқсилига чидамсизлик: ичак зарарланади, ич кетиши, қорин дам бўлиши, озиш, ривожланишда орқада қолиш кузатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Давоси — умр бўйи глютенсиз парҳез (ноннинг ўрнига гуруч, маккажўхори). Бола ва оилага маҳсулотлар таркибини ўқишни ўргатинг. Парҳез бузилса, ҳолат ёмонлашади.

Ч

365. Чала туғилган чақалоқ (МКБ-10: P07)

Мазмуни: 37 ҳафтадан эрта туғилган бола. Нафас, овқат ҳазм қилиш, кўриш ва мия ривожланишида муаммолар хавфи юқори.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болага алоҳида парвариш (иссиқ сақлаш, она сути) ва мунтазам кўрик (кўз, эшитиш, невролог) керак. Ота-оналарни эрта аралашув хизматига ва эмлашга йўналтиринг.

366. Чов чурраси (МКБ-10: K40)

Мазмуни: Қорин ичидаги аъзо (ичак) чов соҳасида қорин девори орқали чиқиб қолиши. Чов соҳасида бўртма пайдо бўлади, юкланганда оғриқ бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир юк кўтармаслик керак. Операция билан даволанади. Чурра қисилиб қолса, 103 га қўнғироқ қилинг.

367. Чурра сиқилиши (МКБ-10: K41.3)

Мазмуни: Чурра ичидаги ичак сиқилиб, қон билан таъминланиши бузилиши. Кучли оғриқ, қайт, чурра қаттиқ ва қайтмайдиган бўлиб қолади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Шошилинч жарроҳлик ҳолати: дарҳол 103 га қўнғироқ қилинг. Чуррани ўзбошимчалик билан жойига тиқишга уринманг.

Ш

368. Шерешевский–Тернер синдроми (МКБ-10: Q96)

Мазмуни: Қизларда X хромосомалардан бирининг йўқлиги: паст бўй, жинсий ривожланишнинг кечикиши, баъзан юрак ва буйрак нуқсонлари. Ақл одатда меъёрида бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Гормонал даволаш ўсишга ёрдам беради. Қиз боланинг ўзига ишончини қўллаб-қувватланг. Ривожланиш масалалари бўйича эндокринолог ва гинеколог назорати зарур.

369. Шизоаффектив бузилиш (МКБ-10: F25)

Мазмуни: Шизофрения ва кайфият бузилиши (депрессия ёки қўзғалиш) белгилари бирга учрайдиган руҳий касаллик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дориларни мунтазам ичиш муҳим. Касаллик даврий зўрайиши мумкин: ўзига хос белгилар (уйқусизлик, шубҳа) пайдо бўлса, психиатрга хабар беринг. Мижозга ҳурмат ва камситмасдан муносабат қилинг.

370. Шизофрения (МКБ-10: F20)

Мазмуни: Оғир сурункали руҳий касаллик: овозлар эшитиш, алаҳлаш, фикрлаш ва ҳис-туйғуларнинг бузилиши, ижтимоий ҳаётдан узоқлашиш. «Икки шахс» дегани эмас. Дорилар билан бошқарилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дорини узлуксиз ичиши ва психиатр назорати муҳим. Мижоз билан тортишманг, алаҳсирашини ҳақиқат деб тасдиқламанг, лекин ҳурмат билан тинглаб туринг. Оилага ёрдам ва ногиронлик масалаларида кўмак беринг.

371. Шох парда шикастланиши (МКБ-10: S05.0)

Мазмуни: Кўзнинг олдинги шаффоф пардасининг жароҳатланиши (тирналиш, кесилиш, куйиш). Кўз оғрийди, ёш оқади, кўриш хиралашади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўзни ишқаламаслик ва дарҳол кўз шифокорига мурожаат қилиш керак. Тузалмаса, шох парда хирасидан кўриш доимий пасайиши мумкин.

Э

372. Экзема (МКБ-10: L20–L30)

Мазмуни: Терининг сурункали яллиғланиши: қизариш, қичишиш, пуфакчалар, қуруқ ёриқлар. Аллергия билан боғлиқ бўлади, юқумли эмас.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Таъсир қилувчи нарсаларни (кир ювиш воситаси, баъзи озиқ-овқат) аниқлаш ва ундан сақланиш керак. Терини намлантириш ва қашламаслик муҳим. Болани масхарадан ҳимоя қилинг.

373. Электр токидан жароҳат (МКБ-10: T75.4)

Мазмуни: Электр токи таъсирида тананинг куйиши, юракнинг ва нафаснинг тўхтаб қолиши, мушак ва нервларнинг зарарланиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Токдан жабрланганга тегишдан олдин токни ўчиринг. Ҳушсиз бўлса, 103 га қўнғироқ қилинг. Ташқи жароҳат кичик бўлса ҳам, юрак зарарланиши мумкин, шунинг учун албатта шифокорга кўрсатинг.

374. Элерс–Данло синдроми (МКБ-10: Q79.6)

Мазмуни: Бириктирувчи тўқиманинг ирсий касаллиги: тери ўта чўзилувчан ва нозик, бўғимлар ортиқча эгилувчан, осон чиқиб кетади, кўкаришлар кўп.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай одам жароҳатдан сақланиши, бўғимларни зўриқтирмаслиги керак. Йирик қон томир ёрилиши хавфи борлиги сабабли мунтазам шифокор кўриги керак.

375. Эмфизема (ўпка) (МКБ-10: J43)

Мазмуни: Ўпка ҳаво халталарининг кенгайиши ва эластиклигини йўқотиши. Нафас қисилиши, нафас чиқаришнинг қийинлиги бўлади. Кўпинча узоқ чекиш оқибати.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Чекишни ташлаш ва ингалятор дорисини қўллаш муҳим. Оғир ҳолларда кислород керак бўлади. Ногиронлик ва парвариш масаласини кўриб чиқинг.

376. Эндопротезлашдан кейинги ҳолат (МКБ-10: Z96.6)

Мазмуни: Бўғим (кўпинча чаноқ-сон ёки тизза) сунъий бўғимга алмаштирилгандан кейинги ҳолат.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дастлабки ойларда мижозга қўлтиқ таёқ, ходунок ёки ҳасса керак бўлади. Баъзи ҳаракатлардан (чўққайиш, оёқ чалиштириш) эҳтиёт бўлиш керак. Уйдаги тўсиқларни олиб ташланг. Реабилитация машқлари муҳим.

377. Энкопрез (МКБ-10: F98.1)

Мазмуни: Болада нажасни ўзи билмасдан ёки тута олмай, ичи кийимга чиқиб кетиши (ақли соғлом ва меъёрида туғилган бола, одатда 4 ёшдан катта).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болани уришманг ва уялтирманг, бу ихтиёрий эмас. Кўпинча қабзиятдан бўлади. Шифокор ва психолог кўриги керак. Мактабда масхара қилинишидан ҳимоя қилинг.

378. Энурез (МКБ-10: F98.0)

Мазмуни: Болаларда (5 ёшдан катта) уйқуда ёки кундузи сийдикнинг беихтиёр чиқиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болани жазоламанг ва уялтирманг. Кечқурун суюқликни камайтириш, ҳожатхонага боришга ўргатиш ва шифокор кўриги ёрдам беради. Руҳий қўллаб-қувватлаш муҳим.

379. Энцефалит (МКБ-10: G04)

Мазмуни: Бош мия тўқимасининг яллиғланиши (кўпинча вирусдан). Юқори ҳарорат, бош оғриғи, чалкашлик, тутқаноқ бўлади. Оқибатида ақл ва ҳаракат бузилиши қолиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Шошилинч ҳолат, дарҳол 103. Касалликдан кейин реабилитация ва оилани қўллаб-қувватлаш керак. Кана орқали юқадиган турлари учун эмлаш ва эҳтиёт чоралари муҳим.

380. Энцефалопатия (МКБ-10: G93.4)

Мазмуни: Бош мия функциясининг турли сабабларга (заҳарланиш, жигар ёки буйрак касаллиги, кислород етишмаслиги) кўра бузилиши. Хотира, диққат ва хулқда ўзгаришлар бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Сабабини аниқлаш ва даволаш мумкин. Мижозда тўсатдан чалкашлик пайдо бўлса, шифокорга юборинг. Узоқ давом этса, парваришга муҳтожлик бўлиши мумкин.

381. Эпикондилоз (МКБ-10: M77.1)

Мазмуни: Тирсак бўғимининг ён томонидаги пай бириктирилган жойнинг яллиғланиши («теннисчи тирсаги»). Қўлни кўтарганда, ушлаганда оғриқ.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қўлни зўриқтирадиган кишиларда учрайди. Қўлга дам бериш, ортез ва шифокор даволаши ёрдам беради.

382. Эшакем (МКБ-10: L50)

Мазмуни: Терида қичишувчи, қизил, кўтарилган доғлар (чақириқ) пайдо бўлиши, одатда аллергиядан. Бир неча соатда ўтиб кетиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Аллергенни аниқлаб, ундан сақланиш керак. Лаб, юз ёки тил шишиб, нафас қийинлашса, шошилинч 103 га қўнғироқ қилинг.

383. Эшитиш пасайиши ва карлик (МКБ-10: H90; H91)

Мазмуни: Эшитишнинг қисман (қаттиқ эшитиш) ёки тўлиқ (карлик) йўқолиши. Туғма ёки орттирилган бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз билан юзма-юз, равшан гаплашинг, керак бўлса ёзиб кўрсатинг ёки имо-ишора тили таржимонидан фойдаланинг. Эшитиш мосламаси ёки кохлеар имплант, ногиронлик ва таълим масалаларида ёрдам беринг.

Ю

384. Юрак клапани протезланишдан кейинги ҳолат (МКБ-10: Z95.2)

Мазмуни: Юракнинг касалланган клапани сунъий клапанга алмаштирилган ҳолат.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Механик клапан қўйилган мижоз қонни суюлтирувчи дориларни умр бўйи ичиши ва мунтазам таҳлил топширишни унутмаслиги керак. Қон кетиш белгилари пайдо бўлса, шифокорга мурожаат қилинг. Ногиронлик масаласини кўриб чиқинг.

385. Юрак ритмининг бузилиши (МКБ-10: I49)

Мазмуни: Юрак уришининг нотекис, тез ёки секин бўлиши. Юрак «ўйнаб», узилиб, тез ураётгандек ҳис этилади. Бош айланиши, ҳолсизлик, баъзан ҳушдан кетиш бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозда ҳушдан кетиш, кучли кўкрак оғриғи бўлса, 103 га қўнғироқ қилинг. Дорилар узилмаслиги, кофе ва спиртли ичимликдан сақланиш муҳим.

386. Юрак ўтказувчанлигининг бузилиши (МКБ-10: I44–I45)

Мазмуни: Юрак ичидаги электр импульсларининг ўтишида тўсиқ (блокада): юрак секин уради, бош айланади, ҳушдан кетиш бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир ҳолларда сунъий ритм юритувчи (кардиостимулятор) ўрнатилади. Мижозда ҳушдан кетиш бўлса, шифокорга юборинг.

Ў

387. Ўзгалар парваришига муҳтожлик (МКБ-10: Z74.1)

Мазмуни: Одамнинг соғлиғи сабабли кундалик ишларни (овқатланиш, ювиниш, кийиниш, ҳожатхонага бориш) мустақил бажара олмай, доимий ёки вақтинчалик бошқа одам ёрдамига муҳтожлиги.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ижтимоий ходим мижознинг қанча ёрдамга муҳтожлигини баҳолаб, парвариш режасини тузади. Ногиронлик ҳужжатларида бу ҳолат кўрсатилиши ва тегишли ёрдам ва тўловлар белгиланиши мумкин.

388. Ўмров синиши (МКБ-10: S42.0)

Мазмуни: Бўйин ва елка орасидаги ўмров суягининг синиши. Йиқилиш ёки зарбадан кўп бўлади. Елка соҳасида оғриқ, қўлни кўтара олмаслик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга қўлни тинч сақлаш ва боғлам кераклигини тушунтиринг. Бир неча ҳафта кийиниш, овқатланиш ва ювинишда ёрдам керак бўлиши мумкин.

389. Ўпка гипертензияси (МКБ-10: I27)

Мазмуни: Ўпка қон томирларида босимнинг ошиши: нафас қисилиши, ҳолсизлик, оёқларда шиш, ҳушдан кетиш. Юракнинг ўнг қисмига оғир юк тушади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга оғир жисмоний юклама, баланд тоғли жой ва ҳомиладорлик хавфли. Дориларни мунтазам ичиш керак. Оғир ҳолда ногиронлик ва кислород масаласини кўтаринг.

Қ

390. Қандли диабет (1-тур) (МКБ-10: E10)

Мазмуни: Организм инсулин ишлаб чиқара олмайдиган касаллик, одатда болалик ва ёшликда бошланади. Бемор умр бўйи инсулин уколи олиши керак.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болалар ва ёшлар учун шакарни ўлчаш, инсулин ва парҳез ҳаётий муҳим. Шакар тушиб кетса (титроқ, терлаш, чалкашлик), дарҳол шакарли нарса беринг. Мактабда болага шароит яратиш керак. Оилага ногиронлик ва воситалар (глюкометр) масаласида ёрдам беринг.

391. Қандли диабет (2-тур) (МКБ-10: E11)

Мазмуни: Инсулин етарли даражада таъсир қилмайдиган (ёки кам ишлаб чиқариладиган) диабет тури, асосан катталарда ва семизликда. Дори ва парҳез билан бошқарилади, баъзан инсулин керак бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга вазнни камайтириш, ҳаракат, парҳез ва дорини ичишни тушунтиринг. Оёқларни ҳар куни кўздан кечириш, кўз ва буйракни йилига текшириш керак. Асоратлар ногиронликка олиб келиши мумкин.

392. Қандсиз диабет (МКБ-10: E23.2)

Мазмуни: Қандли диабетга алоқаси йўқ касаллик: гипофиз ишлаб чиқарадиган антидиуретик гормон (вазопрессин) етишмаслиги ёки буйракларнинг унга сезгирлиги йўқлиги сабабли организм сувни ушлаб қола олмайди ва кўп миқдорда суюлтирилган сийдик ажралади. Одам жуда кўп сув ичади ва кўп сийди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз сувсиз қолмаслиги керак, сувсизланиш хавфли. Гормон ўрнини босувчи дори мунтазам қабул қилинади. Қандли диабет билан адаштирманг.

393. Қизилўнгач атрезияси (МКБ-10: Q39.0)

Мазмуни: Чақалоқда қизилўнгачнинг туғма битиб қолиши, шу сабабли сут ва овқат ошқозонга ўтмайди. Чақалоқ оғзидан кўпик чиқаради, бўғилади. Шошилинч операция керак.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Операциядан кейин болада ютиш қийинлиги, овқат тиқилиши кузатилиши мумкин. Оилани овқатлантириш ва парваришга ўргатишда ёрдам беринг.

394. Қизилўнгач торайиши (МКБ-10: K22.2)

Мазмуни: Қизилўнгач йўлининг торайиши, одатда куйиш (кислота, ишқор) ёки яллиғланиш оқибатида. Овқат ютиш қийин ва оғриқли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болалар ёки руҳий касаллиги бор мижозлар учун уйда кислота, ишқор ва кимёвий моддаларни яшириш керак. Мижоз суюқ ва майдаланган овқат ейиши керак; жарроҳлик ёрдами лозим.

395. Қовоқ тушиши (птоз) (МКБ-10: H02.4)

Мазмуни: Юқори қовоқнинг тушиб, кўзни қисман ёки тўлиқ беркитиши. Туғма ёки мушак ва нерв касалликлари оқибатида бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болада қовоқ кўзни беркитса, кўриш ривожланмай қолиши мумкин. Операция керак, шунинг учун кўз шифокорига юборинг. Катталарда тўсатдан пайдо бўлса, неврологга мурожаат қилинг.

396. Қовуқ ўсмаси (МКБ-10: C67)

Мазмуни: Сийдик пуфагининг хавфли ўсмаси. Асосий белгиси — сийдикда қон пайдо бўлиши (оғриқсиз ҳам). Чекувчиларда кўп учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Сийдикда қон кўрилса, дарҳол урологга юборинг. Онкологик даволаш, ногиронлик ва операциядан кейинги парвариш (сийдик йиғгич) масаласида ёрдам беринг.

397. Қон ивишининг бузилишлари (коагулопатиялар) (МКБ-10: D65–D68)

Мазмуни: Қоннинг ивиши бузилиб, қон кетиш тўхтамаслиги ёки осон кўкариш билан кечадиган касалликлар. Масалан, гемофилия.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни жароҳатдан эҳтиёт қилиш, аспирин ва шунга ўхшаш дориларни ичмаслик ва ҳар қандай операция (тиш олиш ҳам) олдидан шифокорни огоҳлантириш керак. Қон кетиши бошланса, 103 га қўнғироқ қилинг.

398. Қорин олд девори чурраси (МКБ-10: K43)

Мазмуни: Қорин деворидаги мушакларнинг заифлашган жойидан ички аъзоларнинг (кўпинча ичак) чиқиб қолиши. Кўпинча операция жойида ёки киндик атрофида пайдо бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир юк кўтармаслик ва қорин боғичини қўллаш мумкин. Чурра қаттиқ бўлиб, оғриса ва қайт бўлса, шошилинч ёрдамга мурожаат қилинг.

399. Қўл-оёқларнинг туғма йўқлиги (МКБ-10: Q71; Q72)

Мазмуни: Бола қўл ёки оёғининг бир қисми ёки тўлиқ йўқ ҳолда туғилиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болага протез ва реабилитация керак, у ўсган сари протез алмаштирилади. Бундай бола мактабда одатдагидек ўқиши мумкин, камситишдан ҳимоя қилинг. Оилага руҳий қўллаб-қувватлаш ва ногиронлик расмийлаштиришга ёрдам беринг.

400. Қўтир (МКБ-10: B86)

Мазмуни: Тери остида йўл очиб яшовчи кана (қўтир канаси) келтириб чиқарадиган юқумли тери касаллиги. Кечаси кучайувчи кучли қичишиш, бармоқлар орасида ва белда тошма бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Яқин мулоқот ва умумий кийим-ўринбош орқали юқади. Оила аъзолари билан бирга даволанади, кийим ва ўринбош иссиқ сувда ювилади. Юқишдан қўрқиб, мижозни камситманг.

Ғ

401. Ғилайлик (страбизм) (МКБ-10: H50)

Мазмуни: Кўзларнинг бири ёнга, юқорига ёки пастга оғиб, иккала кўз бир нуқтага қарамаслиги.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болада эрта аниқланиб даволанмаса, оғган кўзнинг кўриши пасайиши мумкин. Ота-оналарни кўз шифокорига йўналтиринг; болани масхара қилишдан ҳимоя қилинг.

Ҳ

402. Ҳаракатлантирувчи неврон касаллиги (амиотрофик ён склероз) (МКБ-10: G12.2)

Мазмуни: Бош ва орқа миянинг ҳаракат нерв ҳужайраларининг аста-секин нобуд бўлиши. Мушаклар кучсизланиб, нутқ, ютиш ва нафас бузилади. Ақл одатда сақланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тез зўрайиб борувчи касаллик, мижоз ва оилага паллиатив ёрдам, ҳаракат, нутқ ва нафас воситалари ва руҳий қўллаб-қувватлаш керак. Мижоз ўз қарорларини ўзи қабул қилиш ҳуқуқини сақлайди.

403. Ҳушдан кетиш (обморок) (МКБ-10: R55)

Мазмуни: Мияга қон келишининг вақтинча пасайиши оқибатида қисқа вақтга ҳушдан кетиш. Иссиқ, қўрқув, тик туриш, юрак ритми бузилишидан бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Одамни ётқизинг, оёқларини кўтаринг, кийимини бўшатинг, тоза ҳаво беринг. Бир неча дақиқада ҳушга келмаса ёки такрорланса, 103 га қўнғироқ қилинг ва шифокорга юборинг.

II. ТИББИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-ТИББИЙ АТАМАЛАР

Тиббий ва ижтимоий-тиббий ҳужжатларда кўп учрайдиган атамалар.

A

1. Абилитация

Мазмуни: Туғма нуқсони бор болада ҳали шаклланмаган қобилиятларни (юриш, гапириш) илк бор ривожлантириш. Реабилитацияда йўқотилгани тикланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Боланинг якка реабилитация дастурида (РЯТД) абилитация тадбирлари ҳам кўрсатилади; ота-оналарни бу хизматларга йўналтиринг.

2. Агнозия

Мазмуни: Кўриш ва эшитиш соғлом бўлса ҳам, мия шикастланиши туфайли таниш нарса, одам ёки товушни таний олмаслик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз яқинини ёки қошиқ, телефонни танимаслиги мумкин; бу ёлғон ёки эътиборсизлик эмас. Тинч, содда тушунтиринг, уй хавфсизлигини кўринг. Инсульт, деменцияда учрайди.

3. Адаптация (ижтимоий)

Мазмуни: Инсоннинг янги шароитга (касаллик, ногиронлик, янги жой, янги иш ёки жамоа) мослашиши ва тўлақонли яшашга ўрганиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Касаллик ёки ногиронликдан кейин мижоз ҳаёт тарзини ўзгартиради. Ижтимоий ходим муҳитни мослаштириш, ўқитиш ва ишга жойлаштириш орқали унга ёрдам беради.

4. Алоҳида таълимга эҳтиёжи бўлган болалар

Мазмуни: Жисмоний, ақлий, кўриш, эшитиш ёки руҳий ривожланишидаги нуқсон туфайли таълимда махсус шароит ва ёрдамга муҳтож болалар.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Таълим йўналишини ПТПК (психологик-тиббий-педагогик комиссия) хулосаси белгилайди. Ота-оналарга комиссияга мурожаат қилиш ва инклюзив таълим имкониятлари ҳақида маълумот беринг.

5. Амбулатор карта

Мазмуни: Беморнинг поликлиникада юритиладиган тиббий ҳужжати, унда касалликлари, текширув натижалари ва даволаш тарихи ёзилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ТИЭКга ёки ПТПКга ҳужжат йиғишда амбулатор картадан кўчирма талаб қилинади. Мижозга оилавий шифокордан керакли кўчирмани олишга ёрдам беринг. Картадаги маълумотлар махфий, уларни ошкор қилманг.

6. Ампутацион чўлтоқ

Мазмуни: Қўл ёки оёқ кесиб олингандан кейин қолган қисм. Уни протез билан тўлдирса бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Чўлтоқ узунлигига қараб протез тури танланади. Мижозга чўлтоқни тоза ва қуруқ сақлаш ҳамда ТИЭК орқали протезга муҳтожликни белгилатиш тартибини тушунтиринг.

7. Ампутация

Мазмуни: Қўл, оёқ ёки бармоқнинг жарроҳлик йўли билан кесиб олиниши. Сабаби жароҳат, диабет, қон томир касалликлари ёки ўсма бўлиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз кўпинча руҳий зарба олади. Руҳий қўллаб-қувватлаш, реабилитация ва протез билан таъминлаш муҳим. Диабетда ампутация ногиронликка асос бўлади.

8. Анамнез

Мазмуни: Бемор ёки яқинларидан йиғилган касаллик тарихи: касаллик қачон ва қандай бошланган, аввал нималар бўлган, яшаш шароити қандай.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ижтимоий ходим кейс тайёрлаётганда анамнез йиғади: оила, иш, уй-жой, салоҳият. Аниқ маълумот ёрдам режасини тўғри тузишга имкон беради.

9. Антиретровирус терапия (АРВТ)

Мазмуни: ОИВнинг организмда кўпайишини тўхтатиб турадиган дориларнинг комбинацияси. Даволаш умрбод давом этади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Дорини ҳар куни бир вақтда ичиш шарт: ўтказиб юбориш вирусни дорига чидамли қилади. Мижоз камситилмаслигини таъминланг, шифокорга қатнашига ёрдам беринг, маълумотни махфий сақланг.

10. Асорат

Мазмуни: Асосий касаллик ёки даволаш оқибатида пайдо бўлган қўшимча, одатда оғирроқ ҳолат (масалан, диабетнинг асорати — буйрак шикастланиши).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Асоратлар касалликни оғирлаштиради ва ногиронликка олиб келиши мумкин. Мижозга шифокор кўригидан ўтиш ва дориларни ўз вақтида қабул қилиш асоратларнинг олдини олишини тушунтиринг.

11. Асосий ва қўшимча ташхис

Мазмуни: Асосий ташхис — беморнинг аҳволини энг кўп оғирлаштирадиган, асосий касаллик. Қўшимча ташхис — бошқа, қўшилган касалликлар.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ТИЭК хулосаси ва ногиронлик маълумотномасида асосий ташхис ёзилади. Ҳужжатларни тўғри тушуниш учун, мижоз бир нечта касалликка эга бўлса, уларнинг ҳаммаси ҳужжатда кўрсатилганини текширинг.

12. Аудиограмма

Мазмуни: Эшитиш қобилиятини текшириш натижасини кўрсатувчи график ёки жадвал. Эшитиш қайси товушларда ва қанча пасайганини кўрсатади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Карлик ёки эшитишнинг пасайиши билан ногиронлик белгилашда ва эшитиш мосламаси учун аудиограмма керак бўлади. Мижознинг аудиограммаси борлигини ва янгилигини текширинг.

13. Аудиометрия

Мазмуни: Махсус аппарат ёрдамида эшитиш қобилиятини текшириш усули. Натижаси аудиограммада акс этади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Эшитиш бузилишини эрта аниқлаш учун қўлланади. Бола эшитмаяпти деган шубҳа бўлса, ота-оналарни аудиометрияга йўналтиринг: эрта аниқлаш нутқ ривожланишига таъсир қилади.

Б

14. Бармоқлар ампутацияси

Мазмуни: Қўл ёки оёқ бармоқларидан бирини ёки бир нечтасини жарроҳлик йўли билан олиб ташлаш (диабет, куйиш, жароҳат оқибатида).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Диабет туфайли ампутация ногиронликка асос бўлади. Қўлда 4–5 бармоқ йўқолса, бионик протез мумкин. Диабетли мижоз оёғини ҳар куни кўздан кечирсин.

15. Бартел индекси

Мазмуни: Кундалик ишларни (овқатланиш, кийиниш, юриш) ўзи қила олиш даражасини 0–100 баллда баҳолаш шкаласи; балл қанча паст, ёрдам шунча кўп керак.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ижтимоий ходим ундан парваришга муҳтожликни баҳолашда фойдаланади. Баллни ҳар 3–4 ойда такрорлаб, тикланиш ёки ёмонлашувни кузатиш мумкин.

16. Биринчи тиббий ёрдам

Мазмуни: Бахтсиз ҳодиса ёки тўсатдан касалланганда шифокор келгунча кўрсатиладиган оддий ёрдам: қон кетишни тўхтатиш, нафасни текшириш, қулай ҳолатда ётқизиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ижтимоий ходим ҳушдан кетган, талваса қилган ёки қон кетган мижозга биринчи ёрдам бериши, 103 га қўнғироқ қилиши ва шифокор келгунча кузатиши керак.

17. Болаликдан ногиронлик

Мазмуни: 18 ёшгача бошланган касаллик ёки жароҳат туфайли белгиланган ногиронлик. У 18 ёшдан кейин ҳам давом этса, шахс «болаликдан ногирон» дейилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай шахсларга алоҳида пенсия ва имтиёзлар белгиланади. 18 ёшга тўлаётган болага ТИЭКдан қайта ўтиш, реабилитация ва ишга ўтиш бўйича олдиндан маслаҳат беринг.

18. Брайл алифбоси

Мазмуни: Кўзи ожизлар учун махсус нуқталардан иборат ёзув тизими бўлиб, бармоқлар билан сезиб ўқилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўзи ожиз мижозларга Брайл алифбоси билан таъминлаш давлат томонидан бир марта амалга оширилади (253-қарор). Мижозни Брайл ўрганишга, тифлопедагог ёки кўзи ожизлар жамиятига йўналтиринг.

В

19. Вазн мониторинги

Мазмуни: Беморнинг тана вазнини мунтазам ўлчаб, ўзгаришини кузатиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Вазннинг кескин камайиши ёки ортиши касаллик белгиси бўлиши мумкин. Кекса ва кичик болаларда вазнни ойда бир ёзиб боринг, ўзгариш бўлса шифокорга айтинг.

20. Васийлик ва ҳомийлик

Мазмуни: Ўз ҳуқуқини ўзи амалга ошира олмайдиганлар манфаатини ҳимоя қилиш тизими: васий — муомалага лаёқатсиз, ҳомий — лаёқати чекланган шахс учун.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижознинг пенсияси, мулки ва ҳужжатларини расмий васий ёки ҳомий бошқариши керак. Расмийлаштиришга ёрдам беринг ва васийнинг мижоз манфаатига хилоф иш қилмаслигини кузатинг.

21. Вирусли юклама

Мазмуни: ОИВ-инфекцияси бор одамнинг қонида вирус миқдори. Даво самарали бўлса, миқдор жуда пасаяди ва аниқланмайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Вирусли юклама аниқланмаса, одам бошқаларга вирус юқтирмайди ва оддий ҳаёт кечира олади. Мижозни доимий таҳлил топширишга ва дорини тартиб билан қабул қилишга ундаш лозим.

22. Витал белгилар (қон босими, пульс, ҳарорат, нафас)

Мазмуни: Организмнинг ҳаётий кўрсаткичлари: қон босими, юрак уриш сони (пульс), тана ҳарорати ва нафас олиш сони.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кекса ва оғир беморларда ўлчанади, четланиш бўлса шифокорга айтилади. Меъёр: пульс дақиқасига 60–90, қон босими тахминан 120/80.

Г

23. Гастростома

Мазмуни: Қорин деворидан ошқозонга қўйилган махсус най (тешик), у орқали беморга озиқ-овқат берилади. Ютиш бутунлай бузилганда қўйилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижозда най атрофини тоза сақлаш, озиқ берилгач ярим ўтирган ҳолатда ушлаш керак. Оилани парваришга ўргатинг, ҳамшира кўмагини таъминланг.

24. Гемоглобин

Мазмуни: Қондаги эритроцитлар (қизил қон таначалари) таркибидаги оқсил бўлиб, кислород ташийди. Унинг камайиши камқонлик (анемия) дейилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Гемоглобин кўрсаткичи қон таҳлилида кўрилади. Эркакларда меъёр тахминан 130–170 г/л, аёлларда 120–150 г/л. Паст гемоглобин ҳолсизлик ва тез чарчашга сабаб бўлади, шифокорга йўлланг.

25. Гемодиализ

Мазмуни: Буйраклар ишламай қолганда қонни «сунъий буйрак» аппарати билан тозалаш усули. Одатда ҳафтасига 2–3 марта, бир неча соатдан.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ногиронликка ва доимий қатновга муҳтож. Диализ марказига транспортни ташкил этинг, парҳез ва суюқлик чекловига риоя қилишда ёрдам беринг. Диализни ўтказиб юбориш ҳаётга хавфли.

26. Гериатрия

Мазмуни: Кекса ёшдаги одамлардаги касалликларни аниқлаш, даволаш ва уларнинг олдини олиш билан шуғулланувчи тиббиёт соҳаси.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кексаларда бир вақтда бир нечта касаллик ва кўп дори бўлади, шунинг учун гериатр кўриги самарали. Кексаларни гериатрик ва ижтимоий-тиббий хизматларга йўналтиринг.

27. Геронтология

Мазмуни: Қарилишнинг биологик, ижтимоий ва руҳий жиҳатларини ўрганувчи фан.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қариш — касаллик эмас, табиий жараён. Ёлғизлик ва ижтимоий фаолликни ҳисобга олинг, кексани ҳурмат қилинг ва мустақиллигини сақланг.

28. Гистология

Мазмуни: Тўқима парчасини микроскопда текшириш. Одатда ўсма хавфли ёки хавфсиз эканини аниқлашда ўтказилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Гистология хулосаси онкологик ташхисни тасдиқлайди ва ногиронлик белгилашда муҳим ҳужжат ҳисобланади. Мижозга хулоса натижасини кутиш даврида руҳий қўллаб-қувватлаш беринг, натижани шифокор тушунтириши лозимлигини айтинг.

29. Глюкометр

Мазмуни: Қондаги шакар (глюкоза) миқдорини ўлчайдиган кичик аппарат. Бармоқдан бир томчи қон олиб ўлчанади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Диабетли мижозлар учун асосий восита. Кўзи ожизларга овозли глюкометр берилади (253-қарор). Мижозга ўлчаш усулини ўргатинг, натижаларни дафтарга ёзиб боришни тавсия этинг.

30. Госпитализация

Мазмуни: Беморни даволаш ва кузатиш учун касалхонага ётқизиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ётқизишда ҳужжатлар (паспорт, полис), дори ва яқинларга хабар берилишини текширинг. Уйда қолувчи болалар ва кекса қариндошлар парвариш режасини тузинг.

Д

31. Даволаш гимнастикаси

Мазмуни: Беморнинг аҳволини яхшилаш ва ҳаракат қобилиятини тиклаш учун махсус танланган машқлар.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Инсульт, жароҳат ва контрактуралардан кейин жуда муҳим. Мижозга машқларни шифокор кўрсатмаси билан ва мунтазам қилишни тушунтиринг. Уйда машқ қилиш учун яқинларини ўргатинг.

32. Даволаш жисмоний тарбияси (ДЖТ)

Мазмуни: Касалликдан кейин тикланиш учун ўтказиладиган жисмоний машқлар тизими. Машғулотларни ДЖТ инструктори ёки мутахассис олиб боради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Реабилитация дастурига кириши мумкин. Мижозни ДЖТ хоналарига ёки реабилитация марказига йўналтириб, қатнашини назорат қилинг.

33. Дастурли гемодиализ

Мазмуни: Буйраклари ишламайдиган беморнинг қонини «сунъий буйрак» аппарати билан режали равишда (одатда ҳафтасига 2–3 марта) тозалаб туриш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижозлар учун ногиронлик белгиланади. Диализга қатнаш (транспорт), қатъий парҳез ва суюқлик чеклови бўйича ёрдам беринг. Диализни ўтказиб юбориш хавфли.

34. Декомпенсация

Мазмуни: Сурункали касалликнинг ёмонлашган, назоратдан чиққан ҳолати. Масалан, юрак касаллигида нафас қисилиши ва шиш кучайиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижознинг аҳволи тўсатдан ёмонлашса, шифокорга зудлик билан мурожаат қилинг. Декомпенсация даврида мижоз вақтинча касалхонага муҳтож бўлади.

35. Декомпенсация даври

Мазмуни: Касаллик назоратдан чиққан, организм энди ўз кучи билан курашолмайдиган давр. Бу даврда белгилар кучаяди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ПТПК хулосаларида декомпенсация босқичидаги юрак, нафас ва ҳазм касаллиги бор болалар тўлиқ кунлик боғчага қабул қилинмайди. Ижтимоий ходим мижозни шифокорга йўналтириши ва қўшимча парвариш режасини тузиши керак.

36. Дефекация кечикиши

Мазмуни: Ичак бўшалишининг (нажас чиқишининг) кечикиши, қабзият. Кексаларда ва ётоқ беморларда кўп учрайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тола (клетчатка)ли овқат, кўп суюқлик ва ҳаракат ёрдам беради. Узоқ вақт давом этса, шифокорга айтиш керак, чунки ичакнинг тиқилиши хавфли. Бемор уялиб айтмаслиги мумкин, бу ҳақда мулойимлик билан сўранг.

37. Дефектолог

Мазмуни: Болаларнинг ақлий, эшитиш, кўриш ёки нутқ ривожланишидаги нуқсонларни тузатиш билан шуғулланувчи мутахассис.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлиги бор ёки ривожланиши орқада қолган болалар оиласини дефектолог билан таништириш керак. Эрта аралашув хизматида ва махсус таълим муассасаларида ишлайди.

38. Диагноз

Мазмуни: Шифокорнинг беморда қандай касаллик борлиги ҳақидаги хулосаси (ташхис).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз диагнозини ўзи айтмаса, суриштирманг, у махфий маълумот. Ҳужжатларда ёзилган диагноз асосида нафақа, ногиронлик, реабилитация ва таълим масалалари ҳал бўлади.

39. Диагностика

Мазмуни: Касалликни аниқлаш учун текширувлар: таҳлиллар, рентген, УЗИ, кўрик, сўров.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни керакли текширувларга йўналтириш ва натижаларни йиғишда ёрдам беринг (ТИЭК ва ПТПК учун). Текширув натижасини шифокор тушунтиради.

40. Диализ

Мазмуни: Буйрак ишламай қолганда қонни зарарли моддалардан сунъий тозалаш. Ҳозирда асосан гемодиализ (аппарат орқали) қўлланилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Диализга муҳтожлик ногиронлик белгилаш учун асос. Қатнов, парҳез ва кайфиятга эътибор беринг; диализ беморлар учун руҳий жиҳатдан оғир.

41. Дискриминация

Мазмуни: Инсонни касаллиги, ногиронлиги, ёши ёки бошқа белгиси учун камситиш, ҳуқуқларини чеклаш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ОИВ, руҳий касаллик ва ногиронлиги бор одамлар кўпинча камситилади. Мижознинг ҳуқуқлари ҳимоя қилиниши ва камситиш ҳолатлари ҳақида тегишли органларга мурожаат қилишга ёрдам беринг.

42. Диспансеризация

Мазмуни: Аҳолини режали равишда тиббий кўрикдан ўтказиш ва касалликларни эрта аниқлаш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозларни, айниқса кексалар ва болаларни, кўрикдан ўтишга ундаш. Эрта аниқланган касаллик осон даволанади.

43. Диспансер назорати

Мазмуни: Сурункали касаллиги бор одамнинг шифокор томонидан мунтазам кузатилиши (рўйхатда туриш).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз диспансер кўригини ўтказиб юбормаслигини назорат қилинг. Масалан, диабет, туберкулёз ва руҳий касалликларда назорат муҳим. Ёлғиз яшовчи мижозларга эслатиб туриш керак.

Ж

44. Жарроҳликдан кейинги ҳолат

Мазмуни: Операциядан сўнг тикланиш даври: оғриқ, ҳолсизлик, чоклар парвариши ва аста-секин ҳаракатни тиклаш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз уйга чиққанда парвариш, дорилар ва текширувга бориш режасини тушунтиринг. Ёлғиз яшовчиларга овқат, тозалаш ва дори билан ёрдам керак бўлиши мумкин.

З

45. Зондли озиқлантириш

Мазмуни: Ўзи овқат ея олмайдиган беморга бурун орқали ошқозонга киритилган юпқа най (зонд) орқали суюқ овқат бериш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижозлар ўзгалар парваришига тўлиқ муҳтож. Оилани овқатлантириш ва найни парваришлашга ўргатиш керак: овқат бераётганда бемор ярим ўтирган ҳолда бўлиши лозим.

И

46. Иммун танқислик

Мазмуни: Организм ҳимоя тизимининг заифлиги. Туғма ёки орттирилган (масалан, ОИВ ёки дорилар туфайли) бўлиши мумкин. Одам инфекцияларга тез чалинади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни инфекциядан эҳтиёт қилиш (гавжум жойлардан узоқ тутиш, қўл ювиш). Касалликнинг оғир бўлиши ва асоратлар хавфи борлигини ҳисобга олинг.

47. Имо-ишора тили

Мазмуни: Эшитиш ва гапириш қобилияти бузилган одамлар ишлатадиган қўл ҳаракатлари ва юз ифодаси орқали мулоқот тили.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кар ёки заиф эшитувчи мижоз билан ишлаганда сурдотаржимон хизматидан фойдаланинг. Бундай мижозга овоз чиқариб эмас, юзма-юз ва аниқ ифодалаб гаплашинг.

48. Инклюзив таълим

Мазмуни: Алоҳида таълимга эҳтиёжи бор болаларнинг соғлом болалар билан бирга оддий мактабда ўқиши. Унга қулай шароит яратилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ота-оналарга инклюзив таълим ҳуқуқи бор эканини ва ПТПК орқали йўналиш олиш тартибини тушунтиринг. Мактабдаги ассистент ва бошқа ёрдам ҳақида маълумот беринг.

49. Инкурабел касаллик

Мазмуни: Тузалмайдиган, тўлиқ даволаб бўлмайдиган касаллик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай беморга ва оилага руҳий қўллаб-қувватлаш, оғриқни камайтириш ва паллиатив ёрдам керак. Беморнинг қолган умри давомида муносиб шароит яратишга ҳаракат қилинг.

50. Инсулин

Мазмуни: Қондаги шакар миқдорини тартибга солувчи гормон. Диабети бор одамларда у етишмайди ва уколлар билан киритилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Инсулин қабул қилувчи мижоз уколни вақтида олиши ва овқатни ўтказиб юбормаслиги керак. Дори музлаткичда сақланади. Кўзи ожизларга овозли глюкометр берилади.

51. Интоксикация

Мазмуни: Организмнинг заҳарланиши: инфекция, заҳарли модда, дори ёки касаллик маҳсулотлари сабабли. Ҳолсизлик, бош оғриғи, кўнгил айниши, иситма билан кечади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозда заҳарланиш белгилари бўлса, сабабини аниқлаш ва шифокорга мурожаат қилиш керак. Оғир ҳолда 103 га қўнғироқ қилинг.

52. Инфузия

Мазмуни: Дори ёки суюқликни томир ичига томчилатиб юбориш (томчи қўйиш).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз баъзан инфузия учун уйда ёки поликлиникада бўлиши керак. Ёлғиз яшовчи ёки қатнай олмайдиган мижозларга уйда тиббий ёрдам ташкил қилишга кўмаклашинг.

Й

53. Йиқилиш ва жароҳатланишнинг олдини олиш

Мазмуни: Йиқилишга олиб келувчи сабабларни (силлиқ пол, ёмон ёруғлик, зинапоя) камайтириш ва хавфсиз муҳит яратиш чоралари.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кексалар ва ногиронларда йиқилиш суяк синишига олиб келади. Уйда гиламларни олиб ташланг, тутқичлар ўрнатинг, ёруғликни кучайтиринг, қулай пойабзал киришни тавсия этинг.

К

54. Касаллик зўрайган давр

Мазмуни: Сурункали касалликнинг белгилари кучайган вақти: оғриқ, ҳарорат, нафас қисилиши ва ҳоказо.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Зўрайиш даврида мижознинг ишлаш ва ўзини парваришлаш қобилияти пасаяди, қўшимча ёрдам керак. Дориларни ўтказиб юбормасликни ва зўрайиш белгилари бўлса шифокорга мурожаат қилишни тушунтиринг.

55. Касбий реабилитация

Мазмуни: Ногирон ёки касалликдан кейин ишлай олмай қолган одамни касбга ўргатиш, қайта ўқитиш ва ишга жойлаштиришга қаратилган чоралар.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозни ёш, соғлиқ ва қобилиятига мос касбга йўналтиринг. Бандликка кўмаклашиш марказлари ва иш берувчилар билан ҳамкорлик қилинг.

56. Касб касаллиги

Мазмуни: Иш жойидаги зарарли омиллар (чанг, кимёвий моддалар, шовқин) таъсирида пайдо бўладиган касаллик. Масалан, силикоз, антракоз.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижозга ТИЭК орқали меҳнат лаёқатини йўқотиш даражасини белгилатиш ва тегишли тўловлар олиш мумкин. Иш жойидаги ҳужжатларни йиғишга ёрдам беринг.

57. Катетеризация

Мазмуни: Сийдик пуфагига ёки қон томирга юпқа най (катетер) киритиш. Сийдик пуфагига киритилса, сийдик чиқарилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Сийдик ушлай олмаган ёки чиқара олмаган беморлар учун ишлатилади. Катетер парвариши гигиенага қаттиқ риоя қилишни талаб қилади (инфекциянинг олдини олиш учун). Оилани ўргатиш ва ҳамшира ёрдамини ташкил қилиш керак.

58. Кислород терапияси

Мазмуни: Нафас олишга қийналган беморга кислородни махсус аппарат (кислород концентратори) ёки баллон орқали бериш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир ўпка ва юрак касаллиги бор мижозга уйда кислород керак бўлиши мумкин. Аппарат яқинида олов ёқмаслик ва чекмаслик муҳим. Таъминот ва электр узилишлари бўйича режа тузишга ёрдам беринг.

59. Клиник прогноз

Мазмуни: Касалликнинг келажакда қандай кечиши ҳақидаги шифокор фикри: тузалиш, барқарорлик ёки ёмонлашиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: «Нохуш клиник прогноз»да ногиронлик тезроқ ва муддатсиз белгиланиши мумкин. Прогноз ҳақида мижозга ва оилага шифокор тушунтириши керак; ижтимоий ходим руҳий қўллаб-қувватлаши лозим.

60. Клиник ташхис

Мазмуни: Беморни кўриш, шикоятлари ва текширув натижаларига асосланган шифокор ташхиси.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлик ёки нафақа ҳужжатларида клиник ташхис кўрсатилади. Ташхис МКБ-10 коди билан ёзилади. Ҳужжатдаги ташхис тўғри ва тўлиқ эканини текширинг.

61. Клиник-функционал маълумотлар

Мазмуни: Беморнинг касаллиги ва унинг организм ишлашига таъсири (юра оладими, кўрадими, ўзини эплайдими) ҳақидаги шифокор ва текширув маълумотлари.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ТИЭК ногиронлик белгилашда шу маълумотларга таянади. Мижознинг ҳужжатлари тўлиқ ва янги эканини текширинг.

62. Когнитив функциялар

Мазмуни: Бош миянинг ақлий ишлари: хотира, диққат, фикрлаш, нутқ ва маълумотни тушуниш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кексаларда ва инсульт ёки бош мия жароҳатидан кейин бузилади. Мижоз унутса ёки тушунмаса, уни ортиқча қистаманг, содда тушунтиринг. Баҳолаш учун MMSE каби тестлар қўлланилади.

63. Колостома

Мазмуни: Йўғон ичакнинг бир учини қорин деворига чиқариб, нажас тўпловчи халтага йўналтириш операцияси. Нажас табиий йўлдан эмас, шу тешикдан чиқади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Колостомаси бор мижоз халтани алмаштириш, терини парваришлаш ва уялишни енгиш учун ёрдамга муҳтож. Нажас йиғувчи халта керак бўлади. Колостома ногиронлик белгилаш асосларидан.

64. Компенсация

Мазмуни: Организмнинг касалликка қарамай меъёрида ишлашни сақлаб қолиши. Касаллик яхши назоратда бўлса, «компенсация даври» дейилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозда компенсация даври бўлса, у кўпроқ мустақил яшайди. Уни сақлаш учун дориларни тартиб билан ичиш ва шифокор назорати муҳим.

65. Коррекция

Мазмуни: Нуқсонни тузатиш ва камайтиришга қаратилган чоралар, масалан, нутқ нуқсонини логопед билан тузатиш ёки кўриш пасайишини кўзойнак билан тўғрилаш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болаларда коррекцион ёрдам эрта бошланса, натижа яхши бўлади. Мижозни тегишли мутахассис ва машғулотларга йўналтиринг.

66. Кохлеар имплантация

Мазмуни: Қулоқнинг ички қисмига электрон қурилма жойлайдиган операция. У эшитиш нервини электр импульслари билан бевосита қўзғатиб, карлар ва қаттиқ эшитмайдиганларга товушни эшитишга имкон беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола эрта ёшда имплантация қилинса, нутқ яхши ривожланади. Операциядан кейин қурилмани созлаш ва нутқ машғулотлари зарур. Ота-оналарга қурилмани сувдан асраш ва доимий созлаш муҳимлигини тушунтиринг.

67. Кундалик ҳаётий фаолият (ADL)

Мазмуни: Одамнинг ҳар куни қиладиган асосий ишлари: овқатланиш, ювиниш, кийиниш, ҳожатхонага бориш, ўрнидан туриш ва юриш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз шу ишларнинг қайсинисини ўзи қила олишини баҳолаб, қанча ёрдам кераклигини аниқлаш мумкин (Бартел индекси орқали). Бу ўзгалар парваришига муҳтожлик ва ёрдам режасининг асосий мезони.

68. Кундузги парвариш хизмати

Мазмуни: Ногиронлиги бор болаларга кундузи махсус марказда парвариш, тарбия ва реабилитация хизмати кўрсатиш. Кечқурун бола уйига қайтади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ота-оналар ишлаши ёки дам олиши учун қулайлик яратади. Оилага бундай хизматдан фойдаланиш тартибини тушунтиринг ва ПТПК хулосасини олишда ёрдам беринг.

Л

69. Лабдан ўқиш

Мазмуни: Эшитмайдиган ёки қаттиқ эшитадиган одамнинг гапираётган одамнинг лаби ва юз ҳаракатларига қараб нутқни тушуниши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кар мижоз билан юзма-юз, ёруғликка қараб ва секин, аниқ гаплашинг. Оғзингизни беркитманг ва тескари қараб гапирманг. Лабдан ўқиш ҳамма сўзни тушуниш имконини бермайди, шунинг учун ёзиб кўрсатинг.

70. Лисфранк чўлтоқлиги

Мазмуни: Оёқ панжасининг ўрта қисмидан (Лисфранк бўғими даражасида) ампутация қилингандан кейин қоладиган чўлтоқ. Товон ва панжанинг орқа қисми сақланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз юра олади, лекин махсус протез ёки ортопедик пойабзал керак. Чўлтоқ терисини жароҳатдан асраш ва тоза сақлаш муҳим.

71. Логопед

Мазмуни: Нутқ нуқсонларини аниқлаш ва тузатиш билан шуғулланувчи мутахассис.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Нутқи кечикган, дудуқланувчи ёки инсультдан кейин гапира олмаётган мижозни логопедга йўналтиринг. Қанчалик эрта бошланса, шунчалик яхши натижа беради.

72. Лоутон шкаласи (IADL)

Мазмуни: Одамнинг мураккаб кундалик ишларни (телефон, бозорлик, овқат тайёрлаш, дори ичиш, пул ишлатиш) бажара олишини баҳолаш жадвали.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кексалар ва ногиронлар қанча ёрдамга муҳтожлигини аниқлашда ёрдам беради. Мижоз қайси ишларни ўзи эплай олмаслигини кўриб, хизмат режасини тузинг.

M

73. Майда қўл моторикаси

Мазмуни: Бармоқлар ва қўлнинг нозик ҳаракатларини бажариш қобилияти: ёзиш, тугма тақиш, қошиқ тутиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болаларда ривожланиши ёзишга тайёрликни кўрсатади. Инсульт ва артритдан кейин бузилиши мумкин; бундай мижозларга машқ, меҳнат терапияси ва қулай ашёлар (йўғон ручка, қошиқ) ёрдам беради.

74. Массаж

Мазмуни: Мушаклар ва тўқималарга қўл билан таъсир қилиш орқали қон айланишини яхшилаш, мушакларни бўшатиш ва оғриқни камайтириш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Реабилитацияда, айниқса фалаж, БЦФ ва жароҳатлардан кейин кенг қўлланилади. Баъзи касалликларда (ўсма, тромбоз, юқори ҳарорат) мумкин эмас, шунинг учун шифокор рухсати зарур.

75. Меҳнатда майибланиш

Мазмуни: Иш жараёнида олинган жароҳат ёки соғлиқнинг бузилиши (иш жойидаги ҳодиса).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай ҳолатда иш берувчи ва ижтимоий суғурта томонидан тўловлар кўзда тутилган. Ҳодиса ҳақидаги ҳужжатлар (далолатнома) йиғилишига ёрдам беринг ва мижознинг ҳуқуқларини тушунтиринг.

76. Меҳнат лаёқатининг йўқотилиши даражаси

Мазмуни: Касаллик ёки жароҳат сабабли одамнинг ишлаш қобилияти қанча фоиз пасайганини ифодаловчи кўрсаткич.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ТИЭК томонидан белгиланади ва меҳнат майиблиги ёки касб касаллигида тўловлар миқдорига таъсир қилади. Мижозга бу фоиз нима эканини тушунтиринг ва керакли ҳужжатларни тайёрлашга ёрдам беринг.

77. Меҳнат терапияси

Мазмуни: Беморни кундалик ва иш фаолиятига қайтаришга қаратилган машғулотлар: кийиниш, овқат тайёрлаш, оддий ишларни бажариш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Инсульт, жароҳат ва руҳий касалликлардан кейин мустақилликни тиклашга ёрдам беради. Мижозни реабилитация марказидаги эрготерапевт ёки меҳнат терапияси хизматига йўналтиринг.

78. Мустақил яшаш кўникмалари

Мазмуни: Одамнинг бошқаларга боғланмай яшаши учун зарур малакалар: овқат тайёрлаш, пул ишлатиш, гигиена, транспортдан фойдаланиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлиги бор ёшлар ва ички интернатдан чиққанлар учун жуда муҳим. Бу кўникмаларни босқичма-босқич ўргатинг ва ўрганишини қўллаб-қувватланг.

79. Мушак кучи

Мазмуни: Мушакнинг қанчалик кучли қисқариши ва юк кўтара олиши. Одатда 0 дан 5 гача баллда баҳоланади (0 — ҳаракат йўқ, 5 — меъёридаги куч).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Фалаж ва мушак касалликларида ҳужжатларда бу баллар ёзилади. Баллар паст бўлса, мижозга кўпроқ ёрдам ва воситалар керак.

80. Мушак тонуси (гипотония)

Мазмуни: Мушакларнинг дам олиш пайтидаги таранглиги. Гипотония — мушаклар ортиқча бўш, юмшоқ; гипертонус — ортиқча таранг.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мушак тонуси бузилиши болаларда (БЦФ, Даун синдроми) тез-тез учрайди. Бундай болага эрта массаж, гимнастика ва ортопедик воситалар ёрдам беради.

81. Мўлжал олиш ва ҳаракатланиш (мобиллик)

Мазмуни: Одамнинг фазода ўзини йўналтира олиши ва бир жойдан иккинчи жойга ўтиш қобилияти.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўзи ожиз, юра олмайдиган ва деменцияли мижозларда бузилади. Уйни ва йўлларни хавфсиз қилинг, ҳасса, ходунок ёки кресло-аравача билан таъминлашга ёрдам беринг, йўналишни ўргатувчи мутахассисни таклиф қилинг.

Н

82. Невролог

Мазмуни: Бош ва орқа мия, нервлар ва мушакларнинг касалликларини даволовчи шифокор.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Инсульт, тутқаноқ, Паркинсон, БЦФ, бош оғриғи ва ҳаракат бузилишларида мижозни шу шифокорга йўналтиринг. Ногиронликда унинг хулосаси асосий ҳужжатлардан бири.

83. Нейролептик дорилар

Мазмуни: Руҳий касалликларни (шизофрения, психоз) даволашда ишлатиладиган дорилар. Алаҳлаш, галлюцинация ва қўзғалишни камайтиради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз дорини ўзбошимчалик билан тўхтатмаслиги керак. Кўп ҳолларда уйқучанлик, қўл титраши, оғиз қуриши каби ножўя таъсирлар бўлади. Бундай шикоятларни шифокорга айтишга ёрдам беринг.

84. Ногиронлиги бўлган шахс

Мазмуни: Узоқ муддатли жисмоний, руҳий, ақлий ёки сезги бузилишлари туфайли ҳаётдаги бошқа одамлар каби тўлиқ қатнаша олишда чекловлар мавжуд бўлган инсон.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: «Ногирон» ўрнига «ногиронлиги бўлган шахс» деб муомала қилинг, бу ҳурмат белгиси. Мижозга ҳуқуқлари, имтиёзлари ва ёрдам турлари ҳақида тушунтиринг.

85. Ногиронлик

Мазмуни: Соғлиқ бузилиши натижасида ҳаётий фаолиятнинг доимий чекланиши, бунинг оқибатида ижтимоий ҳимоя ва ёрдамга эҳтиёж пайдо бўлиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлик одамнинг қадр-қимматини камайтирмайди. Унга мустақил ҳаёт, таълим, иш ва жамият ҳаётида қатнашиш учун шароит яратиш лозим.

86. Ногиронлик гуруҳи

Мазмуни: Соғлиқ ҳолати ва ҳаётий фаолият чекловлари даражасига қараб белгиланадиган ногиронлик тоифаси (I, II, III гуруҳ; болаларда — «16 ёшгача ногирон бола»).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Гуруҳ нафақа, имтиёзлар ва ёрдам турларини белгилайди. Гуруҳни ТИЭК белгилайди. Мижозга қайта кўрикдан ўтиш вақтларини эслатиб туринг.

87. Ногиронлик сабаби

Мазмуни: Ногиронлик қандай ҳолатдан келиб чиққанини кўрсатувчи ёзув: умумий касаллик, меҳнатда майибланиш, касб касаллиги, болаликдан ногиронлик ва ҳоказо.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Сабабга қараб нафақа ва тўловлар ўзгаради. Ногиронлик маълумотномасидаги сабабнинг тўғри ёзилганини текширинг.

88. Ногиронлик тўғрисидаги маълумотнома

Мазмуни: ТИЭК томонидан берилган ҳужжат: ногиронлик гуруҳи, сабаби ва муддати кўрсатилган.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Нафақа, имтиёзлар ва реабилитация воситаларини олиш учун асосий ҳужжат. Муддати тугамасидан олдин қайта кўрикка тайёргарлик кўришни эслатинг.

89. Нур билан даволаш

Мазмуни: Радиация нурларидан (нур терапияси) ёки физиотерапевтик нурлардан фойдаланиб касалликларни, асосан ўсмаларни, даволаш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Саратон беморлари бир неча ҳафта давомида такрорий даволанишга келади. Ҳолсизлик, тери қизариши ва иштаҳа йўқлиги бўлади. Бемор ва оила учун транспорт ва ёрдамни ташкил қилишга кўмак беринг.

90. Нутқий мулоқот

Мазмуни: Одамнинг сўзлар билан фикр билдириши ва бошқаларнинг нутқини тушуниши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Нутқий мулоқот бузилган мижозга (инсульт, кар, аутизм) қўшимча усулларни (расм, ёзув, имо-ишора) қўллаш керак. Уларнинг фикрини шошилмасдан тинглаб, тушунишга ҳаракат қилинг.

О

91. Оилавий шифокор

Мазмуни: Бутун оила аъзоларини кузатувчи ва даволовчи биринчи навбатда мурожаат қилинадиган шифокор (оилавий поликлиника шифокори).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга биринчи навбатда шу шифокорга мурожаат қилиш лозим. У мутахассислар кўригига йўлланма беради ва диспансер назоратини олиб боради.

92. Олигофренопедагог

Мазмуни: Ақлий ривожланиши орқада қолган болалар билан ишлайдиган махсус педагог.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ақлий заифлиги бор болаларнинг оилаларини шу мутахассис билан таништириш керак. Махсус таълим муассасаларида ишлайди; боланинг имкониятини ва ривожланиш режасини тузишга ёрдам беради.

93. Ортопед-травматолог

Мазмуни: Суяк, бўғим, мушак ва пайларнинг жароҳатлари ва касалликларини даволовчи шифокор.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Суяк синиши, бўғим касаллиги, оёқ деформацияси ва протез ёки ортопедик восита керак бўлганда шу шифокорга йўналтиринг. Протез-ортопедия воситаларига йўлланмани у беради.

94. Орфан (камёб) касалликлар

Мазмуни: Жуда кам учрайдиган, кўпинча ирсий ва оғир касалликлар. Даволаш усуллари чекланган ва қиммат бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай касаллиги бор болаларнинг оилалари тиббий ва молиявий қийинчилик, ёлғизликни бошидан кечиради. Уларни махсус марказ ва давлат дастурлари билан таништиринг, руҳий қўллаб-қувватланг.

95. Отоларинголог

Мазмуни: Қулоқ, томоқ ва бурун касалликларини даволовчи шифокор (ЛОР).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Эшитишнинг пасайиши, овоз бўғилиши, қулоқ оғриғи ва бурун битиши билан мурожаат қилишда шу шифокорга юборинг. Эшитиш мосламаси учун ҳам у хулоса беради.

96. Офтальмолог

Мазмуни: Кўз касалликлари ва кўриш бузилишларини даволовчи шифокор (кўз шифокори).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўриш пасайган, диабети бор, 40 ёшдан катта мижозларни йилига бир марта шу шифокор кўригидан ўтказиш керак. Кўзойнак, ҳасса ва ногиронлик учун хулоса беради.

97. Оғриқ синдроми

Мазмуни: Узоқ давом этадиган ёки кучли оғриқ касалликнинг асосий белгиси бўлиши (масалан, онкологик ёки бўғим оғриғи).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғриқ одамнинг уйқуси, кайфияти ва ҳаракатини бузади. Мижознинг оғриғига ишонинг, уни камситманг. Беморга оғриқ қолдирувчи дориларни шифокор тавсиясига кўра ичишга ёрдам беринг.

П

98. Паллиатив даво

Мазмуни: Тузалмайдиган касалликларда касалликни бартараф этиш эмас, оғриқ ва бошқа азобларни камайтириб, ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган даволаш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу «таслим бўлиш» эмас, бемор ва оила учун ёрдам. Оғир саратон, ОИТС ва юрак етишмовчилигининг охирги босқичида берилади. Оилага шу ёрдам турлари ҳақида хабар беринг.

99. Паллиатив ёрдам

Мазмуни: Тузалмайдиган касаллиги бор беморларга тиббий, руҳий ва ижтимоий ёрдам тизими. Оғриқни камайтириш, парвариш ва оилани қўллаб-қувватлашни ўз ичига олади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Беморнинг қадр-қимматини сақлаган ҳолда охирги кунларини тинч ўтказишига ёрдам беради. Ижтимоий ходим оилани руҳий қўллаб-қувватлайди ва махсус хизматлар билан боғлайди.

100. Парваришга муҳтож шахс

Мазмуни: Соғлиғи сабабли ўзига хизмат қила олмайдиган ва доимий ёки вақтинчалик бошқа одам ёрдамига муҳтож инсон.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижоз учун парвариш режаси тузилади (овқат, гигиена, дори, ҳаракат). Керак бўлса, парвариш қилувчи ходим ёки ижтимоий хизматлар ташкил қилинади. Парваришни ким қилаётганини ва унинг ҳолатини ҳам кузатиб боринг.

101. Парваришлаш

Мазмуни: Беморга ёки ногиронлиги бор одамга кундалик эҳтиёжларида ёрдам бериш: овқатлантириш, ювиниш, кийинтириш, ҳолатини ўзгартириш, дори бериш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Парваришни ҳурмат ва меҳр билан қилиш керак. Мижознинг одатлари ва хоҳишини ҳисобга олинг. Оила аъзоларига тўғри парвариш усулларини ўргатинг.

102. Парентерал озиқлантириш

Мазмуни: Овқатни ошқозон-ичак орқали эмас, балки озуқа аралашмаларини томир ичига юбориш орқали озиқлантириш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Овқат ея олмайдиган оғир беморларда қўлланилади, асосан касалхонада. Бундай мижоз ва оила катта қўллаб-қувватлашга муҳтож.

103. Парҳез таом

Мазмуни: Касалликка мос махсус тайёрланган овқат (масалан, диабетда шакарсиз, буйрак касаллигида тузсиз).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз парҳезга риоя қилмаса, касаллик зўраяди. Нима мумкин ва нима мумкин эмаслигини ёзиб беринг ва оилага тушунтиринг. Ёлғиз қолган кексаларга тўғри овқатланишни ташкил қилишда ёрдам беринг.

104. Педиатр

Мазмуни: Болаларнинг (туғилгандан 14–18 ёшгача) касалликларини даволовчи шифокор.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бола соғлиғи, ривожланиши ва эмлашлар бўйича биринчи мурожаат этиладиган шифокор. Боланинг ривожланишдаги орқада қолишини ёки ногиронлик аломатларини сезсангиз, ота-онани педиатрга юборинг.

105. Пирогов чўлтоқлиги

Мазмуни: Оёқ панжаси олиб ташланиб, товон суяги сақланиб қолган ва болдир суягига туташтирилган ампутация чўлтоғи.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз махсус протез билан ёки ортопедик пойабзал билан юра олади. Чўлтоқ терисини парваришлаш ва жароҳатдан сақлашни тушунтиринг.

106. Профилактика

Мазмуни: Касалликнинг олдини олиш чоралари: эмлаш, соғлом турмуш тарзи, кўрик, таҳлиллар.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ижтимоий ходимнинг энг муҳим вазифаларидан. Мижозларни эмлашга, кўрикка, соғлом овқатланишга ва хавфли одатлардан воз кечишга ундаш касалликларни камайтиради.

107. Психиатр

Мазмуни: Руҳий касалликларни ташхислайдиган ва даволовчи шифокор.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозда алаҳлаш, кучли депрессия, ўз жонига қасд хавфи ёки одатдан ташқари хатти-ҳаракат бўлса, психиатрга йўналтиринг. Руҳий касалликка нисбатан қўрқув ва камситишни камайтириш ижтимоий ходимнинг иши.

108. Психолог

Мазмуни: Инсон руҳияти, хулқ-атвор ва ҳис-туйғулари билан ишлайдиган мутахассис. Шифокор эмас ва дори бермайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Стресс, оилавий низо, йўқотиш, болалар тарбияси ва қийинчиликларда мижозга психолог суҳбати ёрдам беради. Унинг хулосаси ПТПК ва реабилитацияда ҳам керак.

109. Психологик ёрдам

Мазмуни: Қийин вазиятдаги одамга ҳис-туйғуларини енгиш, ўзини тиклаш ва қарор қабул қилишда берилаётган ёрдам: суҳбат, маслаҳат, машғулот.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлик, касаллик, зўравонлик ва йўқотишдан кейин мижозга ва оила аъзоларига керак. Уни тинглаб, айбламасдан ёрдам бериш — ижтимоий ходимнинг асосий иши.

110. Психологик-тиббий-педагогик комиссия (ПТПК)

Мазмуни: Болаларнинг ривожланишини баҳолаб, қайси таълим шакли (оддий, инклюзив, махсус) мос эканини аниқловчи комиссия.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ривожланишида орқада қолган ёки ногиронлиги бор болаларнинг ота-оналарини комиссияга йўналтиринг. Комиссия хулосаси болани тўғри ўқитиш ва реабилитация қилишнинг асоси.

111. Психоневролог

Мазмуни: Болалар ва катталарда асаб тизими ва руҳий ривожланиш бузилишлари билан шуғулланувчи шифокор.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ақлий ривожланиш кечикиши, тутқаноқ, нутқ бузилиши ва хулқ-атвор муаммоларида болани шу шифокорга юборинг. Унинг хулосаси ПТПК ва ногиронлик учун керак.

Р

112. Реабилитацион эксперт диагностикаси

Мазмуни: Одамнинг соғлиғи, ҳаракат ва ишлаш қобилиятини комплекс баҳолаш бўйича экспертиза: шифокорлар, психолог ва бошқа мутахассислар иштирок этади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ТИЭК ногиронлик ва реабилитация эҳтиёжини белгилаш учун шундай диагностикани ўтказади. Мижозга нималарни олиб бориш кераклигини тушунтиринг ва ҳужжатларни тайёрлашга ёрдам беринг.

113. Реабилитация

Мазмуни: Касаллик ёки жароҳатдан кейин ҳаракат, нутқ, ақлий ва ижтимоий қобилиятларни тиклаш ва мустақилликни қайтаришга қаратилган чоралар мажмуаси.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Реабилитация тиббий, касбий, ижтимоий ва педагогик бўлиши мумкин. Ижтимоий ходим мижозни керакли турдаги реабилитацияга йўналтиради ва ундан қатнашишини қўллаб-қувватлайди.

114. Реабилитация башорати

Мазмуни: Реабилитация орқали одамнинг қанчалик тикланиши ва қобилиятини қайтариши мумкинлиги ҳақидаги хулоса (ижобий, чекланган ёки ноқулай).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга ва оилага реал кутилмаларни тушунтиринг. Башорат ёмон бўлса ҳам, ҳаёт сифатини яхшилаш чоралари муҳим.

115. Реабилитация потенциали

Мазмуни: Реабилитация орқали одамда қайси қобилиятларни тиклаш ёки ривожлантириш имконияти борлигини кўрсатувчи ички захира.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Потенциал юқори бўлса, мижоз кўпроқ тикланади ва мустақил бўлиши мумкин. Мижознинг кучли томонларини аниқлаш ва уларга таяниш керак.

116. Реабилитация қилишнинг техник воситалари

Мазмуни: Ногиронлиги бор одамга кундалик ҳаётда мустақил бўлишига ёрдам берувчи мосламалар: кресло-аравача, ходунок, ҳасса, эшитиш мосламаси ва бошқалар.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз эҳтиёжига мос воситани аниқлашда ёрдам беринг ва уни олиш учун тегишли йўлланма ва ҳужжатларни расмийлаштиришга кўмак беринг. Воситадан тўғри фойдаланишни ўргатиш ҳам муҳим.

117. Реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастури (РЯТД)

Мазмуни: Ҳар бир ногиронлиги бор одам учун алоҳида тузиладиган режа: қандай реабилитация чоралари, воситалар ва ёрдамлар керак.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ТИЭК томонидан тузилади. Ижтимоий ходим мижозга дастурда нималар борлигини тушунтириши ва унинг амалга оширилишини кузатиши керак.

118. Ремиссия

Мазмуни: Касаллик белгиларининг сезиларли камайиши ёки йўқолиши (соғайиш эмас, тинч давр).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ўзини яхши ҳис қилса ҳам, дорини ўзбошимчалик билан тўхтатмаслиги керак. Кўп касалликлар (руҳий, онкологик, аутоиммун) қайталаниши мумкин.

119. Ремиссия даври

Мазмуни: Касалликнинг тинч, белгисиз ёки жуда кучсиз даври.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу даврда мижоз ишлаши ва мустақил яшаши мумкин, лекин дори ва шифокор назоратини давом эттириш керак. Қайталанишнинг дастлабки белгиларини билиб қўйиш муҳим.

120. Рентгенологик текширув

Мазмуни: Рентген нурлари ёрдамида ички аъзолар ва суякларнинг расмини олиш орқали касалликларни аниқлаш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ҳужжатларида рентген хулосаси кўп бўлади. Ҳомиладор аёлларга рентген хавфли эканини айтиб қўйинг. Текширувга келишда ёрдам керак бўлиши мумкин.

121. Рецидив (касалликнинг қайталаниши)

Мазмуни: Тузалгандек кўринган ёки тинч даврдан кейин касалликнинг яна қайтиб келиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Белгилар қайтса, мижоз дарҳол шифокорга боришини таъминланг. Онкологик ва руҳий касалликларда қайталанишнинг эрта аниқланиши муҳим.

122. Ромберг позаси

Мазмуни: Мувозанатни текшириш усули: одам оёқларини бирлаштириб, қўлларини олдинга чўзиб, кўзларини юмиб тик туради. Агар чайқалса ёки йиқилса, мувозанат бузилган.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Неврологик ҳужжатларда учрайди ва мувозанат бузилишини кўрсатади. Бундай мижоз йиқилиш хавфи остида, уйни хавфсиз қилиш керак.

С

123. Симптом

Мазмуни: Касалликнинг белгиси, масалан, ҳарорат, оғриқ, йўтал.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз шикоятларини диққат билан тинглаб, шифокорга аниқ айтиб бериш учун ёзиб боринг: қачон бошланди, қанчалик кучли.

124. Симптоматик даво

Мазмуни: Касалликнинг сабабини эмас, унинг белгиларини (оғриқ, ҳарорат, қайт) камайтиришга қаратилган даво.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тузалмайдиган касалликларда мижознинг ҳаёт сифатини яхшилайди. Бунда ҳам шифокор тавсияси бўйича даволаниш керак.

125. Синдром

Мазмуни: Бир-бири билан боғлиқ белгилар мажмуаси, у битта сабабдан ёки турли сабаблардан бўлиши мумкин (масалан, Даун синдроми).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ҳужжатларда «синдром» сўзи учраса, бу бир-бири билан боғлиқ белгилар мажмуаси тавсифланганини билдиради. Тушунмаган бўлсангиз, шифокордан сўранг.

126. Скрининг

Мазмуни: Касаллик белгилари бўлмаган одамларда касалликни эрта аниқлаш учун оммавий текширув (масалан, чақалоқларда эшитиш, кексаларда қон босими).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозларни скрининг текширувларидан ўтишга ундаш касалликни эрта топишга ёрдам беради.

127. Соматик касаллик

Мазмуни: Руҳий бўлмаган, жисмоний аъзолар касаллиги (юрак, ўпка, буйрак, жигар ва бошқалар).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Соматик ва руҳий касалликлар бир-бирига таъсир қилади: оғир жисмоний касаллик депрессияга олиб келиши мумкин, шунинг учун мижознинг руҳий ҳолатига ҳам эътибор беринг.

128. Стационар даволаш

Мазмуни: Беморни касалхонада ётқизиб даволаш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ётқизиш керак бўлса, мижозга йўлланма олиш, ҳужжат ва уй ишларини ташкил қилишда ёрдам беринг. Ёлғиз яшовчиларнинг уйи ва уй ҳайвонларини ким қарашини ҳал қилинг.

129. Стигма (стигматизация)

Мазмуни: Касаллиги ёки ногиронлиги бор одамга нисбатан салбий қараш, «тамға» босиш ва камситиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ОИВ, руҳий касаллик, сил, тутқаноқ ва ногиронлиги бор одамлар кўпинча стигмага учрайди. Бу уларни даволанишдан ва ёрдам сўрашдан тўхтатади. Ижтимоий ходим ҳурмат билан муносабат қилиб, жамиятни ҳам маърифатлантириши керак.

130. Сурдопедагог

Мазмуни: Кар ва заиф эшитувчи болалар билан ишлайдиган махсус педагог.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Эшитиши бузилган болаларнинг оилаларини сурдопедагог билан таништиринг: у боланинг нутқи ва таълимига ёрдам беради.

131. Сурдотаржимон

Мазмуни: Эшитмайдиган одам ва эшитувчи одам ўртасида имо-ишора тилида таржима қилувчи мутахассис.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кар мижоз билан муҳим суҳбат (шифокор кўриги, ТИЭК) учун сурдотаржимонни олдиндан таклиф қилинг. Мижознинг яқинини таржимон ўрнига қўйманг.

Т

132. Тактил сезувчанлик

Мазмуни: Тери орқали теккизиш, босим ва ҳароратни сезиш қобилияти.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўр-кар одам билан мулоқот тактил усул орқали бўлади. Диабет ва нерв касалликларида бу сезгининг йўқолиши жароҳат ёки куйишни сезмасликка олиб келиши мумкин.

133. Терапевт

Мазмуни: Катталарнинг ички аъзолар касалликларини ташхислайдиган ва даволайдиган шифокор.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга биринчи навбатда терапевт кўриги керак бўлади. У керак бўлса, бошқа мутахассисга юборади.

134. Терминал босқич

Мазмуни: Касалликнинг охирги босқичи, бунда даволаш натижа бермайди ва умр қисқа қолиши кутилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай беморга оғриқни камайтириш, парвариш ва руҳий қўллаб-қувватлаш керак. Оилага ҳам ёрдам беринг, беморнинг хоҳишини (қаерда бўлишни) ҳурмат қилинг.

135. Тиббий-ижтимоий экспертиза

Мазмуни: Соғлиқ ҳолати ва ҳаёт фаолиятининг чекланишини баҳолаб, ногиронлик ва реабилитация эҳтиёжини аниқлаш жараёни.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга экспертизага қандай тайёрланиш, қандай ҳужжат олиш кераклигини тушунтиринг ва уни кузатиб боришга ёрдам беринг.

136. Тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси (ТИЭК)

Мазмуни: Ногиронликни белгилайдиган ва реабилитация дастурини тузадиган комиссия: унда шифокорлар ва бошқа мутахассислар иштирок этади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлик олиш, гуруҳни ўзгартириш ва қайта кўрикда мижозни тайёрлашга ва ҳужжатларни тўплашга ёрдам беринг.

137. Тиббий кўрсатма ва қарши кўрсатма

Мазмуни: Кўрсатма — қайси ҳолатда даволаш ёки текширув керак. Қарши кўрсатма — қайси ҳолатда у мумкин эмас ёки хавфли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Масалан, баъзи касалликларда массаж, иссиқ ёки жисмоний юкламага қарши кўрсатма бор. Мижозга бирор нарсани тавсия қилишдан олдин шифокор билан келишинг.

138. Тифлопедагог

Мазмуни: Кўзи ожиз ва заиф кўрувчи болалар ва катталар билан ишлайдиган мутахассис: Брайл ёзуви, ҳассада юриш, мўлжал олишни ўргатади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўриш бузилган мижозни шу мутахассис билан таништириш уларнинг мустақиллигини оширади.

139. Тиффно индекси

Мазмуни: Ўпка ишини текширишда ишлатиладиган кўрсаткич: бир сонияда чиқарилган ҳавонинг умумий ҳавога нисбати. Нафас йўллари торайишини кўрсатади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ўпка касаллиги бор мижоз ҳужжатларида учрайди. Кўрсаткич паст бўлса, ўпка ишлаши бузилганини билдиради.

140. Тонометр

Мазмуни: Қон босимини ўлчайдиган асбоб.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қон босими юқори мижозларга уйда ўлчашни ўргатинг ва натижаларни ёзиб боришни маслаҳат беринг. Кўзи ожизлар учун овозли тонометр бор.

141. Трансплантация

Мазмуни: Касалланган аъзони донордан олинган соғлом аъзо билан алмаштириш (буйрак, жигар, юрак ва бошқалар).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Трансплантациядан кейин бемор умр бўйи иммунитетни пасайтирувчи дорилар ичади, инфекциядан эҳтиёт бўлиши керак. Дорилар узилмаслиги ва шифокор назоратида бўлишига ёрдам беринг.

142. Трансфузия

Мазмуни: Беморга донор қонини ёки унинг таркибий қисмларини қуйиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Талассемия, лейкоз, кўп қон йўқотишда керак. Мунтазам қон қуйиладиган мижозларни даволаниш режаси бўйича кузатиб боринг.

У

143. Узоқ муддатли парвариш

Мазмуни: Узоқ вақт (ойлар, йиллар) давомида ўзига хизмат қила олмайдиган одамга бериладиган доимий парвариш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Парвариш қилувчи оила аъзолари чарчаши мумкин: уларга дам олиш ва руҳий ёрдам имкониятини яратинг. Керак бўлса, ижтимоий хизматлар ва ёрдамчилар ташкил қилинг.

144. Уй шароитида қараб туриш хизмати

Мазмуни: Ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бор одамларга уйда ижтимоий-маиший ёрдам кўрсатиш (озиқ-овқат, тозалаш, дори олиб келиш ва бошқалар).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу хизмат орқали мижоз ўз уйида узоқ яшайди. Хизмат сифатини, мижоз қониқишини ва хавфсизлигини кузатиб боринг.

145. Умумий касаллик

Мазмуни: Меҳнат жароҳати ёки касб касаллиги бўлмаган, умумий сабабларга кўра пайдо бўлган касаллик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлик сабаби «умумий касаллик» деб ёзилса, бу нафақа ҳисобига таъсир қилади. Иш билан боғлиқ бўлса, касб касаллиги эканини аниқлашга ёрдам беринг.

Ф

146. Физиотерапия

Мазмуни: Касалликларни табиий омиллар билан даволаш: иссиқлик, ток, магнит, нур, массаж.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Реабилитацияда кенг қўлланилади. Баъзи ҳолатларда (ўсма, юқори ҳарорат) мумкин эмас, шунинг учун шифокор рухсатисиз бошламанг.

147. Флюорография

Мазмуни: Ўпканинг рентген текшируви, кўкрак қафасини расмга олиш орқали сил ва бошқа ўпка касалликларини аниқлайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозларни йилига камида бир марта ўтиш учун ундаш керак. Узоқ йўтал, озиш ва терлашда шифокорга юборинг. Ҳомиладорларга эҳтиёт бўлиш лозим.

148. Фтизиатр

Мазмуни: Сил касаллигини ташхислайдиган ва даволайдиган шифокор.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Сил белгилари бор ёки силга чалинган мижозни шу шифокорга йўналтиринг. Даволаш давомида мижозни қўллаб-қувватланг.

149. Функционал синф (NYHA)

Мазмуни: Юрак етишмовчилигининг оғирлигини 4 синфга бўлиш: I — деярли белги йўқ; IV — дам олганда ҳам нафас қисилади. Синф қанча юқори бўлса, касаллик шунча оғир.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлик ҳужжатларида учрайди. Синф юқори бўлса, мижозга кўпроқ парвариш ва ёрдам керак.

150. Функциялар бузилиши даражалари (енгил, ўртача, ифодаланган, кучли ифодаланган)

Мазмуни: Организм вазифаларининг (ҳаракат, кўриш, нутқ, ақл) бузилиш даражасини баҳолаш: енгил, ўртача, ифодаланган ва кучли ифодаланган.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлик гуруҳини белгилашда асосий мезонлардан. Даража қанча юқори бўлса, ногиронлик гуруҳи ва парваришга эҳтиёж шунча катта.

X

151. Хавф гуруҳидаги болалар

Мазмуни: Соғлиқ, ривожланиш ёки ижтимоий муаммолар хавфи юқори бўлган болалар (оғир оилавий шароит, чала туғилган, ота-онасиз қолган ва ҳоказо).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай болаларни доимий кузатиш, оилага ёрдам бериш ва керак бўлса, ҳимоя органларига хабар бериш ижтимоий ходимнинг вазифаси.

152. Халқаро касалликлар таснифи (МКБ-10)

Мазмуни: Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти тузган касалликлар рўйхати: ҳар бир касалликка ҳарф ва рақамдан иборат код берилган (масалан, E11 — қандли диабет 2-тур).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлик ва тиббий ҳужжатларда ташхис МКБ-10 коди билан ёзилади. Кодни билсангиз, касалликни тезроқ аниқлайсиз.

153. Химиотерапия

Мазмуни: Саратон ҳужайраларини йўқотувчи кучли дорилар билан даволаш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бемор сочи тўкилиши, кўнгил айниши, ҳолсизлик, инфекцияга мойиллик каби ножўя таъсирларни бошдан кечиради. Уни қўллаб-қувватланг, касалхонага қатнашда ёрдам беринг.

154. Хирург

Мазмуни: Касалликларни операция йўли билан даволайдиган шифокор.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Операция олдидан мижозга ва оилага нималарни кутиш, қандай тайёрланиш лозимлигини тушунтиришга ёрдам беринг. Операциядан кейинги парваришни ташкил қилинг.

155. Холестерин

Мазмуни: Қондаги ёғсимон модда. Кўп бўлса, қон томирларда пилакчалар ҳосил бўлиб, инфаркт ва инсульт хавфини оширади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга ёғли овқатни камайтириш, ҳаракат қилиш ва шифокор дорисини ичиш керак. Йилига бир марта қон таҳлилини топширишни эслатинг.

Ц

156. Цитостатик терапия

Мазмуни: Тез кўпаядиган ҳужайралар (ўсма, иммун) ўсишини тўхтатувчи дорилар билан даволаш. Саратон ва аутоиммун касалликларда қўлланилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ножўя таъсири кўп, инфекцияга мойиллик ортади. Мижоз шифокор назоратида бўлиб, дорилар аниқ жадвал бўйича ичилишини таъминланг.

Ч

157. Чайлд–Пью шкаласи

Мазмуни: Жигар циррозининг оғирлигини A, B, C синфларига ажратувчи баҳолаш усули. C синфи энг оғир.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тиббий ҳужжатларда учрайди. Синф юқори бўлса, мижозга кўпроқ парвариш керак, ногиронлик белгилашда ҳисобга олинади.

Ш

158. Шопар чўлтоқлиги

Мазмуни: Оёқ панжаси Шопар бўғими даражасидан (панжанинг ўрта қисми) ампутация қилингандан кейин қолган чўлтоқ.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга махсус протез ёки ортопедик пойабзал керак. Чўлтоқ терисини жароҳат ва яралардан асраш муҳим.

Э

159. Экзоартикуляция

Мазмуни: Қўл ёки оёқни бўғим даражасидан бутунлай олиб ташлаш операцияси (суякни кесмасдан).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижозга махсус протез керак (елка, тизза ёки чаноқ-сон бўғими протези). Реабилитация ва руҳий қўллаб-қувватлаш ҳам лозим.

160. Электромиография

Мазмуни: Мушаклар ва нервларнинг электр фаоллигини текшириш усули. Мушак ва нерв касалликларини фарқлашга ёрдам беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз игна электродлари қўйилиши сабабли бироз безовталик ҳис қилиши мумкин. Қўрқмасликни тушунтиринг. Ногиронлик ҳужжатларида унинг хулосаси бўлиши мумкин.

161. Эндопротезлаш

Мазмуни: Касалланган бўғимни сунъий бўғим (эндопротез) билан алмаштириш операцияси.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Операциядан кейин мижозга реабилитация, қўлтиқ таёқ ёки ходунок керак. Уйдаги тўсиқларни олиб ташлаш ва йиқилишнинг олдини олиш муҳим.

162. Эрготерапия

Мазмуни: Кундалик ҳаёт малакаларини (кийиниш, овқатланиш, ёзиш, ювиниш) тиклашга қаратилган реабилитация усули. Уй шароитини мослаштиришни ҳам ўз ичига олади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Инсульт, жароҳат ва руҳий касалликлардан кейин мустақилликни тиклашда муҳим. Мижозни эрготерапевтга йўналтиринг.

163. Эрта аралашув

Мазмуни: Ривожланишида муаммо бор ёки хавф остидаги кичик ёшдаги болаларга (одатда 0–3 ёш) мутахассислар томонидан эрта ёрдам кўрсатиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қанчалик эрта бошланса, шунчалик самарали. Ривожланишида орқада қолган бола оилаларини эрта аралашув хизматига йўналтиринг.

164. Эрта аралашув хизмати

Мазмуни: Кичик ёшдаги болалар ва уларнинг оилаларига ривожланишни қўллаб-қувватлаш учун мутахассислар (дефектолог, логопед, психолог) томонидан кўрсатиладиган комплекс хизмат.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ота-оналарга бундай хизмат мавжудлигини ва уни қандай олишни тушунтиринг. Оилани ўйин ва машғулотларни уйда ҳам давом эттиришга ўргатиш керак.

165. Эшитишни ривожлантириш

Мазмуни: Заиф эшитувчи ва кохлеар имплантли болаларда эшитишни ва товушни англашни машқ қилдириш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Эшитиш мосламаси ёки имплант қўйилган болага мунтазам машғулот керак. Ота-оналарни уйда ҳам машқлар билан шуғулланишга ўргатинг.

Я

166. Яллиғланиш

Мазмуни: Организмнинг шикастланиш ёки инфекцияга жавоби: қизариш, шиш, ҳароратнинг ортиши ва оғриқ.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Иситма, шиш, қизариш ёки йиринг мижозда яллиғланиш борлигини билдиради; бундай ҳолда шифокорга ўз вақтида йўлланг.

Ў

167. Ўзгалар парваришига муҳтожлик мезони

Мазмуни: Одамнинг ўзгалар парваришига муҳтожлигини белгилашда эътиборга олинадиган белгилар: ўзига хизмат қилиш, ҳаракатланиш, мўлжал олиш, мулоқот ва бошқалар қанчалик бузилганлиги.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз бундай ёрдамга муҳтожми-йўқми, шу мезонлар бўйича баҳоланади. Ижтимоий ходим аниқ мисоллар билан (мижоз нимани қила олмайди) маълумот тайёрлашга ёрдам беради.

168. Ўз-ўзига хизмат қилиш

Мазмуни: Одамнинг овқатланиш, ювиниш, кийиниш, ҳожатхонага бориш каби кундалик эҳтиёжларини ўзи бажара олиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ўз-ўзига хизмат қила олмаса, парваришга муҳтожлик белгиланади. Қисман эплаган ишларини ўзи қилишига имкон беринг, бу унинг мустақиллигини сақлайди.

169. Ўпканинг сунъий нафаси (сунъий вентиляция)

Мазмуни: Ўзи нафас ола олмайдиган одамга аппарат орқали ҳаво бериш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир беморлар касалхонада, баъзан уйда ҳам аппаратга уланган бўлади. Бундай мижознинг оиласи катта ёрдамга муҳтож: аппарат парвариши, электр узилиши бўйича режа ва руҳий қўллаб-қувватлаш.

Қ

170. Қайта кўрик

Мазмуни: Ногиронлик гуруҳининг муддати тугагач ёки ҳолат ўзгарганда ТИЭКдан такрорий ўтиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Муддат тугашини олдиндан эслатиб туринг ва мижозга янгиланган ҳужжатларни тайёрлашга ёрдам беринг, акс ҳолда нафақа тўхтаб қолиши мумкин.

Ҳ

171. Ҳаёт фаолиятининг чекланиши

Мазмуни: Соғлиқ бузилиши натижасида одамнинг ўзига хизмат қилиш, ҳаракатланиш, ўқиш, ишлаш ва мулоқот қилиш қобилиятининг камайиши.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронликни белгилашнинг асосий мезони. Мижоз қайси соҳада чекланишини аниқ тавсифлаш, керакли ёрдам турларини танлашга хизмат қилади.

Лотин ҳарфлилар

172. CD4+ лимфоцитлар

Мазмуни: ОИВ-инфекцияси вируси зарарлайдиган иммунитет ҳужайралари. Уларнинг сони иммунитетнинг қанчалик пасайганини кўрсатади: сони кам бўлса, инфекцияга мойиллик юқори.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: ОИВли мижоз шу таҳлилни мунтазам топшириши керак. Дорилар (антиретровирус терапия) ёрдамида сони ошади. Таҳлиллар ва дори қабулини назорат қилишга ёрдам беринг.

173. GMFCS классификацияси

Мазмуни: Мия фалажи (БЦФ) бор болаларнинг катта ҳаракатларини (ўтириш, юриш) 5 даражага бўлиш тизими: I — деярли мустақил юради; V — ҳаракатланиши учун тўлиқ ёрдам керак.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: БЦФ ҳужжатларида кўп учрайди. Даража боланинг қандай восита (ходунок, кресло-аравача) ва парваришга муҳтожлигини кўрсатади.

174. MMSE (когнитив ҳолатни баҳолаш тести)

Мазмуни: Хотира, диққат, нутқ ва мўлжал олишни текширувчи қисқа тест (30 балл). Балл қанча паст бўлса, ақлий функциялар шунча бузилган.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кексаларда деменцияга шубҳа бўлса, шифокор шу тестдан фойдаланади. Тест ташхис қўймайди, фақат ёрдам беради. Мижозни тест пайти ҳурмат билан тутинг.

175. WHODAS 2.0 (ногиронликни баҳолаш шкаласи)

Мазмуни: Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ишлаб чиққан сўровнома: фикрлаш, ҳаракат, ўзига хизмат, мулоқот, кундалик иш ва жамиятда иштирок соҳаларида қийинчиликларни баҳолайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ногиронлик даражасини ва мижозга қандай ёрдам кераклигини аниқлаш учун ишлатилади. Ижтимоий ходим мижозга саволларни тушунтириб, рост жавоб беришга ёрдам беради.

III. ПРОТЕЗ-ОРТОПЕДИЯ МОСЛАМАЛАРИ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯНИНГ ТЕХНИК ВОСИТАЛАРИ

2024-йил 30-апрелдаги 253-сонли қарорда келтирилган воситалар: нима эканлиги ва нима мақсадда ишлатилиши.

A

1. Аппарат икки изли оёқ учун, тўлиқ пластик технологияда

Мазмуни: Иккала оёққа кийиладиган пластик ортопедик аппарат: бўғимларни ушлаб, тик туриш ва юришга ёрдам беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Фалаж ёки мушак кучсизлигида (БЦФ, полиомиелит оқибати) қўлланади. Болада ўсиш билан ўлчами алмаштирилади; кийиш ва тозалашни оилага ўргатинг.

2. Аппарат икки изли оёқ учун, тўлиқ чарм-шинали

Мазмуни: Иккала оёққа кийиладиган чарм ва металл шиналардан ортопедик аппарат; пластикдан оғирроқ, бўғимларни маълум ҳолатда ушлайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Пластик турига қараганда оғир. Терининг ишқаланиши ва яра бўлмаслигини мунтазам текширинг.

3. Аппарат оёқ учун, тўлиқ пластик технологияда

Мазмуни: Бир оёққа кийиладиган енгил пластик аппарат: кучсиз ёки фалаж оёқда бўғимларни ушлаб, юришни осонлаштиради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Катта ва болалар ўлчамлари бор. Бола ўсганда аппарат мослигини кузатинг; уни тоза сақлаш ва терини текширишни тушунтиринг.

4. Аппарат оёқ учун, тўлиқ чарм-шинали

Мазмуни: Бир оёқ учун чарм-металл шинали аппарат: кучсиз оёқни маълум ҳолатда ушлаб, юришда таянч бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга аппаратни тоза сақлаш ва териси шикастланмаслигини текширишни тушунтиринг. Болаларда ўсиш билан ўлчамини ўзгартириш керак бўлади.

Б

5. Бандаж (бир томонлама чов чурраси учун)

Мазмуни: Чов соҳасига тақиладиган эластик камар: чурра чиқмаслиги учун чурра жойини ташқаридан босиб ушлайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бандаж чурранинг ўзини даволамайди. Оғир юк кўтармаслик ва чурра сиқилганда (кучли оғриқ, қайт) 103 га қўнғироқ қилиш кераклигини тушунтиринг.

6. Бандаж (икки томонлама чов чурраси учун)

Мазмуни: Човнинг ҳар икки томонини қамраб оладиган эластик камар: иккала томондаги чурраларни ушлаб туради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бир томонлама бандажга ўхшаш тавсияларга амал қилинади. Оилага уни тўғри тақиш (ётган ҳолатда, чурра жойига қўйилгандан кейин) тушунтирилади.

7. Бандаж (қорин девори чурраси ва буйрак тушганлиги учун)

Мазмуни: Қорин соҳасига тақиладиган кенг эластик камар. Қорин олд девори чурраси чиқмаслиги ва тушган буйракни ўз жойида ушлаб туриш учун мўлжалланган.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга оғир юк кўтармаслик ва бандажни эрталаб ётган ҳолатда тақишни тушунтиринг. Тери қизариши ва ишқаланишини текшириб боринг.

8. Билак протези (пластик технологияда)

Мазмуни: Билак даражасида ампутациядан кейин қўйиладиган пластик сунъий қўл: нарса ушлаш ва кундалик ишларга ёрдам беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Протез чўлтоққа индивидуал ўлчанади. Мижозни протезни тақиш ва ундан фойдаланишга ўргатиш (реабилитация) муҳим. Чўлтоқ терисини тоза сақлашни тушунтиринг.

9. Бионик бармоқлар (4–5 бармоқ ампутацияси учун)

Мазмуни: Мушаклардаги электр сигналлар билан ҳаракатланадиган электрон сунъий бармоқлар: 4–5 бармоқ йўқолганда ушлаш қобилиятини қисман тиклайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу энг замонавий воситалардан бири. Мижозга батареяни зарядлаш ва сувдан асрашни тушунтиринг, ишлатишга ўргатишда ёрдам беринг.

10. Бионик билак протези (битта ушлаш функцияли)

Мазмуни: Мушак сигналларига жавоб берадиган электрон протез, битта ушлаш ҳаракатини (кафтни очиш-ёпиш) бажаради. Билак ампутациясида қўлланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оддий протездан фарқли, бу протез қўлни фаолроқ қилади. Ишлатиш учун ўқитиш керак. Мижознинг ёши ва ҳаётий эҳтиёжига қараб танланади.

11. Бионик билак протези (4–8 ушлаш функцияли)

Мазмуни: Мураккаб бионик протез: 4–8 хил ушлаш ҳаракатини (чимчилаш, мушт) бажариб, қўл функциясини кўп жиҳатдан тиклайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу энг мураккаб воситалардан. Мижозни ундан фойдаланишга ўргатиш ва меҳнат реабилитациясига йўналтириш мумкин, чунки у ишга қайтишга ёрдам беради.

12. Бионик елка протези (бионик тирсакли)

Мазмуни: Тирсакдан юқори ампутацияда қўйиладиган, электрон тирсак ва кафтли протез: тирсакни букиш ва кафтни очишни тиклайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тирсаги бионик бўлгани сабабли механик тирсакли протезга қараганда қулайроқ. Мижозни яхшилаб ўргатиш керак. Ҳаёт сифатини сезиларли яхшилайди.

13. Бионик елка протези (механик тирсакли)

Мазмуни: Елка соҳаси ампутациясида қўйиладиган протез: тирсаги механик (қўл кучи билан бошқарилади), кафти электрон.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бионик тирсакли турига қараганда содда. Мижознинг эҳтиёжи ва имкониятига қараб танланади. Протезни ишлатишга ўргатиш муҳим.

14. Бионик тирсакдан юқори ампутация қўл протези

Мазмуни: Тирсакдан юқори ампутацияда қўйиладиган электрон протез: тирсак (механик ёки бионик) ва кафт орқали қўл функциясини тиклайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Турлари кўп (бир ёки бир нечта ушлаш, механик ёки бионик тирсак). Тўғри турни танлашда ТИЭК ва протезчи билан ҳамкорлик қилинг.

15. Болалар учун махсус юриш мосламаси (ходунок)

Мазмуни: Болалар учун енгил металл мослама: мувозанати ёки оёқ кучи кам болага тик туриб юришни ўрганишга ёрдам беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болаларда церебрал фалаж ёки бошқа ҳаракат бузилишларида ишлатилади. Ота-оналарга ходункани боланинг бўйига мослаш ва уйда хавфсиз ишлатишни тушунтиринг.

16. Болалар учун функционал кресло-аравача (болалар церебрал фалажи бор болаларга)

Мазмуни: Тана ва бошни ушлаб турадиган мослаштириладиган болалар аравачаси: ўтира олмайдиган болага тўғри ўтиришга ва сколиоздан сақланишга ёрдам беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оддий аравачадан фарқли, бу тананинг ҳолатини тўғрилайди. Бола ўсиши билан мослаштиришни кузатиб боринг.

17. Болдир протези (пластик технологияда)

Мазмуни: Тиззадан пастда ампутацияда болдир ва панжа ўрнини босувчи пластик протез: юришни тиклайди. Панжаси углепластик ёки шарнирли.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Чўлтоққа юмшоқ қоплама (лайнер) қўйиш тавсия қилинади. Протез кийиб юриш машқ талаб қилади. Чўлтоқ терисини тоза сақлашни тушунтиринг.

18. Болдир протези (чарм-шинали)

Мазмуни: Чарм ва металл шиналардан болдир протези: пластикдан оғирроқ, тиззадан пастдаги ампутацияда юришни тиклайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Пластик протез имконияти бўлмаганда ёки вақтинча сифатида ишлатилади. Мижознинг чўлтоғида ишқаланиш ва яралар бўлмаслигини тез-тез текширинг.

19. Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

Мазмуни: Брайл ёзувини ёзиш мосламаси (нуқта босувчи қалам ва тахта ёки ёзув машинкаси): кўзи ожизларга ёзишга имкон беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўзи ожиз болалар ва катталарга мустақил ўқиш ва ёзиш имконини беради. Мижозни тифлопедагог ёрдамида ўқитишга йўналтиринг.

Е

20. Елка бўғимидан экзоартикуляция протези

Мазмуни: Қўл елка бўғимидан бутунлай олиб ташланганда қўйиладиган сунъий қўл. Йўқолган қўлнинг кўриниши ва қисман вазифасини тиклаш учун ишлатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бундай мижозга протезни кийиш ва ундан фойдаланишни ўргатиш (реабилитация) керак.

21. Елка протези (пластик технологияда)

Мазмуни: Қўл елка даражасида кесилганда қўйиладиган пластикдан ясалган протез. Йўқолган қўл қисмини тиклайди ва нарсаларни тутишга ёрдам беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қўл елка даражасида кесилган одамларга қўйилади. Мижоз чўлтоғининг терисини асраши ва протезни тоза сақлаши керак.

К

22. Корсет (бел соҳасига, фиксацияловчи, пластик)

Мазмуни: Белни қаттиқ ушлаб турувчи пластик камар. Умуртқа поғонасининг бел қисмини қимирлатмаслик ва юкламани камайтириш учун ишлатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бел жароҳати, операциядан кейинги ҳолат ёки умуртқа касаллигида берилади. Мижозга уни ҳамиша ва тўғри кийиш кераклигини тушунтиринг; терини ишқаланишдан асранг.

23. Корсет (бошни ушлаб турувчи, пластик)

Мазмуни: Бошни тик ушлаб турадиган пластик мослама. Бош ва бўйин мушаклари кучсиз бўлган беморларга ёрдам беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: БЦФ, мушак дистрофияси ва шунга ўхшаш касалликларда ишлатилади. Мослама боланинг бўйнини ишқаламаслиги ва нафасини қийинлаштирмаслигини кузатинг.

24. Корсет (кўкрак-бел соҳасига, матодан)

Мазмуни: Мато (эластик)дан тикилган, кўкрак ва бел қисмини енгил ушлаб турувчи камар.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Умуртқа поғонаси оғриғида ёки ёмон ўтириш одатида ёрдам беради. Пластик корсетдан енгил ва кундалик кийиш осон, лекин унчалик қаттиқ ушламайди.

25. Корсет (кўкракнинг пастки қисми ва бел соҳасига, коррекцияловчи, пластик)

Мазмуни: Умуртқа қийшайишини (сколиоз, кифоз) тўғрилаш ва ривожланишини тўхтатиш учун ишлатиладиган пластик корсет.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Болалар ва ўсмирларга берилади, ўсиш билан алмаштириб турилади. Болага уни мунтазам кийиш кераклигини тушунтириш ва кийишга уялмасликка ёрдам бериш керак.

26. Кохлеар имплант

Мазмуни: Кохлеар имплантация операциясида қулоқнинг ички қисмига жойланадиган электрон қурилма. Эшитиш нервини қўзғатиб, товушни англашга имкон беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қурилманинг ташқи қисми (нутқ процессори) батареяга ва созлашга муҳтож. Оилага уни сувдан асраш ва доимий сервис хизматидан фойдаланиш кераклигини айтинг.

27. Кресло-аравача, сайр қилишга мўлжалланган

Мазмуни: Кўчада ва узоқ масофага бориш учун мўлжалланган механик ногиронлар аравачаси. Унинг катта ғилдираклари тўсиқлардан ўтишга ёрдам беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Юра олмайдиган мижозга мустақил ёки бошқа одам ёрдамида кўчага чиқишга имкон беради. Уйдан чиқиш йўлидаги тўсиқларни (зинапоя) ва пандусни ҳисобга олинг.

28. Кресло-аравача, санитария ускуналари билан жиҳозланган (душ, ҳаммом, ҳожатхона учун)

Мазмуни: Ичига ҳожатхона идиши ўрнатилган ва сувдан ўтказмайдиган махсус аравача. Ҳожатхона ва ҳаммомда фойдаланиш мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ётоқ ёки юра олмайдиган беморнинг гигиенасини осонлаштиради ва парвариш қилувчига енгиллик беради. Мижознинг қадр-қиммати сақланишига ёрдам беради.

29. Кресло-аравача, хонага мўлжалланган (механик)

Мазмуни: Уй ичида ҳаракатланиш учун мўлжалланган, ихчам ва енгил механик аравача.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тор эшиклар ва хоналарда фойдаланишга қулай. Кўчага чиқиш учун бошқа тур аравача керак бўлиши мумкин.

30. Кресло-аравача, электр юритмали (болалар ва ўсмирлар учун)

Мазмуни: Болалар ва ўсмирлар учун электр моторли кресло-аравача: оёқлари шикастланган ёки БЦФ бор болага мустақил ҳаракатланиш имконини беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қўли билан аравачани ҳайдай олмайдиган болага қулай; бошқарув тури боланинг имкониятига қараб танланади. Бола ўсиши билан мослаштиришни кузатиб боринг.

31. Кресло-аравача, электр юритмали (универсал)

Мазмуни: Мотор билан ҳаракатланадиган, жойстик орқали бошқариладиган аравача. Қўл кучи етарли бўлмаган одамлар учун.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мустақил ҳаракат учун катта имконият беради. Зарядлаш ва хавфсиз ҳайдашни ўргатиш керак.

32. Кресло-аравача, қўлда бошқариладиган (вело)

Мазмуни: Қўл билан айлантириладиган педал (велосипед тамойилида) орқали ҳаракатланадиган аравача, эркин ҳаракат ва қўл мушакларини машқ қилдиришга ёрдам беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оёқлари ишламайдиган, лекин қўллари кучли мижозларга мос. Кўчада тезроқ ва узоқроқ юриш имконини беради.

33. Кўзи ожизлар ҳассаси

Мазмуни: Кўзи ожизлар йўлни текшириб боришда ишлатадиган узун ва оқ рангли ҳасса.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўзи ожиз мижозга ҳассадан фойдаланишни ва кўчада мўлжал олишни тифлопедагог ёрдамида ўргатиш керак. Ҳассанинг оқ ранги бошқаларга мижознинг кўзи ожиз эканини билдиради.

34. Кўз олмаси протези (косметик)

Мазмуни: Кўз олмаси олиб ташлангандан кейин қўйиладиган сунъий кўз. Кўришни тикламайди, фақат табиий кўринишни сақлайди.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ташқи кўринишидан уялмаслиги учун руҳий қўллаб-қувватлаш муҳим. Протезни тоза сақлаш ва шифокор кўрсатмасига амал қилиш керак.

35. Кўкрак бези протези

Мазмуни: Операция билан бир ёки иккала кўкрак бези олиб ташланганда ташқаридан кийиладиган сунъий кўкрак (одатда силикондан).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Аёлга ташқи кўриниш ва ўзига ишончни қайтаради. Кўкрак бези саратонидан кейин ишлатилади. Муомалада ҳурмат ва меҳр билан бўлинг.

36. Кўтарувчи кресло-аравача (трансфер)

Мазмуни: Беморни ўриндан кресло-аравачага ёки ҳожатхонага кўчиришга ёрдам берадиган кўтариш мосламаси ёки махсус аравача.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир ёки ҳаракатсиз беморни парвариш қилувчининг белини сақлайди ва бемор учун хавфсиз. Мижозни кўчиришда жароҳат хавфини камайтиради.

М

37. Махсус матрас

Мазмуни: Узоқ ётган беморлар учун мўлжалланган матрас (одатда ҳаво билан тўлдириладиган, секциялари навбат билан шишиб-пасайиб туради). Тананинг бир жойига босим тушишини камайтиради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ётоқ яраларнинг олдини олиш ёки даволашда жуда муҳим. Мижознинг ҳолатини ўзгартириб туришни ҳам унутманг.

38. Модулли сон протези (пневматик ва механик тугунли)

Мазмуни: Сон соҳасидан оёқ кесилган одам учун сунъий оёқ. Бўғим (тизза) қисмлари ҳаво босими (пневматик) ёки механик тизим билан ишлайди ва қисмларни алмаштириш мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга юришни тиклаш имконини беради. Протезни тўғри кийиш ва ундан фойдаланишни ўргатиш керак; чўлтоқ терисини парваришланг.

39. Модулли чаноқ-сон бўғими экзоартикуляцияси протези

Мазмуни: Оёқ чаноқ-сон бўғимидан бутунлай олиб ташланганда қўйиладиган сунъий оёқ. Қисмлари алоҳида ва алмаштирилиши мумкин.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу энг мураккаб оёқ протезларидан бири. Мижоз ундан фойдаланишни ўрганиши учун узоқ реабилитация керак бўлади. Руҳий қўллаб-қувватлаш муҳим.

40. Мураккаб ортопедик пойабзал (жуфт, мавсумий; мўйнали турлари билан)

Мазмуни: Оёқ деформацияси, қисқалиги ёки оғир касаллиги бор одамлар учун алоҳида ўлчов бўйича тайёрланадиган махсус пойабзал.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оёқни тўғри ушлаб туради, юришни осонлаштиради ва яра пайдо бўлишининг олдини олади. Диабет оёғи, маймоқлик, БЦФ ва полиомиелит оқибатларида ишлатилади.

Н

41. Нажас қабул қилгич

Мазмуни: Колостома (қорин деворидаги ичак тешиги)дан чиқадиган нажасни йиғиш учун ёпиштириладиган махсус халта.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Колостомаси бор мижоз учун ҳаётий зарур восита. Халтани тўғри алмаштириш, терини парваришлаш ва уялишни енгишда ёрдам беринг.

42. Ногиронлар аравачаси

Мазмуни: Юра олмайдиган одам ўтириб ҳаракатланиши учун мўлжалланган аравача (қўлда ёки электр юритмали).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга мустақил ҳаракатланиш имконини беради. Уй ва атроф-муҳитдаги тўсиқларни (зинапоя, тор эшик) пандус ва кенг эшик билан ҳал этиш керак.

О

43. Овозли глюкометр

Мазмуни: Қондаги шакар миқдорини ўлчайдиган ва натижани овоз билан айтадиган асбоб.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Диабети бор ва кўзи ожиз ёки кўриши пасайган мижозлар учун мўлжалланган. Шакарни мустақил назорат қилишга имкон беради. Асбобдан фойдаланишни ўргатинг.

44. Овозли термометр

Мазмуни: Тана ҳароратини ўлчаб, натижани овоз билан айтадиган асбоб.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўзи ожиз мижозга ҳароратни мустақил ўлчашга ёрдам беради. Касаллик белгиларини ўз вақтида сезиш учун фойдали.

45. Овозли тонометр

Мазмуни: Қон босимини ўлчаб, натижани овоз билан айтадиган аппарат.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Қон босими юқори бўлган кўзи ожиз ёки кўриши паст мижозлар учун. Босимни назорат қилиб, инсульт ва инфаркт хавфини камайтиради.

46. Ортопедик башмачок

Мазмуни: Болаларнинг оёғини тўғри ҳолатда ушлаб турувчи махсус ортопедик пойабзал.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Маймоқлик, ясси оёқ ва оёқ деформациясида болаларга тавсия этилади. Ота-оналарга кундалик кийишнинг аҳамиятини тушунтиринг.

П

47. Пешоб қабул қилгич

Мазмуни: Сийдикни йиғиш учун ишлатиладиган халта ёки идиш. Катетер ёки махсус мослама билан уланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Сийдигини тута олмайдиган ёки катетерли мижозлар учун. Гигиена ва халтани вақтида бўшатиш инфекциянинг олдини олади. Мижознинг уялишини ҳисобга олинг.

48. Протез учун пойабзал

Мазмуни: Сунъий оёқ (протез) билан кийиш учун мўлжалланган махсус пойабзал.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Протезнинг тўғри ишлаши ва мувозанат учун муҳим. Оддий пойабзал ўрнига протезга мос пойабзал кийиш керак.

Р

49. Рақамли эшитиш мосламаси

Мазмуни: Қулоққа тақиладиган электрон асбоб: товушни кучайтиради ва эшитишни яхшилайди. Одамнинг эшитиш даражасига мослаб созланади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Заиф эшитувчи мижозларга мулоқот қилишда катта ёрдам беради. Мижозга уни доимий тақиш, батареяни алмаштириш ва тоза сақлашни ўргатинг. Мослама тўлиқ кар одамга ёрдам бермаслиги мумкин.

50. Рельефли-нуқтали ёзув мосламаси

Мазмуни: Брайл алифбосида (бўртма нуқталар) ёзиш учун мўлжалланган асбоб ёки қурилма.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кўзи ожиз болаларнинг ўқиши ва ёзишини таъминлайди. Кўзи ожиз мижозларга Брайл ёзувини ўрганишга ёрдам беринг.

С

51. Сон протези (чарм-шинали)

Мазмуни: Сон соҳасидан оёқ кесилган одам учун сунъий оёқ. Чўлтоқ учун чарм гильза ва металл шиналардан тайёрланади, тизза бўғими механик.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга юришни тиклаш имконини беради. Протездан фойдаланишни ўргатиш ва чўлтоқ терисини парваришлашга ёрдам беринг.

52. Сунъий ритм юритувчи (кардиостимулятор)

Мазмуни: Юрак уришини тартибга солувчи ва секин ураётган юракни тезлатувчи кичик электрон асбоб. Кўкрак териси остига ўрнатилади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Юрак ритми бузилган мижозлар учун ҳаётий восита. Мижоз кучли магнит майдонидан эҳтиёт бўлиши ва мунтазам кардиолог кўригидан ўтиши керак.

Т

53. Тиббий тувак

Мазмуни: Ётоқ ёки юра олмайдиган беморнинг ётган жойида ҳожатини чиқариши учун мўлжалланган идиш.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижознинг қадр-қимматини сақлаб, гигиена ва парваришни осонлаштиради. Уни ҳар сафар тоза ювиб, дезинфекция қилиб туриш лозим.

54. Тизза бўғими экзоартикуляцияси протези (пластик ва чарм-шинали)

Мазмуни: Оёқ тизза бўғими даражасида олиб ташланган одамлар учун сунъий оёқ. Пластик ёки чарм ва шиналардан ясалади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижозга таянч ва юришни тиклайди. Мижоз протезни тўғри кийишни ўрганиши ва чўлтоғини парваришлаши керак.

55. Тирсакли қўлтиқ таёқ

Мазмуни: Тирсак ва билакка таянадиган таёқ. Юришда енгил таянч беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оёқ жароҳатидан кейин ёки мувозанат заиф бўлса ишлатилади. Мижозга баландлигини ростлаш ва тўғри ишлатишни ўргатинг, ёмғирли ёки сирпанчиқ жойда эҳтиёт бўлишини айтинг.

56. Тифлотехника воситалари (кўзи ожизлар учун)

Мазмуни: Кўзи ожиз ва заиф кўрувчиларга мўлжалланган махсус мосламалар: Брайл ёзув асбоблари, овозли соат, овозли ўлчов асбоблари, лупа, ҳасса.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Бу воситалар кўриши бузилган мижозга мустақил яшаш ва ўқиш имконини беради. Мижознинг эҳтиёжига мос воситани аниқлашда ёрдам беринг.

57. Тутор (билак-кафт бўғимига)

Мазмуни: Қўл билаги бўғимини қотириб, ҳаракатини чеклайдиган қаттиқ боғлам-мослама (ортез).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Жароҳат, операциядан кейин, нерв фалажи ёки яллиғланишда бўғимни тинч сақлаш учун. Мижозга қачон ва қанча вақт кийишни шифокор тушунтиради.

58. Тутор (болдир-ошиқ бўғимига)

Мазмуни: Болдир ва оёқ панжаси орасидаги бўғимни ушлаб турувчи қаттиқ ортез, оёқ панжасининг тушиб қолишининг олдини олади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оёқ панжаси фалажи, инсульт ва БЦФда юришни осонлаштиради. Пойабзал билан бирга кийилади. Терининг ишқаланишини кузатинг.

59. Тутор (оёқ учун, тўлиқ пластик технологияда)

Мазмуни: Бутун оёқни ушлаб турувчи пластикдан тайёрланган ортез. Оёқ фалаж ёки жуда кучсиз бўлганда таянч беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оёқ мушаклари заиф бўлган болалар ва катталарнинг тик туриши ва юришига ёрдам беради. Тери ва ўсиш назоратини унутманг.

60. Тутор (тизза бўғимига, сон ва болдир соҳасини қамраб олувчи)

Мазмуни: Тизза бўғимини қотириб ёки чеклаб, сон ва болдирни ўраб турувчи ортез.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тизза жароҳати, операциядан кейин, бўшашган бойлам ва фалажда қўлланилади. Тўғри кийилишини ва терига зарар етказмаслигини кузатинг.

61. Тутор (тирсак бўғимига)

Мазмуни: Тирсак бўғимини ушлаб турувчи ёки чекловчи ортез.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Тирсак жароҳатидан ёки операциядан кейин қўлни тинч сақлаш учун. Қўлнинг бошқа бўғимлари ва бармоқлари ҳаракатини сақланг.

Ф

62. Функционал кровать

Мазмуни: Баландлиги ва бош-оёқ қисмларини ростлаш мумкин бўлган махсус карават. Ёнбош панжаралари бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ётоқ беморни парвариш қилишни осонлаштиради, ётоқ яралари хавфини камайтиради. Овқатлантириш пайти беморни ярим ўтирган ҳолда кўтариш мумкин. Мижозни йиқилиб тушишдан ҳимоя қилади.

Ч

63. Чаноқ-сон бўғими экзоартикуляцияси протези (чарм-шинали)

Мазмуни: Оёқ чаноқ-сон бўғимидан бутунлай олиб ташланганда қўйиладиган сунъий оёқ. Чарм ва шиналардан ясалган.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мураккаб протез, мижоз унга ўрганиши учун узоқ реабилитация керак. Руҳий қўллаб-қувватлаш муҳим.

Э

64. Электрон скутер

Мазмуни: Мотор билан юрадиган, рулли ва ўриндиқли транспорт воситаси. Ногиронлиги бор одамнинг узоқ масофага юришини осонлаштиради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Юришга қийналувчи ва қўллари бошқарув учун кучли мижозлар учун. Хавфсиз ҳайдашни ўргатинг ва пандус, тўсиқларни ҳисобга олинг.

65. Эндопротез (сунъий бўғим)

Мазмуни: Касалланган бўғим ўрнига операция билан ўрнатилган металл ёки пластмассадан ясалган сунъий бўғим.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғриқни камайтириб, юришни тиклайди. Операциядан кейин реабилитация ва эҳтиёт бўлиш (оғир юк, чўққайиш) керак.

66. Эшитиш аппарати (товуш кучайтиргич)

Мазмуни: Қулоқ орқасига ёки қулоқ ичига тақиладиган ва товушни кучайтирадиган асбоб.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Заиф эшитувчи кексалар ва болаларга мулоқотда ёрдам беради. Мижозга батареяни алмаштириш, тоза сақлаш ва доимо тақишни ўргатинг.

Ю

67. Юриш мосламаси (ходунок)

Мазмуни: Тўрт оёқли ёки рамали металл мослама, олдинга қўйиб унга таяниб юрилади. Мувозанатни сақлашга ёрдам беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Кексалар, инсультдан кейинги ва мувозанат заиф мижозларда йиқилишни камайтиради. Баландлигини тўғри ростлаш ва ундан қандай фойдаланишни ўргатинг.

68. Юриш мосламаси (ходунок-роллатор)

Мазмуни: Ғилдиракли ходунок, суриб юрилади, тормоз ва баъзан ўриндиқли бўлади.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Ходунокни кўтаришга қийналувчи, лекин юра оладиган мижозларга қулай. Тормозларни ишлатишни ва тошлоқ ёки нотекис йўлда эҳтиёт бўлишни ўргатинг.

Ў

69. Ўпка сунъий нафас аппарати

Мазмуни: Ўзи нафас ола олмайдиган одамга ҳаво ҳайдаб берувчи аппарат (вентилятор).

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оғир нафас етишмовчилиги ва мушак касалликларида уйда ҳам қўлланилади. Электр узилишига қарши захира режаси ва оилани аппарат билан ишлашга ўргатиш зарур.

Қ

70. Қўл (кафт) протези (пластик технологияда)

Мазмуни: Қўл кафти ёки бармоқлар йўқ бўлганда қўйиладиган пластикдан ясалган сунъий қўл. Кўринишни тиклайди ва нарсаларни тутишга ёрдам беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мижоз ўзини ишончли ҳис қилади ва кундалик ишларни осонроқ бажаради. Протезни тўғри ишлатиш ва чўлтоқ терисини парваришлашни ўргатинг.

71. Қўлтиқ таёқ (жуфт)

Мазмуни: Қўлтиқ остига таяниб юриладиган икки таёқ. Оёққа тушадиган юкни камайтиради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Оёқ синиши, операциядан кейин ёки фалажда ишлатилади. Оғирлик қўлтиққа эмас, кафтга тушиши керак; нерв босилмаслиги учун тўғри ўлчам муҳим.

Ҳ

72. Ҳасса (тўрт оёқли)

Мазмуни: Тагида тўртта таянч оёқчаси бор ҳасса, одатдагидан барқарор туради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Мувозанати заиф кексалар ва инсультдан кейинги мижозларга ёрдам беради. Баландлигини қўл билагига мослаб ростланг.

Лотин ҳарфлилар

73. FM-тизими (эшитиш қийинлиги бўлганлар учун)

Мазмуни: Радиотўлқин орқали ишлайдиган қурилма: гапирувчининг микрофони овозни бевосита эшитиш мосламасига ёки кохлеар имплантга узатади. Шовқинли жойда (синфда) аниқроқ эшитишга имкон беради.

Ижтимоий ходим учун аҳамияти: Эшитиш мосламаси ёки имплантли болалар мактабда яхшироқ ўқиши учун керак. Ўқитувчиларга микрофонни қандай ишлатишни тушунтиринг.

ФОЙДАЛАНИЛГАН МАНБАЛАР

Қўлланма қуйидаги ҳужжатлар ва манбалар асосида тузилди.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 17 февралдаги ПФ-74-сон Фармони «Ногиронлиги бўлган шахсларни ҳамда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида».
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 12 октябрдаги 638-сон қарори «Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим беришга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида».
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8 февралдаги 62-сон қарори «Тиббий-ижтимоий экспертиза хизмати ташкилий тузилмасини ва фаолиятини ташкил этишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида».
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 25 январдаги 46-сон қарори «Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларнинг таълим олишларини ташкил этиш ва уларни реабилитация қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида».
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30 апрелдаги 253-сон қарори «Муҳтож шахсларни протез-ортопедия мосламалари ва реабилитация қилишнинг техник воситалари билан таъминлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида».
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 27 февралдаги 126-сон қарори «Ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида».
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 28 февралдаги 132-сон қарори «Транспорт хизматларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш орқали кўриш ва ҳаракатланиш билан боғлиқ касалликларга чалинган алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар учун таълим олиш шароитларини яхшилаш тўғрисида».
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 1 июлдаги 405-сон қарори «Ногиронлиги бўлган шахсларнинг бандлигини қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида».
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 21 майдаги 271-сон қарори «Руҳий ҳолати бузилган ногиронлиги бўлган шахслар учун интернат муассасаларини такомиллаштириш ва янги ижтимоий хизматларни ташкил этишга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида».

Бошқа манбалар

10. Касалликларнинг халқаро таснифи, 10-қайта кўриб чиқиш (МКБ-10). Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти.

Тиббий билим ва ижтимоий меҳр — инсон қадри йўлида

Чирчиқ шаҳар «Инсон» ижтимоий хизматлар маркази

Чирчиқ - 2026-йил